

Bunga Rampai

PENDIDIKAN KEBIDANAN BERBASIS KONTINUITAS ASUHAN

Kurikulum, Praktik Klinik, dan Kompetensi Bidan Masa Kini



Yan Deivita • Giari Rahmilasari • Eka Rati Astuti
Nurul Komariah • Yeni Fitriarningsih • Hasnawati

Editor : Ade Zakiya Tasman Munaf

BUNGA RAMPAI

PENDIDIKAN KEBIDANAN BERBASIS KONTINUITAS ASUHAN: KURIKULUM, PRAKTIK KLINIK, DAN KOMPETENSI BIDAN MASA KINI

Penulis:

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.

Giari Rahmilasari, S.ST., M.Keb., Bdn.

Eka Rati Astuti, SST., M.Keb.

Bdn. Nurul Komariah, SST., S.Stat., M.Keb.

Dr. Yeni Fitrianiingsih, SST., M.Kes.

Hasnawati, SST., M.Kes.

Editor:

Ade Zakiya Tasman Munaf, S.T.Keb., M.Keb.



Bunga Rampai Pendidikan Kebidanan Berbasis Kontinuitas Asuhan: Kurikulum, Praktik Klinik, dan Kompetensi Bidan Masa Kini

Penulis:

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.
Giari Rahmilasari, S.ST., M.Keb., Bdn.
Eka Rati Astuti, SST., M.Keb.
Bdn. Nurul Komariah, SST., S.Stat., M.Keb.
Dr. Yeni Fitrianiingsih, SST., M.Kes.
Hasnawati, SST., M.Kes.

Editor:

Ade Zakiya Tasman Munaf, S.T.Keb., M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-63-9

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku Bunga Rampai Pendidikan Kebidanan Berbasis Kontinuitas Asuhan: Kurikulum, Praktik Klinik, dan Kompetensi Bidan Masa Kini disusun untuk merespons kebutuhan penguatan mutu pendidikan kebidanan di tengah perubahan layanan kesehatan, tuntutan keselamatan pasien, serta perkembangan teknologi dan regulasi profesi. Pendidikan bidan dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang terampil secara klinis, tetapi juga mampu berpikir kritis, beretika, komunikatif, dan konsisten memberikan asuhan berkesinambungan pada perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Karena itu, buku ini menghadirkan perspektif kurikulum dan praktik pembelajaran yang menekankan continuity of care sebagai fondasi pembentukan kompetensi bidan masa kini.

Susunan bab dalam buku ini mengikuti alur dari transformasi kurikulum hingga penguatan kompetensi praktik. Chapter 1 membahas transformasi kurikulum D3–D4–Profesi Bidan berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan Standar Kompetensi Nasional Bidan, termasuk pemetaan capaian pembelajaran lulusan, integrasi standar kompetensi, serta implementasi pembelajaran dan penilaian. Chapter 2 menguraikan model Continuity of Care (CoC) dalam pendidikan kebidanan—mulai perencanaan, implementasi, hingga evaluasi—sebagai kerangka pembelajaran klinik yang menyatu dengan kebutuhan layanan. Chapter 3 melengkapi pendekatan tersebut melalui pembahasan simulasi kebidanan, meliputi OSCE, high-fidelity simulation, dan standardized patient, termasuk strategi integrasi simulasi dalam kurikulum, evaluasi, serta aspek etika dan keselamatan.

Penguatan kompetensi bidan sebagai praktisi profesional dibahas pada bab-bab berikutnya. Chapter 4 menekankan komunikasi terapeutik dan shared decision making untuk memastikan asuhan yang berpusat pada klien dan menghormati otonomi perempuan. Chapter 5 menguraikan implementasi evidence-based midwifery dalam pembelajaran teori dan praktik, termasuk refleksi berbasis teknologi digital serta sinergi interprofessional collaboration. Sebagai penutup, Chapter 6 membahas etika profesi bidan dan tantangan praktik kebidanan di era digital, seperti kerahasiaan data, telehealth, dan profesionalisme di media sosial. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis dan pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pendidik, mahasiswa, preceptor klinik, dan praktisi sebagai rujukan untuk memperkuat kurikulum, pembelajaran klinik, serta kompetensi bidan yang adaptif dan berintegritas.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 TRANSFORMASI KURIKULUM D3 – D4 – PROFESI BIDAN BERBASIS OBE DAN STANDAR KOMPETENSI NASIONAL BIDAN 1

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Outcome-Based Education (OBE)	2
C. Standar Kompetensi Nasional Bidan.....	3
D. Standar Kompetensi dalam Pendidikan Kebidanan dan OBE.....	4
E. Urgensi Transformasi Kurikulum Pendidikan Bidan	5
F. Pemetaan Standar Kompetensi Nasional Bidan terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	6
G. Kurikulum D3 Bidan Berbasis OBE	6
H. Kurikulum D4 Bidan Berbasis OBE	7
I. Kurikulum Profesi Bidan Berbasis OBE	7
J. Integrasi Standar Kompetensi Bidan dalam Kurikulum OBE.....	8
K. Implementasi OBE dalam Pembelajaran dan Penilaian.....	8
L. Simpulan.....	9
M. Referensi.....	9
N. Glosarium.....	10

CHAPTER 2 MODEL CONTINUITY OF CARE (CoC) DALAM PENDIDIKAN KEBIDANAN: PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EVALUASI 11

Giari Rahmilasari	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Perencanaan.....	13
C. Implementasi	16
D. Evaluasi	20
E. Simpulan.....	22
F. Referensi.....	23
G. Glosarium.....	25

CHAPTER 3 SIMULASI KEBIDANAN: OSCE, HIGH-FIDELITY SIMULATION, DAN STANDARDIZED PATIENT.....27

Eka Rati Astuti, SST., M.Keb.....	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Landasan Teoretis Simulasi dalam Pendidikan Kebidanan	27
C. <i>Objective Structured Clinical Examination</i> (OSCE)	30
D. <i>High-Fidelity Simulation</i>	34
E. <i>Standardized Patient</i>	38
F. Integrasi Simulasi dalam Kurikulum Kebidanan.....	39
G. Evaluasi Pembelajaran Berbasis Simulasi.....	40
H. Tantangan dan Strategi Implementasi Simulasi Kebidanan	41
I. Etika dan Keselamatan dalam Simulasi Kebidanan.....	42
J. Penutup	43
K. Referensi.....	43

CHAPTER 4 PENGUATAN KOMPETENSI BIDAN DALAM KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN SHARED DECISION MAKING47

Bdn. Nurul Komariah, SST., S.Stat., M.Keb.	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Konsep Dasar Komunikasi dalam Kebidanan	48
C. Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Kebidanan.....	50
D. Kompetensi Bidan dalam Komunikasi Terapeutik.....	52
E. Konsep Shared Decision Making (Pengambilan Keputusan Bersama).....	54
F. Penerapan Shared Decision Making (SDM) dalam Asuhan Kebidanan	56
G. Integrasi Komunikasi Terapeutik dan Shared Decision Making.....	58
H. Strategi Penguatan Kompetensi Bidan	60
I. Penutup	63
J. Referensi.....	64
K. Glosarium.....	65

CHAPTER 5 IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED MIDWIFERY DALAM PEMBELAJARAN TEORI DAN PRAKTIK67

Dr. Yeni Fitrianiingsih, SST., M.Kes.....	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Dekonstruksi Tradisi Klinis melalui EBM dalam Kurikulum Berbasis Continuity of Care	68
C. Refleksi Praktis Berbasis Teknologi Digital dalam Pendidikan Kesehatan	71

D. Sinergi Interprofessional Collaboration (IPC) dalam Praktik dan Pendidikan.....	73
E. Simpulan.....	74
F. Referensi.....	75

CHAPTER 6 ETIKA PROFESI BIDAN DAN TANTANGAN PRAKTIK KEBIDANAN ERA DIGITAL77

Hasnawati SST., M.Kes.	77
A. Pendahuluan.....	77
B. Etika Kerahasiaan dan Perlindungan Data Klien Dalam Praktik Kebidanan Era Digital.....	78
C. Dilema Etis dan Tanggung Jawab Profesional Bidan Dalam <i>Telehealth</i> dan Telekonsultasi.....	81
D. Media Sosial, Informasi Digital, dan Profesionalisme Bidan.....	83
E. Simpulan.....	85
F. Referensi.....	86
G. Glosarium.....	89

PROFIL PENULIS91

CHAPTER 1

TRANSFORMASI KURIKULUM D3 – D4 – PROFESI BIDAN BERBASIS OBE DAN STANDAR KOMPETENSI NASIONAL BIDAN

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Transformasi pendidikan kebidanan merupakan suatu keniscayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta tuntutan pelayanan kebidanan yang semakin kompleks. Pendidikan bidan tidak lagi berorientasi pada penguasaan materi semata (content-based), melainkan pada ketercapaian kompetensi lulusan yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) (Ige et al., 2024).

Pendekatan OBE sejalan dengan kebijakan pendidikan tinggi nasional yang menekankan capaian pembelajaran lulusan sebagai tolok ukur mutu pendidikan, serta selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025). Dalam konteks pendidikan kebidanan, OBE menjadi pendekatan strategis untuk menjamin lulusan memiliki kompetensi klinik, profesionalisme, dan tanggung jawab etik sesuai Standar Kompetensi Bidan Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Di Indonesia, transformasi kurikulum pendidikan bidan dari jenjang Diploma III (D3), Diploma IV (D4), hingga Pendidikan Profesi Bidan diarahkan untuk menghasilkan bidan yang kompeten, beretika, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan kebidanan komprehensif berbasis bukti (evidence-based practice). Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE.

Bab ini membahas secara komprehensif konsep OBE, urgensi transformasi kurikulum pendidikan bidan, karakteristik kurikulum D3, D4, dan Profesi Bidan berbasis OBE, integrasi Standar Kompetensi Bidan, serta implikasi implementasinya dalam pembelajaran, penilaian, dan evaluasi kurikulum.

B. Konsep Outcome-Based Education (OBE)

Outcome-Based Education (OBE) merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil akhir pembelajaran (learning outcomes) yang harus dicapai oleh lulusan setelah menyelesaikan suatu program Pendidikan. Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan berbasis kompetensi modern saat ini. Dalam OBE, seluruh komponen kurikulum, yang dimulai dari perancangan, pelaksanaan pembelajaran, metode evaluasi hingga penjaminan mutu, dirancang secara terintegrasi untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan yang telah ditentukan (Embo et al., 2025).

Dalam konteks pendidikan tinggi, OBE didefinisikan sebagai suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang secara sistematis diarahkan untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan (Kemendikbudristek, 2023). Pendekatan ini menuntut adanya keselarasan (*constructive alignment*) antara tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode penilaian (Biggs & Tang, 2011).

OBE menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran (*student-centered learning*) dan mendorong penguasaan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), serta sikap profesional (*attitude*) secara holistic dan berkesinambungan. Dosen berperan sebagai fasilitator yang merancang pengalaman belajar bermakna agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang ditetapkan secara optimal. Dalam pendidikan kebidanan, pendekatan ini relevan karena praktik kebidanan menuntut pengambilan keputusan klinik berbasis bukti, komunikasi efektif, dan praktik yang aman serta beretika serta menuntut tanggung jawab etis dan hukum (Jones et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran diukur berdasarkan capaian kompetensi, bukan sekadar penyelesaian materi atau jam tatap muka.

OBE memungkinkan kurikulum dirancang secara sistematis untuk menjamin lulusan memiliki kesiapan praktik profesional sesuai standar kompetensi nasional dan internasional. Prinsip utama OBE meliputi kejelasan capaian pembelajaran, perancangan kurikulum secara *backward design*, keselarasan (*alignment*) antara capaian pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian, serta perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dengan demikian, OBE menjadi pendekatan strategis dalam menjamin mutu lulusan pendidikan bidan. Hal ini dikarenakan OBE tidak hanya menjadi pendekatan pedagogik, tetapi juga kerangka strategis dalam penjaminan mutu pendidikan kebidanan.

C. Standar Kompetensi Nasional Bidan

Standar kompetensi nasional bidan merupakan kriteria minimum kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang bidan agar dapat memberikan pelayanan kebidanan secara profesional, aman, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Standar ini menjadi acuan utama dalam penyusunan kurikulum pendidikan bidan, penilaian pembelajaran, serta uji kompetensi nasional dan praktik profesional di Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Standar kompetensi nasional bidan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Presiden terkait tenaga kesehatan, serta ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan. Standar ini menyetarakan level kompetensi bagi praktisi bidan di seluruh wilayah Indonesia, memperkuat integrasi nasional dalam praktik kebidanan, dan mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama penetapan standar kompetensi nasional bidan adalah:

1. Menjamin mutu lulusan pendidikan bidan agar memiliki keterampilan praktik sesuai standar profesi.
2. Memetakan kompetensi minimal yang wajib dipenuhi oleh bidan di seluruh layanan kesehatan.
3. Menjadi acuan utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan bidan di berbagai jenjang (D3, D4, Profesi).
4. Mendukung perlindungan masyarakat dengan memastikan praktik kebidanan dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan berlisensi.

Standar kompetensi nasional bidan mencakup beberapa domain kompetensi penting yang harus dimiliki oleh bidan, antara lain:

1. Etik Legal dan Keselamatan Klien

Bidan harus mampu menunjukkan perilaku profesional yang mencerminkan integritas, menghormati hak klien, menjaga kerahasiaan informasi kesehatan, serta menjamin keselamatan pasien dalam praktik kebidanan.

2. Komunikasi Efektif

Kompetensi dalam komunikasi dibutuhkan untuk menjalin hubungan baik dengan klien, keluarga, dan tim kesehatan, serta menyampaikan informasi kesehatan secara jelas dan berbasis bukti.

3. Landasan Ilmiah Praktik Kebidanan

Bidan harus memiliki pengetahuan ilmiah yang kuat berkaitan dengan fisiologi reproduksi, obstetri, dan kesehatan masyarakat, sehingga dapat menerapkan praktik kebidanan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

4. Keterampilan Klinis dalam Praktik Kebidanan

Kompetensi klinis mencakup kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif pada masa prenatal, persalinan normal, nifas, neonatal, serta deteksi dini komplikasi dan rujukan tepat waktu.

5. Promosi Kesehatan dan Konseling

Bidan wajib mampu merancang dan melaksanakan strategi promosi kesehatan, edukasi, serta konseling kepada klien dan komunitas untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

6. Pengembangan Diri dan Profesionalisme

Kompetensi ini menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, refleksi profesional, serta peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

7. Manajemen dan Kepemimpinan

Bidan harus dapat mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien, bekerja sama dalam tim kesehatan, serta memimpin upaya peningkatan kualitas pelayanan kebidanan di fasilitas layanan kesehatan primer maupun rujukan.

D. Standar Kompetensi dalam Pendidikan Kebidanan dan OBE

Standar kompetensi nasional bidan menjadi basis utama dalam *Outcome-Based Education (OBE)* untuk pendidikan kebidanan. Dalam kerangka OBE, capaian pembelajaran lulusan (*CPL*) harus dirumuskan berdasarkan standar kompetensi nasional agar lulusan benar-benar memenuhi tuntutan praktik profesional yang berlaku secara nasional (Kemendikbudristek, 2023). Standar ini juga menjadi dasar dalam perancangan kurikulum, metode evaluasi, serta penilaian kinerja lulusan oleh institusi pendidikan.

Selain itu, standar kompetensi ini juga menjadi acuan dalam Uji Kompetensi Nasional yang wajib ditempuh oleh lulusan program pendidikan kebidanan untuk memperoleh sertifikat kompetensi profesional dan Surat Izin Praktik (*SIP*). Implementasi uji kompetensi ini diatur secara kolaboratif antara Kemenkes RI, Kemendikbudristek, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan organisasi profesi kebidanan yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Dalam pengembangan standar kompetensi nasional bidan, terdapat beberapa tantangan, diantaranya:

1. Variasi kualitas pendidikan di berbagai institusi kebidanan yang belum sepenuhnya seragam dengan standar nasional.

2. Perluasan cakupan praktik bidan di wilayah terpencil yang membutuhkan standardisasi kompetensi yang kuat.
3. Integrasi standar nasional dengan dinamika layanan kesehatan primer dan rujukan.

Ke depan, pengembangan standar kompetensi nasional bidan perlu dikaitkan dengan standar kompetensi internasional seperti *Essential Competencies for Midwifery Practice* oleh International Confederation of Midwives (ICM) untuk memperkuat daya saing lulusan Indonesia di era global.

E. Urgensi Transformasi Kurikulum Pendidikan Bidan

Transformasi kurikulum pendidikan bidan diperlukan untuk menjawab tantangan perubahan profil masalah kesehatan ibu dan anak, peningkatan kompleksitas pelayanan kebidanan, tuntutan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, perkembangan teknologi kesehatan serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kebidanan. Selain itu, harmonisasi Pendidikan bidan dengan standar internasional juga menjadi tuntutan dalam era globalisasi saat ini (International Confederation of Midwives, 2024). Kurikulum yang tidak berbasis capaian pembelajaran berisiko menghasilkan lulusan yang tidak sepenuhnya siap menghadapi tuntutan praktik profesional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan Standar Kompetensi Bidan sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan, yang harus diintegrasikan secara konsisten ke dalam kurikulum D3, D4, dan Profesi Bidan (Kemenkes RI, 2022). Integrasi ini penting untuk memastikan kesinambungan kompetensi antar jenjang pendidikan dan mencegah terjadinya kesenjangan kompetensi lulusan. Hal ini dikarenakan pendidikan bidan jenjang D3, D4, dan Profesi memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kesehatan yang mampu berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan kesehatan reproduksi, serta penguatan sistem kesehatan nasional.

Pendekatan OBE memungkinkan institusi pendidikan kebidanan untuk merumuskan profil lulusan yang jelas, menetapkan capaian pembelajaran yang terukur, serta memastikan relevansi kurikulum dengan Standar Kompetensi Bidan dan kebutuhan dunia kerja. Transformasi ini juga mendukung implementasi pembelajaran berbasis praktik, klinik, dan komunitas secara lebih optimal.

F. Pemetaan Standar Kompetensi Nasional Bidan terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Dalam kerangka Outcome-Based Education (OBE), *Standar Kompetensi Nasional Bidan* berfungsi sebagai rujukan utama dalam perumusan CPL pada pendidikan D3, D4, dan Profesi Bidan. CPL dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi minimal yang dipersyaratkan secara nasional untuk praktik kebidanan profesional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; Kemendikbudristek, 2023).

Pemetaan CPL terhadap standar kompetensi nasional bertujuan untuk:

1. Menjamin keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan praktik profesional.
2. Memudahkan penilaian ketercapaian kompetensi lulusan.
3. Mendukung penjaminan mutu dan akreditasi program studi (ICM, 2024).

Pemetaan CPL terhadap standar kompetensi nasional bidan memungkinkan institusi pendidikan untuk menyusun kurikulum yang terstruktur dan terukur. Setiap mata kuliah diturunkan dari CPL dan selanjutnya dinilai melalui metode penilaian autentik seperti *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE), portofolio, dan penilaian kinerja klinik (Embo et al., 2025). Pendekatan ini juga memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan praktik profesional, sehingga lulusan bidan memiliki kesiapan kerja dan kompetensi yang diakui secara nasional serta selaras dengan standar internasional (ICM, 2024; WHO, 2022).

G. Kurikulum D3 Bidan Berbasis OBE

Pendidikan Diploma III Kebidanan merupakan pendidikan vokasi yang bertujuan menghasilkan bidan pelaksana yang kompeten dalam memberikan asuhan kebidanan dasar. Kurikulum D3 Bidan berbasis OBE dirancang untuk memastikan lulusan mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta pelayanan kesehatan reproduksi pada kondisi normal sesuai dengan spesifikasi pada level KKNi dan Standar Kompetensi Bidan (Kemenkes RI, 2022).

Kurikulum dirancang dengan proporsi praktik yang dominan, baik di laboratorium keterampilan maupun di lahan praktik klinik dan komunitas. Mata kuliah disusun secara bertahap untuk mendukung pencapaian CPL melalui capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang diturunkan langsung dari CPL (Kemenkes RI, 2022). Standar Kompetensi Nasional Bidan menjadi rujukan utama dalam penyusunan CPL dan CPMK kurikulum D3 Bidan.

Pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi kuliah, praktikum laboratorium, simulasi klinik, dan praktik klinik di lahan praktik. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain *skills lab*, *case-based learning*, dan

problem-based learning sederhana yang relevan dengan konteks praktik kebidanan dasar (Ige et al., 2024). Pendekatan OBE pada jenjang D3 menekankan pembelajaran praktik dan klinik yang terstruktur, disertai penilaian autentik seperti *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE), logbook praktik, dan penilaian kinerja di lahan praktik (Ige et al., 2024).

Ciri utama pembelajaran OBE pada D3 kebidanan yaitu focus keterampilan dasar kebidanan sesuai standar kompetensi nasional bidan (sesuai level bidan), penilaian dilakukan dengan metode OSCE, melalui logbook dan kinerja klinik, serta berfokus pada tujuan lulusan D3 Bidan, yaitu sebagai bidan pelaksana.

H. Kurikulum D4 Bidan Berbasis OBE

Pendidikan Diploma IV Kebidanan diarahkan untuk menghasilkan bidan dengan kemampuan lebih luas, terutama dalam analisis masalah, kepemimpinan, pengambilan keputusan yang lebih kompleks dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Kurikulum D4 berbasis OBE menekankan penguatan berfikir kritis (*critical thinking*), kepemimpinan, manajemen pelayanan kebidanan, serta penerapan *evidence-based practice* dalam pengambilan keputusan klinik (Kusrini & Susanti, 2025).

Capaian pembelajaran lulusan D4 Bidan juga mencakup kemampuan memberikan asuhan kebidanan komprehensif, melakukan deteksi dini komplikasi, kolaborasi interprofesional dalam tim kesehatan, serta pengembangan inovasi sederhana dalam pelayanan kebidanan berbasis komunitas (ICM, 2024). Kurikulum pendidikan D4 Bidan juga mengintegrasikan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pendekatan pembelajaran pada jenjang D4 Bidan lebih menekankan integrasi teori dan praktik, diskusi kasus kompleks, simulasi klinik lanjutan, serta pembelajaran berbasis proyek. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan melalui kombinasi ujian teori, OSCE lanjutan, proyek, dan karya ilmiah terapan.

Ciri utama pembelajaran OBE pada D4 Bidan yaitu berfokus pada tujuan pendidikan D4 kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan pelaksana mahir atau koordinator layanan, memiliki kemampuan analisis kasus dan *critical thinking*. Sehingga dalam proses pembelajaran menekankan pada studi kasus (*case study*).

I. Kurikulum Profesi Bidan Berbasis OBE

Pendidikan Profesi Bidan merupakan tahap akhir dalam pembentukan bidan profesional yang siap praktik mandiri dan bertanggung jawab secara etik dan hukum. Kurikulum Profesi Bidan berbasis OBE dirancang untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi klinik yang unggul, sikap profesional, serta kemampuan

refleksi dan pembelajaran sepanjang hayat. Sehingga lulusan mampu memberikan asuhan kebidanan komprehensif dan berkesinambungan (*continuity of care*) sesuai standar profesi (Embo et al., 2025). Selain itu, lulusan profesi Bidan diharapkan mampu menangani kasus kegawatdaruratan dasar, melakukan rujukan tepat, serta berperan sebagai advokat kesehatan perempuan dan anak di lokasi tempat ia berpraktik nantinya.

Pembelajaran pada pendidikan profesi didominasi oleh praktik klinik intensif dengan supervisi preceptor, pembelajaran berbasis kasus nyata dan refleksi praktik sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) (Shikuku et al., 2025). Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui evaluasi kinerja klinik, OSCE profesi, ujian akhir profesi, dan uji kompetensi nasional.

Ciri pembelajaran OBE pada Profesi Bidan yaitu berfokus pada praktik penuh di lokasi pelayanan kebidanan (lahan klinik/ puskesmas/ rumah sakit), penilaian pembelajaran yang berbasis hasil kinerja nyata dan bertujuan menghasilkan lulusan bidan profesional siap praktik.

J. Integrasi Standar Kompetensi Bidan dalam Kurikulum OBE

Standar Kompetensi Bidan Indonesia dan standar internasional ICM menjadi landasan utama dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan pada setiap jenjang Pendidikan kebidanan, baik D3, D4 maupun Profesi Bidan. Setiap capaian pembelajaran mata kuliah harus diturunkan langsung dari capaian pembelajaran lulusan dan dikaitkan dengan elemen standar kompetensi bidan (Kemenkes RI, 2022; ICM, 2024). Dengan demikian, terdapat keselarasan vertikal dan horizontal antara standar kompetensi, kurikulum, pembelajaran, dan penilaian.

Integrasi standar kompetensi dalam kurikulum berbasis OBE memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan regulasi profesi. Pendekatan ini memastikan adanya *constructive alignment* antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian, sebagaimana prinsip utama dalam OBE (Jones et al., 2025).

K. Implementasi OBE dalam Pembelajaran dan Penilaian

Implementasi OBE dalam pendidikan kebidanan menuntut perubahan paradigma dosen dan institusi pendidikan. Dosen berperan sebagai fasilitator pembelajaran, sedangkan mahasiswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar. Metode pembelajaran harus dirancang untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran, bukan sekadar penyampaian materi. Penilaian dalam OBE bersifat autentik, berkelanjutan, dan berbasis kinerja. Instrumen penilaian harus valid, reliabel, dan transparan serta mampu mengukur ketercapaian kompetensi secara

komprehensif. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan kurikulum secara berkelanjutan.

Implementasi transformasi kurikulum berbasis OBE pada pendidikan bidan menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan lahan praktik, beban administrasi, serta kesenjangan pemahaman tentang OBE. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas dosen, pengembangan sistem penjaminan mutu internal, serta kolaborasi dengan lahan praktik dan pemangku kepentingan. Dukungan kebijakan institusi, pelatihan berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi yang sistematis menjadi kunci keberhasilan transformasi kurikulum pendidikan bidan berbasis OBE.

L. Simpulan

Transformasi kurikulum D3, D4, dan Profesi Bidan berbasis Outcome-Based Education dan Standar Kompetensi Bidan merupakan strategi penting dalam peningkatan mutu pendidikan kebidanan. Pendekatan OBE memungkinkan institusi pendidikan menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak (Ige et al., 2024; Embo et al., 2025). Keberhasilan implementasi kurikulum berbasis OBE memerlukan komitmen institusi, kesiapan dosen, serta sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan (Shikuku et al., 2025).

M. Referensi

- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). Open University Press.
- Embo, M., Levy, C., & Pairman, S. (2025). The International Confederation of Midwives essential competencies for midwifery practice: A revision process – 2024. *Midwifery*, 149, 104525. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2025.104525>
- Ige, W. B., Ngcobo, W. B., & Afolabi, O. (2024). Implementation of competency-based education for quality midwifery programmes in Africa: A scoping review. *BMC Nursing*, 23, 685. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02333-w>
- International Confederation of Midwives. (2024). *Essential competencies for midwifery practice* (Revised ed.). ICM. <https://internationalmidwives.org/resources/essential-competencies-for-midwifery-practice/>
- Jones, A., Smith, L., & Brown, T. (2025). Advancing nurse-midwifery education: A quality approach to competency-based education. *Journal of Midwifery & Women's Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/jmwh.70029>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar kompetensi kerja bidang kebidanan* (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022). Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Panduan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis Outcome-Based Education*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Kebijakan transisi uji kompetensi nasional bidang kesehatan*. Kemendikbudristek.
- Kolegium Kebidanan Indonesia, & Konsil Kesehatan Indonesia. (2025). *Kerangka pengembangan kurikulum pendidikan kebidanan Indonesia berbasis standar kompetensi*. KKI.
- Kusrini, P., & Susanti, A. I. (2025). Competency-based education in midwifery: A comprehensive review of implementation strategies and outcomes in developing regions. *Inovasi Kurikulum*, 2(2), 1155–1170.
- Noviyanti, N. (2024). Midwife competency standards and midwife authority in emergency delivery services. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*.
- Shikuku, D. N., Maina, T., & Otieno, P. (2025). National continuous professional development programmes for midwifery educators and their effectiveness in low- and middle-income countries: A systematic review. *BMC Medical Education*, 25, 1264. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-07877-2>
- Spady, W. G. (1994). *Outcome-based education: Critical issues and answers*. American Association of School Administrators.
- World Health Organization. (2022). *Global standards for the education of midwives*. WHO. <https://www.who.int/publications>
- World Health Organization. (2023). *Transforming and scaling up health professionals' education and training*. WHO Press.

N. Glosarium

CPL	: Capaian Pembelajaran Lulusan
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
OBE	: <i>Outcome-Based Education</i>
OSCE	: <i>Objective Structured Clinical Examination</i>
COC	: <i>Continuity of Care</i>

CHAPTER 2

MODEL CONTINUITY OF CARE (CoC) DALAM PENDIDIKAN KEBIDANAN: PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EVALUASI

Giari Rahmilasari

A. Pendahuluan

Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki (Permenkes No.28 Tahun 2017). Salah satu kewenangan bidan yaitu mendampingi proses fisiologis wanita pada masa kehamilan, persalinan dan nifas secara menyeluruh, aman dan sesuai kebutuhan.

Kualitas pelayanan yang baik, sangat dibutuhkan untuk dapat menurunkan jumlah kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi. Bukti menunjukkan bahwa perawatan yang berkualitas tinggi dari bidan sangat penting untuk mencapai tujuan dan target internasional dalam peningkatan kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan anak (Nove et al., 2021; Renfrew, 2021; Renfrew et al., 2014). Pelayanan kebidanan merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang memerlukan bukti kuat dalam pemberian asuhannya. Berbagai model pelayanan telah dikembangkan, yang berasal dari dua model pelayanan utama dalam asuhan kebidanan dan pendidikan kebidanan, yaitu: *classic midwifery model* yang memandang kehamilan sebagai proses alami dengan minim intervensi medis, dan *strict medical of care* yang menekankan pada intervensi medis atau bahkan pembedahan sejak awal.

Model asuhan kebidanan merupakan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan obstetri. Pendekatan kebidanan menggunakan asuhan (*nurturing*) yang bersifat eksklusif untuk tiap ibu dengan penuh perhatian, sebelum, selama, dan setelah persalinan. Model asuhan kebidanan meyakini bahwa kehamilan dan persalinan merupakan tahapan kehidupan yang normal (Choudhary et al., 2020).

Continuity of Care adalah konsep yang berakar dari lokasi pemberian perawatan primer (seperti puskesmas) yang melibatkan perawatan individu dari waktu ke waktu oleh penyedia layanan kesehatan yang sama. Konsep ini mencakup keberlanjutan relasional (*relational continuity*), keberlanjutan informasi (*informational continuity*) dan keberlanjutan manajemen (*management continuity*). Pada lokasi perawatan primer, asuhan berkelanjutan (*Continuity of*

Care) telah terbukti mengurangi angka kematian dan rawat inap, serta meningkatkan kepuasan pasien.

Penerapan asuhan berkelanjutan (*Continuity of Care*) pada perawatan ibu dan bayi baru lahir, mengacu pada sebuah keadaan dengan pemberian asuhan yang diberikan oleh bidan yang sama atau tim kecil dari bidan yang memberikan asuhan selama periode kehamilan, persalinan dan postpartum yang memungkinkan rujukan ke spesialis jika dibutuhkan. (Bradford et al., 2022). Model CoC yang diterapkan di berbagai negara dengan penghasilan tinggi berhubungan dengan rendahnya angka persalinan prematur (penurunan kejadian sampai 24%), kematian janin sebelum dan sesudah 24 minggu, dan kematian neonatal secara keseluruhan pada ibu hamil berisiko rendah, jika dibandingkan dengan model perawatan lainnya. Selain itu, intervensi lebih jarang dilakukan dan para ibu melaporkan pengalaman positif selama asuhan (Bradford et al., 2022). Meskipun WHO telah merekomendasikan pelayanan kebidanan dengan model *CoC* atau dikenal juga dengan *Midwifery led Continuity of Care (MLCC)*, namun pelaksanaannya di setiap negara membutuhkan bidan yang kompeten (terlatih dengan baik), sehingga untuk penerapannya, membutuhkan pertimbangan yang baik untuk terlebih dahulu meningkatkan kualitas bidan di wilayahnya.

Pendidikan kebidanan memiliki filosofi “asuhan yang berpusat pada perempuan” yang memberikan asuhan secara holistik pada perempuan. Maka CoC merupakan bagian integral dari konsep pelayanan holistik dasar yang berpusat pada perempuan. Mahasiswa kebidanan yang mengikuti model pembelajaran CoC terbukti memiliki pemahaman yang lebih baik tentang filosofi pelayanan kebidanan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas asuhan klinis, sehingga meningkatkan manfaat kesehatan secara keseluruhan bagi perempuan (Yanti et al., 2015).

Continuity of Midwifery Care adalah sebuah *gold standard* model untuk asuhan ibu. *Internasional Confederation of Midwifery (ICM)* menyatakan bahwa semua program kebidanan harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan lebih lanjut menyoroti kebutuhan akan bidan yang mampu untuk bekerja dengan model asuhan berkelanjutan (CoC) ini. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penting bagi mahasiswa kebidanan untuk diberi kesempatan berlatih dalam model CoC selama studi.

Mahasiswa yang melakukan model CoC selama studi terbukti dapat menumbuhkan ketersambungan (*connectedness*) kepada pasien, pemahaman yang luas tentang kondisi keluarga dan psikososial pasien, dan paparan keterampilan klinis kebidanan. Mahasiswa juga memiliki kesadaran akan profesionalisme yang lebih tinggi, melaksanakan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam melakukan

tindakan kebidanan, dan mereka merasakan bahwa kehadirannya ikut berkontribusi positif pada asuhan kebidanan, bahkan mahasiswa kebidanan merasa lebih siap untuk dapat bekerja sesudah melaksanakan CoC. Pasien juga merasa telah memiliki interaksi yang baik selama perawatan mereka dan mendukung sistem rumah sakit, sehingga muncul hubungan saling percaya yang bermakna dan menghasilkan kepuasan dalam pelayanan kebidanan (Carter et al., 2022; Foster et al., 2021).

Terlepas dari berbagai keuntungan model ini dalam pembejarian mahasiswa kebidanan, mahasiswa juga menghadapi tantangan dalam mencapai keberhasilan dalam program ini, hingga dilaporkan mereka mengalami stress akademis, pribadi, sosial dan finansial. Namun, dengan perencanaan yang baik maka program ini akan dapat dilalui dengan baik. CoC memberikan ruang bahwa setiap mahasiswa dapat bertumbuh secara berbeda sesuai dengan situasi yang dihadapi setiap masing-masing mahasiswa (Foster et al., 2021).

B. Perencanaan

Mahasiswa kebidanan memerlukan persiapan yang baik dalam menghadapi proses pendidikan, terutama pada model CoC. Beberapa persiapan yang dibutuhkan berdasarkan "*tripartite model*" yaitu sebuah sistem pendidikan kesehatan yang merujuk pada kolaborasi dari ketiga pihak, yang bekerjasama untuk mencetak pembelajaran praktik, penelitian untuk peningkatan kualitas pendidikan (khususnya kesehatan), kesiapan bekerja mahasiswa dan lain lain. Sistem yang dibangun pada model ini yaitu kolaborasi dari institusi pendidikan (academic), lahan praktik (*placement*), dan mahasiswa (*student model*), yang diharapkan dengan pendekatan kerjasama ini dapat menjembatani celah (*gap*) antara teori dan kenyataan di praktik klinik (Hainsworth et al., 2021):

1. Persiapan diri

- a. Dukungan (Support) dari : Orangtua, universitas tempat mereka belajar, tempat dan staf klinis tempat mereka praktik (belajar), teman, keluarga, rekan sejawat.
- b. Pahami "definisi" CoC yang ditetapkan oleh pendidikan masing-masing, pastikan sudah mendapatkan dan pelajari dengan baik pedoman penulisannya, untuk meminimalisir kesalahan dan kecemasan pada saat pelaporan.
- c. Keamanan diri (*Personal Safety*). Pastikan memiliki lokasi yang tidak terlalu jauh dari lokasi pasien CoC akan diambil, hal ini akan meminimalisir kelelahan dalam perjalanan. Pelaksanaan CoC pada asuhan ibu dan bayi pada dasarnya

tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun oleh tim kecil dengan seorang bidan penanggung jawab dalam tim, namun pada asuhan berkelanjutan oleh mahasiswa, hal ini dilakukan hanya oleh satu orang mahasiswa saja. Artinya, memungkinkan kedatangan berulang ke lokasi praktik untuk memberikan pelayanan kepada pasien, hal ini akan menyulitkan jika posisinya jauh dari tempat tinggal (Foster et al., 2021).

- d. Belajar hubungan profesional dengan pasien (*Profesional Relationship*). Memberikan ruang pelayanan untuk bisa menerima pesan melalui telepon selular maupun bisa dihubungi kapan saja, kadang bisa membuat mahasiswa bingung akan batasan profesional mereka. Mempelajari komunikasi yang baik dalam perilaku profesional dengan pasien akan memberikan hasil yang positif dalam memberikan layanan.
- e. Kuasai seluruh skill praktik yang telah diajarkan di laboratorium, optimalkan dengan belajar mandiri sesudah pembelajaran selesai, dan atau meskipun telah lulus ujian praktik. Hal ini sebagai bekal yang baik untuk dapat melakukan setiap tahapan dalam praktik CoC. Setelah melaksanakan CoC dan dilakukan ujian praktik klinik, umumnya mahasiswa merasa lebih mudah dalam menyelesaikan ujiannya (Browne et al., 2014).
- f. Sesuaikan dengan pedoman yang telah diterbitkan oleh pendidikan (universitas) masing-masing, gunakan format pengkajian, daftar tilik yang disediakan oleh institusi masing-masing, namun membuka wawasan dari berbagai institusi lain dan teori secara keseluruhan, untuk memperkaya pemahaman.
- g. Persiapkan pasien dengan usia kehamilan 32 minggu keatas. Jika memungkinkan, persiapkan lebih dari 1 pasien, sebagai pasien cadangan untuk dapat diberikan asuhan dengan model CoC (ini hanya bersifat pilihan saja).
- h. Bangun komunikasi yang baik dan gunakan teknik komunikasi terapeutik dengan pasien CoC. Hubungan bidan-pasien merupakan hal utama dalam pelayanan kebidanan, karena akan menumbuhkan kepercayaan dan keamanan, serta memberikan dukungan interpersonal. Membangun hubungan baik sangat penting pada tahap awal hubungan terapeutik yang aman dan saling percaya. Pendekatan yang dapat digunakan bisa menggunakan komunikasi non verbal dan verbal, menggunakan keterampilan mendengarkan aktif, memberikan informasi yang jelas, perhatian, empati, rasa hormat, dan penggunaan sentuhan terapeutik. Keseluruhannya bertujuan untuk membangun kemitraan kolaboratif sehingga pasien merasa didengar dan didukung (Skubic et al., 2025).

2. Persiapan Institusi

- a. Persiapkan fasilitas praktik yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk dapat melakukan asuhan secara berkesinambungan. Beberapa negara yang belum melaksanakan asuhan dengan prinsip "*Women Center Care*" atau "*Continuity of Care*" perlu memastikan bahwa tempat mahasiswa praktik memperbolehkan, memfasilitasi serta mendampingi mahasiswa kebidanan yang akan melakukan program CoC.
- b. Persiapkan *Clinical Instructure (CI)* dan dosen pembimbing yang dapat membimbing untuk memungkinkan mahasiswa kebidanan mendapatkan pengalaman relasi yang berkelanjutan, mendukung proses belajar agar dapat mengoptimalkan setiap tahapan yang dilalui, dan memberikan *feedback* sebagai evaluasi kinerja mahasiswa.
Hubungan antara mahasiswa dengan dosen dan *CI* sebagai mentor bisa menjadi kunci dalam proses pembelajaran. Hubungan mahasiswa -mentor yang saling percaya dapat bersifat transformasional, memfasilitasi wawasan dan pembelajaran yang mendalam, serta pertumbuhan kepercayaan diri dan kesiapan untuk transisi ke praktik klinik. Hubungan yang baik dapat membuat mahasiswa mendapatkan kauliats pengalaman berkelanjutan, sedangkan hubungan yang sulit, dapat membuat mahasiswa cemas dan dapat mengurangi kepercayaan diri, kemampuannya untuk melakukan praktik (Moncrieff et al., 2021)
- c. Persiapkan model pembelajaran orang dewasa yang dipahami oleh seluruh tenaga dosen pembimbing dan *Clinical Instructure*, dan modul evaluasi yang tepat agar dapat mengukur pembelajaran yang berkelanjutan dengan baik, serta jadwalkan waktu dalam kurikulum yang tepat agar dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan CoC dengan baik (Foster et al., 2021; Hainsworth et al., 2021).

3. Persiapan Lahan Praktik

- a. Persiapkan lahan praktik yang dapat memungkinkan mahasiswa kebidanan mendapatkan kesempatan untuk memberikan asuhan secara berkesinambungan. Sistem rekam medik yang baik, luas cakupan wilayah, dan sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang pembelajaran, adalah beberapa ukuran agar lahan praktik mampu memfasilitasi kesempatan mahasiswa kebidanan melakukan CoC.
- b. *Clinical Instructure (CI)* membimbing dengan kapasitas pendidikan yang sesuai, misalnya untuk membimbing mahasiswa Profesi, maka CI minimal juga telah menempuh jenjang pendidikan profesi. Jika tidak bisa dipenuhi

karena keterbatasan satu dan lain hal, maka sebaiknya memiliki kriteria khusus, misalnya pengalaman bekerja, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan institusi (Ball et al., 2022).

- c. CI sebaiknya telah memiliki sertifikat pelatihan *preceptor-mentorship*. Hal ini karena pelatihan mentorship merupakan hal yang sangat kuat untuk mendukung peningkatan kualitas mahasiswa kebidanan di lahan praktik. Mahasiswa dapat meningkatkan sesi konsultasi antara mahasiswa, bidan di lahan praktik, dan pendidik dari institusi (Amod & Mkhize, 2023).
- d. Kemampuan CI yang harus dikembangkan yaitu rasa memiliki, pengalaman langsung/pengembangan keterampilan, pengembangan identitas profesional mahasiswa, dan karakteristik pembimbing yang mampu membina rasa saling percaya, membuat mahasiswa akan lebih percaya diri untuk menyuarakan pendapat mereka, menyampaikan kekhawatiran, dan merasa berdaya di lingkungan praktik kliniknya (Ball et al., 2022).

C. Implementasi

Pada dasarnya, setiap institusi pendidikan memiliki rangkaian kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan institusinya masing-masing. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan visi-misi dan tujuan pada setuan institusi yang berbeda. Namun, secara umum prinsip CoC adalah sama, yaitu memberikan pelayanan kepada pasien sejak masa kehamilan hingga masa antara dengan pemberian asuhan Keluarga Berencana (KB).

1. Pada saat praktik klinik dan berada pada program CoC, segera petakan apa yang akan dilakukan kedepan. Buat target pekan seberapa harus mendapatkan pasien, dan apa yang harus dilakukan jika pada target waktu tersebut pasien belum didapatkan.

Lihat jangka waktu pelaksanaan berapa lama, cermati kalender akademik yang sedang berjalan dan panduan yang diberikan pembimbing institusi masing-masing.

Buat target:

- a. Pengambilan pasien sesuai usia kehamilan dari panduan institusi, bangun kepercayaan pasien sejak kontak pertama.
- b. Rencanakan waktu asuhan kehamilan, jika harus dua kali asuhan, maka tentukan langsung kapan pertemuan kedua sebagai acuan, dan sebagai waktu kunjungan ulang dalam penatalaksanaan di dokumentasi kebidanan yang dibuat.
- c. Siapkan diri untuk waktu sejak 2 pekan sebelum Taksiran Persalinan (TP) dan 2 pekan sesudah TP, karena persalinan bisa terjadi kapan saja, terutama di

rentang waktu tersebut. Rumus Naegele di susun oleh seorang dokter obstetri Jerman yaitu Franz Karl Naegele (1778-1851) yang memperkirakan bahwa lamanya kehamilan adalah 10 kali dari siklus menstruasi, yaitu 10×28 hari = 280 hari = 40 minggu. Rumus ini menambahkan sembilan bulan dan tujuh hari pada hari pertama haid terakhir. Hasil hitung dari rumus Naegele adalah estimasi 40 minggu usia kehamilan, dan ini perlu dipahami sebagai tanggal perkiraan persalinan, bukan tanggal yang pasti. Faktor yang mempengaruhi lamanya kehamilan yaitu etnis, tinggi bada, variasi siklus menstruasi, waktu terjadinya ovulasi, paritas dan berat badan ibu. Kalsifikasi usia kehamilan yang dianggap masuk "*early term*" yaitu sejak 37-38 minggu, "*term*" yaitu 39-40 minggu, dan "*late term*" yaitu 41 minggu, berdasarkan klasifikasi ini, maka persalinan bisa saja terjadi ± 2 minggu dari tanggal TP yang diperkirakan pada usia 40 minggu, maka rentang usia kehamilan normal berada pada rentang 38-42 minggu (Lawson, 2021).

- d. Berikan kontak untuk konsultasi, selain kontak pribadi (untuk menjaga privasi anda) agar memudahkan pasien menghubungi jika ada pertanyaan ataupun terasa akan bersalin, hal ini akan memudahkan dan membangun relasi yang berkelanjutan dengan klien jika kepercayaan sudah terjalin.
2. Pada saat pemberian asuhan baik saat kehamilan, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas, bayi baru lahir dan KB, sedapat mungkin lakukan sesuai dengan teori dan setiap tindakan yang diambil, berdasarkan *evidence based midwifery practice*.
3. Ingat, untuk menilai setiap aspek pada ibu secara holistik, yaitu biologi, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual. Berikan asuhan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan ibu. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian dengan baik dan menyeluruh.

Kaji secara seksama data subjektif termasuk keadaan spiritual saat ini. Aspek hubungan interpersonal antara pemberi pelayanan (bidan) dengan pasien salah satunya adalah kepekaan bidan terhadap kebutuhan pasien dengan penyelesaian masalah medis dalam asuhan kebidanan berdasarkan kebutuhan spiritual yang mereka yakini atau dalam Islam berdasarkan syariat, sehingga seluruh rangkaian asuhan menjadi lebih komprehensif dan menjadi langkah efektif agar ibu dapat menerima peran ibu dan memperhatikan keadaan bayi (Akhtarkia et al., 2023; Ismail et al., 2022). Kesehatan spiritual ibu selama persalinan, menciptakan pengalaman persalinan yang menyenangkan, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan ibu dan bayi setelah persalinan, hal ini dapat juga menjadi langkah yang efektif dalam penerimaan peran sebagai ibu. Pengalaman yang positif dapat membuat ibu merasa

sempurna, mampu mengharagi dirinya dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Pengalaman persalinan yang positif juga dapat mempengaruhi perasaan ibu terhadap bayinya, serta memainkan peran penting pada kesehatan ibu dan bayinya (Akhtarkia et al., 2023).

4. Buat penatalaksanaan dalam pendokumentasian secara berurutan dari yang paling awal di lakukan pada setiap tahapan asuhan. Hal ini akan memudahkan untuk melakukan evaluasi pada tahapan selanjutnya. Buat pendokumentasian dengan tepat. Mahasiswa kebidanan harus menyadari bahwa nilai dokumentasi sangat penting, apalagi di lapangan bidan sangat diharapkan untuk menyampaikan dokumentasi yang akurat, komprehensif, dan menilai dengan tepat waktu berdasarkan penilaian, perencanaan, pengambilan keputusan, tindakan dan evaluasi (Brown et al., 2025). Format pendokumentasian harus memenuhi syarat rekam medis yang bermutu yaitu harus memenuhi beberapa indikator yaitu lengkap, akurat, tepat waktu dan memenuhi aspek hukum. Bentuk SOAP yang akan digunakan baik format lama maupun format yang telah di modifikasi dalam bentuk simplifikasi, keseluruhannya harus memenuhi syarat rekam medis yang bermutu, untuk memenuhi hal tersebut, per kaya diri dengan *workshop* atau pelatihan pengguna sistem sesuai dengan standar yang terbaru (Romlah et al., 2024).
5. Beberapa acuan tindakan/asuhan yang dapat digunakan berdasarkan rekomendasi WHO pada masa kehamilan, persalinan dan nifas, yaitu:

a. Kehamilan (Antenatal) (Organization, 2022a)

- 1) Konseling tentang makanan sehat dan tetap aktif secara fisik selama kehamilan, direkomendasikan untuk wanita hamil agar tetap sehat dan mencegah kenaikan berat badan yang terlalu banyak selama kehamilan
- 2) Asupan harian suplemen zat besi 90-60 mg) dan asam folat (400µg / 0,4 mg), direkomendasikan untuk mencegah anemia pada ibu hamil, infeksi masa nifas (*sepsis puerperal*), bayi baru lahir dengan berat badan rendah (*Low Birth Weight/LBW*) dan persalinan prematur.
- 3) Deteksi hiperglikemia pada kapan saja selama kehamilan harus diklasifikasikan juga sebagai Diabetes gestasional (GDM) atau diabetes dalam kehamilan, berdasarkan kriteria WHO.
Rekomendasi ini bukan merekomendasikan pemeriksaan rutin hiperglikemia pada kehamilan, namun diagnosa GDM harus ditegakkan jika pada saat pertama kali pada kapan saja di periode antenatal terdapat hiperglikemia , yang diikuti oleh satu atau lebih dari tanda berikut:
 - a) Gula darah puasa = 5.1–6.9 mmol/L (92–125 mg/dL)

b) Gula darah 1 jam > 10.0 mmol/L (180 mg/dL) diikuti dengan 75 g oral glucose load

c) 2-hour plasma glucose 8.5–11.0 mmol/L (153–199 mg/dL) diikuti dengan 75 g oral glucose load.

Diabetes mellitus dalam kehamilan harus ditegakkan diagnosanya jika satu atau lebih dari kriteria dibawah ini ditemui:

a) Gula darah puasa > 7.0 mmol/L (126 mg/dL)

b) Gula darah sesudah 2 jam > 11.1 mmol/L (200 mg/dL) diikuti 75 g oral glucose load

c) Gula darah sewaktu > 11.1 mmol/L (200 mg/dL) dengan adanya tanda-tanda diabetes.

- 4) Tenaga kesehatan harus menanyakan kepada seluruh ibu hamil pada saat pertama kali kontak dengan nakes dan pada setiap kali kunjungan pemeriksaan antenatal, tentang penggunaan tembakau (saat ini atau sebelumnya) dan paparan sampai apakah ia seorang perokok pasif (*second hand smoke*); penggunaan alkohol, NAPZA dan zat adiktif lain;
- 5) dan lain lain

b. Persalinan (Intranatal)(Vallely et al., 2023)

- 1) Pemberian asuhan dengan *Respectful Maternity Care* yang merujuk pada pemberian asuhan dengan menjaga martabat, privasi, dan kerahasiaan mereka, memastikan terbebas dari bahaya dan perlakuan buruk, dan dukungan secara berkelanjutan selama proses persalinan
- 2) Komunikasi efektif antara tenaga kesehatan pada saat persalinan menggunakan bahasa dan budaya yang mudah dan dapat diterima ibu
- 3) Informasi yang jelas dan dapat dipahami ibu tentang tahapan proses persalinan yang sedang dialami olehnya.
- 4) Penggunaan doppler atau Pinard fetal stetoskop untuk mengetahui kesejahteraan janin
- 5) Pemeriksaan rutin setiap 4 jam sekali pada fase aktif dengan wanita risiko rendah
- 6) Pemberian teknik relaksasi termasuk relaksasi otot progresif, mengatur nafas, musik, mindfulness, dan teknik lain yang dapat menurunkan rasa nyeri ibu bersalin
- 7) Dan lain lain

c. Nifas (Postnatal) (Organization, 2022b)

- 1) Semua perempuan harus mendapatkan penilaian perdarahan pervagina, tonus uterus, tinggi fundus, suhu dan nadi, secara rutin selama 24 jam pertama, dimulai dari 1 jam pertama sesudah persalinan. Tekanan darah harus diukur segera setelah persalinan, jika normal, ukur kembali setelah 6 jam. Selama 24 jam, secara bertahap dilakukan penilaian terhadap kesejahteraan ibu secara umum, penilaian kebutuhan terhadap berkemih dan kemungkinan terjadinya inkontinensia urin, nyeri pada luka perineum, sakit kepala, mual, nyeri pinggang, nyeri dan kebersihan perineum, nyeri payudara dan tonus otot uteri serta lochea.
- 2) Konseling pada bendungan payudara dan dukungan yang responsif untuk menyusui, posisi perlekatan yang baik, cara pemerah ASI, dan penggunaan kompres dingin/panas.
- 3) Informasi nutrisi yang benar untuk mencegah terjadinya konstipasi pada masa nifas.
- 4) Skrining depresi postpartum dan kecemasan menggunakan instrumen yang telah tervalidasi
- 5) Aktivitas fisik reguler untuk seluruh ibu nifas yang tidak memiliki kontraindikasi harus dilakukan, dilakukan selama kurang lebih 150 menit, selama 1 minggu, digabungkan juga dengan berbagai aktivitas fisik yang menguatkan otot, dan juga peregangan ringan.
- 6) Informasi dan layanan kontrasepsi yang komprehensif selama perawatan nifas
- 7) Dan lain lain

D. Evaluasi

Continuity of Care pada mahasiswa kebidanan memiliki tema utama yaitu belajar melalui hubungan "*learning through relationship*", tema utama ini dibangun dari tiga tema yang saling terkait yaitu: bertemu pasien dan membangun konektivitas, menjadi tahu, dan memahami asuhan holistik. Pada metode pembelajaran dengan metode pemberian asuhan CoC ini mahasiswa berusaha untuk merefleksikan pembelajaran yang mereka dapatkan menjadi praktik nyata, dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, sehingga terbangun kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menyadari kebutuhan mereka untuk dapat terus membangun kemampuan menjadi seorang bidan yang profesional.

Maka evaluasi yang baik, adalah juga evaluasi yang dilakukan berdasarkan apa yang sudah direncanakan, dan apa yang sudah dilaksanakan, mencari

kesenjangan antara keduanya, dan kesenjangan antara pelaksanaan dengan teori yang ada. Evaluasi dapat menggambarkan apakah intervensi yang dilakukan berkualitas tinggi dan mewakili nilai-nilai tentang karakteristik atau hasil intervensi yang diinginkan (Teasdale et al., 2023).

Evaluasi digunakan untuk menyelidiki kualitas (manfaat, nilai, signifikansi) dari program, kebijakan atau inisiatif perubahan untuk mengidentifikasi perbaikan, menginformasikan pengambilan keputusan, dan mendorong pembelajaran. Proses yang digunakan untuk mencapai kesimpulan evaluatif-penilaian-melibatkan sintesis dan interpretasi bukti empiris dalam kaitannya dengan kriteria berbasis nilai.

Salah satu model kriteria evaluasi yang mengajarkan cara menentukan kriteria dengan pihak yang terlibat dan terpengaruh, yaitu berdasarkan domain. Domain kriteria tersebut yaitu digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1: Domain Kriteria, adaptasi dari (Teasdale et al., 2023)

Domain	Deskripsi
Keselaran	Intervensi adalah konsisten dan terkoordinasi dengan inisiasi yang besar atau terhubung. Apakah intervensi yang diberikan sudah selaras dengan kebutuhan ibu
Implementasi	Konseptual dan eksekusi, adalah konsisten dengan teori, praktik terbaik, praktik, berbasis bukti/ <i>evidence based practice</i> , intervensi dilakukan sesuai rencana, dan sesuai dengan konteks (kebutuhan).
<i>Experience</i> /Pengalaman	Kegiatan yang dilakukan bermanfaat, menyenangkan, atau disampaikan dengan penuh hormat, peserta/klien memiliki sikap positif terhadap intervensi atau bersedia mengadopsinya/melakukannya
Kesetaraan	Peluang, pengalaman, manfaat dan hasil yang adil dan merata
<i>Outcome/Impact</i>	Intervensi yang diberikan mencapai hasil jangka pendek atau jangka panjang yang diinginkan
Capaian/Akses	Intervensi memberikan pelayanan dan mempertahankan manfaat yang diterima klien, dan klien dapat berpartisipasi untuk mendapatkan manfaat tersebut.

Relevansi	Intervensi konsisten dengan kebutuhan, budaya, atau keadaan penerima manfaat yang dituju
Replicability	Intervensi yang diberikan dapat di duplikasi atau dilakukan kembali pada konteks yang berbeda dengan komponen, model atau prinsip yang sama
Penggunaan sumber daya/alokasi sumber daya	Pendanaan dan material digunakan secara ekonomis, pendanaan, personil, dan material mencukupi untuk pelaksanaan. Contoh pada tata laksana pemberian doa, gunakan materi kertas yang dapat dipakai berulang, sehingga pemberian edukasi dapat dilakukan secara ekonomis.
Keberlanjutan (sustainability)	Intervensi yang diberikan telah (atau dapat) memiliki manfaat jangka panjang atau aktifitas yang berlanjut.
Efek yang tidak diinginkan	Intervensi dikaitkan dengan konsekuensi positif yang tidak direncanakan atau konsekuensi negatif yang minimal

Seluruh domain evaluasi ini dapat di jadikan kerangka berpikir yang dapat dituangkan dalam pembahasan untuk melihat apakah tindakan yang diberikan sudah tepat atau masih memerlukan perbaikan, dan apa yang seharusnya dapat dilakukan.

Evaluasi pada asuhan yang diberikan mahasiswa kebidanan bukan hanya tentang “menyamakan hasil dengan teori yang ada”, tapi justru memperkaya pengetahuan ketika kesenjangan itu ada, dilakukan penggalian informasi, mengapa kesenjangan tersebut terjadi, dan kemungkinan yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi hal tersebut.

E. Simpulan

Continuity of Midwifery Care adalah sebuah *gold standard* model untuk asuhan ibu. *Internasional Confederation of Midwifery (ICM)* menyoroti kebutuhan akan bidan yang mampu bekerja dengan model asuhan berkelanjutan (CoC) ini. Berbagai penelitian menunjukkan manfaat mahasiswa kebidanan yang menjalankan model asuhan berkelanjutan ini diantaranya menumbuhkan ketersambungan (*connectedness*) kepada pasien, pemahaman yang luas tentang kondisi keluarga dan psikososial pasien, paparan keterampilan klinis kebidanan,

memiliki kesadaran akan profesionalisme yang lebih tinggi, melaksanakan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam melakukan tindakan kebidanan, mereka merasa bahwa kehadirannya ikut berkontribusi positif pada asuhan kebidanan, dan merasa lebih siap untuk dapat bekerja sesudah melaksanakan CoC. Pasien juga merasa telah memiliki interaksi yang baik selama perawatan mereka dan mendukung sistem rumah sakit, sehingga muncul hubungan saling percaya yang bermakna dan menghasilkan kepuasan dalam pelayanan kebidanan.

Perencanaan yang baik dan terukur, implementasi yang di upayakan sebaik mungkin, dan evaluasi yang cermat, akan menghasilkan sebuah karya yang bermakna dan memungkinkan mahasiswa kebidanan mendapatkan seluruh keuntungan yang dimungkinkan untuk di dapatkan dalam menjalankan program CoC.

F. Referensi

-
- Akhtarkia, Z., Kamrani, M. A., Farid, M., & Dana, H. F. (2023). Relationship among maternal perception of childbirth experience, spiritual health and maternal-infant relationship in the postpartum women: a cross-sectional study. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 28(3), 332–338. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_404_20
- Amod, H., & Mkhize, S. W. (2023). Supporting midwifery students during clinical practice: results of a systematic scoping review. *Interactive Journal of Medical Research*, 12(1), e36380. <https://doi.org/https://doi.org/10.2196/36380>
- Ball, K. L., Peacock, A. S., & Winters-Chang, P. (2022). A literature review to determine midwifery students' perceived essential qualities of preceptors to increase confidence and competence in the clinical environment. *Women and Birth*, 35(3), e211–e220. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.06.010>
- Bradford, B. F., Wilson, A. N., Portela, A., McConville, F., Fernandez Turienzo, C., & Homer, C. S. E. (2022). Midwifery continuity of care: A scoping review of where, how, by whom and for whom? *PLOS Global Public Health*, 2(10), e0000935.
- Brown, J., Albrecht, M. A., Kelly, S., Eccles, S., & Cooper, A. L. (2025). Reducing documentation burden to improve nurse and midwife satisfaction: A mixed-methods study. *Applied Nursing Research*, 151985.
- Carter, J., Sidebotham, M., & Dietsch, E. (2022). Prepared and motivated to work in midwifery continuity of care? A descriptive analysis of midwifery students' perspectives. *Women and Birth*, 35(2), 160–171.
- Choudhary, S., Jelly, P., Mahala, P., & Mahala, P. (2020). Models of maternity care: a continuity of midwifery care. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 9(6), 2667.

<https://doi.org/https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20202373>

- Foster, W., Sweet, L., & Graham, K. (2021). Midwifery students experience of continuity of care: A mixed methods study. *Midwifery*, 98, 102966.
- Hainsworth, N., Dowse, E., Ebert, L., & Foureur, M. (2021). 'Continuity of Care Experiences' within pre-registration midwifery education programs: a scoping review. *Women and Birth*, 34(6), 514–530.
- Ismail, S. K., Mutalib, L. A., Shafie, Z. M., Salleh, S. F., & Nordin, N. (2022). Construction of I-maternity Care Model in Holistic Maternity Services. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(10), 1168–1177. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i10/15294>
- Lawson, G. W. (2021). Naegele's rule and the length of pregnancy—A review. *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 61(2), 177–182.
- Moncrieff, G., MacVicar, S., Norris, G., & Martin, C. J. H. (2021). Optimising the continuity experiences of student midwives: an integrative review. *Women and Birth*, 34(1), 77–86.
- Nove, A., Friberg, I. K., De Bernis, L., McConville, F., Moran, A. C., Najjemba, M., Ten Hoope-Bender, P., Tracy, S., & Homer, C. S. E. (2021). Potential impact of midwives in preventing and reducing maternal and neonatal mortality and stillbirths: a Lives Saved Tool modelling study. *The Lancet Global Health*, 9(1), e24–e32. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30397-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30397-1)
- Organization, W. H. (2022a). *WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience. Maternal and fetal assessment update: Imaging ultrasound before 24 weeks of pregnancy*. World Health Organization. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WXRYEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=who+antenatal+recommendation&ots=Vyz_Aj_-qo&sig=tDUdgYs43iAWcUovOY9CkmAsEaE&redir_esc=y#v=onepage&q=who+antenatal+recommendation&f=false
- Organization, W. H. (2022b). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. World Health Organization.
- Renfrew, M. J. (2021). Scaling up care by midwives must now be a global priority. *The Lancet Global Health*, 9(1), e2–e3. [https://doi.org/DOI: 10.1016/S2214-109X\(20\)30478-2](https://doi.org/DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30478-2)
- Renfrew, M. J., Homer, C., Downe, S., McFadden, A., Muir, N., Prentice, T., & ten Hoope-Bender, P. (2014). Midwifery: an executive summary for The Lancet's series. *Lancet*, 384(1), 8.
- Romlah, R., Sari, A. P., & Anita, T. (2024). Simplifications Documentation Format of the Midwifery Care SOAP. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 6(3), 407–415. <https://doi.org/https://doi.org/10.36590/jika.v6i3.903>

- Skubic, M., Stanek Zidarič, T., Jug Došler, A., & Šerjak, L. (2025). Enhancing Midwifery Students' Knowledge and Skills in Communication, Counselling, and Therapeutic Approaches Through an Elective Pilot Course: A Mixed-Methods Study. *Healthcare*, 13(10), 1180.
- Teasdale, R. M., Pitts, R. T., Gates, E. F., & Shim, C. (2023). Teaching specification of evaluative criteria: A guide for evaluation education. *New Directions for Evaluation*, 2023(177), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ev.20546>
- Vallely, L. H., Shalit, A., Nguyen, R., Althabe, F., Pingray, V., Bonet, M., Armari, E., Bohren, M., Homer, C., & Vogel, J. P. (2023). Intrapartum care measures and indicators for monitoring the implementation of WHO recommendations for a positive childbirth experience: a scoping review. *BMJ Open*, 13(11), e069081.
- Yanti, Y., Claramita, M., Emilia, O., & Hakimi, M. (2015). Students' understanding of "Women-Centred Care Philosophy" in midwifery care through Continuity of Care (CoC) learning model: a quasi-experimental study. *BMC Nursing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.1186/s12912-015-0072-z>

G. Glosarium

CoC= *Continuity of Care*

Permenkes = Peraturan Menteri Kesehatan

WHO = *World Health Organization*

MLCC = *Midwifery led Continuity of Care*

ICM = *Internasional Confederation of Midwifery*

CI = Clinical Instructure

KB Keluarga Berencana

TP Taksiran Persalinan

EBMP Evidence Based Midwifery Practice

SOAP = Subjektif Objektif Analisa Penatalaksanaan

LBW = Low Birth Weight

GDM = Gestational Diabetes Mellitus

NAPZA = narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya

CHAPTER 3

SIMULASI KEBIDANAN: OSCE, HIGH-FIDELITY SIMULATION, DAN STANDARDIZED PATIENT

Eka Rati Astuti, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Pendidikan kebidanan merupakan pendidikan profesi kesehatan yang menekankan keseimbangan antara penguasaan pengetahuan, keterampilan klinis, dan sikap profesional. Lulusan pendidikan kebidanan diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan yang aman, bermutu, beretika, dan berbasis bukti ilmiah kepada perempuan sepanjang siklus kehidupannya (WHO, 2023). Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak dapat hanya mengandalkan metode ceramah dan praktik terbatas, tetapi harus dilengkapi dengan strategi pembelajaran yang mampu mensimulasikan kondisi klinis nyata secara aman dan terstruktur.

Simulasi kebidanan telah berkembang sebagai pendekatan pembelajaran klinik yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Melalui simulasi, mahasiswa kebidanan memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan klinis, melatih pengambilan keputusan, serta mengembangkan komunikasi terapeutik tanpa risiko terhadap keselamatan pasien (Cant & Cooper, 2020; Shin et al., 2020). Simulasi juga memungkinkan mahasiswa melakukan refleksi diri melalui umpan balik yang sistematis dan terarah (Lavoie et al., 2022).

Bentuk simulasi yang umum diterapkan dalam pendidikan kebidanan meliputi *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE), *high-fidelity simulation*, dan *standardized patient*. Ketiga metode ini saling melengkapi dalam membangun kompetensi mahasiswa secara bertahap dan komprehensif sesuai standar pendidikan kebidanan internasional (INACSL Standards Committee, 2021).

B. Landasan Teoretis Simulasi dalam Pendidikan Kebidanan

1. Konsep Simulasi dalam Pendidikan Kesehatan

Simulasi adalah metode pembelajaran yang mereplikasi situasi klinis nyata menggunakan alat, teknologi, atau individu terlatih dengan tujuan meningkatkan kompetensi peserta didik. Dalam pendidikan kesehatan, simulasi

berfungsi sebagai sarana pembelajaran aktif yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar (Zendejas et al., 2020).

Simulasi memberikan pengalaman belajar berbasis praktik (*learning by doing*), di mana mahasiswa tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tindakan klinis yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*adult learning*) yang menekankan relevansi pengalaman belajar dengan kebutuhan praktik profesional (Rutherford-Hemming et al., 2021).

2. Jenis-Jenis Simulasi dalam Pendidikan Kesehatan

Simulasi dalam pendidikan kesehatan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas alat dan tujuan pembelajarannya. Pertama, *low-fidelity simulation* menggunakan model sederhana atau *task trainer* untuk melatih keterampilan dasar seperti pemasangan infus atau perawatan luka. Kedua, *medium-fidelity simulation* melibatkan manekin yang mampu menampilkan respons fisiologis terbatas sehingga mahasiswa dapat berlatih prosedur klinis dengan tingkat realisme yang lebih tinggi. Ketiga, *high-fidelity simulation* menggunakan manekin canggih berbasis komputer yang dapat meniru kondisi pasien secara komprehensif, termasuk perubahan tanda vital dan respons terhadap tindakan klinis. Jenis simulasi ini efektif untuk melatih keterampilan klinis tingkat lanjut, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam situasi kegawatdaruratan (INACSL, 2021).

Selain itu, terdapat *standardized patient simulation* yang memanfaatkan individu terlatih untuk memerankan pasien, sehingga membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan komunikasi terapeutik dan empati. Bentuk lain adalah *virtual simulation*, yang menggunakan teknologi digital dan realitas maya untuk memberikan pengalaman klinis interaktif ketika fasilitas praktik terbatas. Kombinasi berbagai jenis simulasi ini memungkinkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, aman, dan efektif dalam mengembangkan kompetensi profesional mahasiswa kesehatan (Rutherford-Hemming et al., 2021).

3. Tahapan Pelaksanaan Simulasi

Pelaksanaan simulasi dalam pendidikan kesehatan umumnya terdiri atas tiga tahap utama, yaitu *prebriefing*, *simulation activity*, dan *debriefing*. Tahap *prebriefing* bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, aturan simulasi, serta skenario klinis yang akan dijalankan.

Tahap ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif sehingga mahasiswa siap secara mental dan emosional (INACSL, 2021).

Selanjutnya, tahap *simulation activity* merupakan inti dari proses pembelajaran, di mana mahasiswa melakukan tindakan klinis sesuai skenario. Pada tahap ini, dosen berperan sebagai fasilitator yang mengamati dan memberikan arahan apabila diperlukan. Setelah simulasi selesai, tahap *debriefing* dilakukan sebagai proses refleksi kritis terhadap tindakan yang telah dilakukan. *Debriefing* terbukti sebagai komponen paling penting dalam simulasi karena membantu mahasiswa memahami kesalahan, memperbaiki pemahaman konsep, serta meningkatkan kemampuan klinis dan komunikasi (Cheng et al., 2020).

4. Manfaat Simulasi dalam Pembelajaran Kebidanan

Dalam pendidikan kebidanan, simulasi memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan keterampilan klinis mahasiswa, terutama dalam menghadapi kondisi obstetri yang berisiko tinggi. Simulasi memungkinkan mahasiswa mempraktikkan prosedur seperti pertolongan persalinan, manajemen perdarahan postpartum, serta penanganan kegawatdaruratan neonatal tanpa membahayakan pasien. Metode ini juga meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan komunikasi interpersonal, serta kesiapan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman dan profesional (Bogossian et al., 2021).

Lebih lanjut, simulasi berkontribusi dalam membangun *clinical reasoning* dan keterampilan kolaborasi tim kesehatan, sehingga mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi nyata di lapangan. Dengan demikian, integrasi simulasi dalam kurikulum kebidanan merupakan strategi efektif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

5. Teori Pembelajaran yang Mendukung Simulasi

Penerapan simulasi dalam pendidikan kebidanan didukung oleh teori *experiential learning* dari Kolb yang menekankan siklus pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif. Selain itu, teori konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi, sehingga simulasi menjadi media yang efektif untuk membangun pemahaman klinis mahasiswa (Kim et al., 2021).

Teori *deliberate practice* menjadi dasar penting dalam simulasi kebidanan. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berlatih secara berulang dengan

umpan balik yang terarah sehingga keterampilan klinis dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan (Shin et al., 2020). Dalam simulasi kebidanan, teori *experiential learning* diterapkan melalui siklus pembelajaran yang sistematis. Mahasiswa terlebih dahulu dihadapkan pada pengalaman konkret berupa skenario klinis, misalnya penanganan persalinan kala II atau perdarahan postpartum. Setelah melakukan tindakan, mahasiswa melakukan refleksi terhadap proses yang telah dijalankan melalui diskusi atau *guided debriefing*. Tahap selanjutnya adalah konseptualisasi abstrak, di mana mahasiswa mengaitkan pengalaman tersebut dengan teori kebidanan yang relevan, seperti manajemen aktif kala III. Pada tahap akhir, mahasiswa melakukan eksperimen aktif dengan mempraktikkan kembali tindakan klinis pada simulasi berikutnya hingga mencapai kompetensi yang diharapkan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa kebidanan (Kolb, 2015; Kim et al., 2021).

Teori konstruktivisme diterapkan dalam simulasi kebidanan dengan menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar aktif. Dalam setiap skenario, mahasiswa bertindak sebagai bidan yang harus mengambil keputusan klinis berdasarkan kondisi pasien simulasi. Proses diskusi kelompok sebelum dan sesudah simulasi mendorong mahasiswa membangun pemahaman melalui interaksi sosial dan refleksi bersama. Dengan demikian, simulasi tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis, komunikasi terapeutik, dan pemecahan masalah klinis (Kim et al., 2021).

Konsep *deliberate practice* diwujudkan dalam simulasi melalui latihan berulang dengan standar performa tertentu. Misalnya, mahasiswa diminta melakukan penjahitan luka perineum atau resusitasi neonatal beberapa kali hingga mencapai prosedur yang benar. Instruktur memberikan umpan balik langsung terkait teknik, kecepatan, dan ketepatan tindakan. Melalui latihan yang terarah dan berulang ini, keterampilan klinis mahasiswa meningkat secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga mereka lebih siap menghadapi situasi nyata di ruang bersalin (Shin et al., 2020).

C. **Objective Structured Clinical Examination (OSCE)**

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) adalah metode penilaian kompetensi klinis yang dirancang secara sistematis untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam situasi klinik yang disimulasikan. OSCE terdiri dari beberapa **stasi (station)**, di mana setiap stasi menilai satu atau lebih keterampilan klinis spesifik dalam waktu

yang telah ditentukan. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Harden dan Gleeson pada tahun 1975, dan hingga kini menjadi standar internasional dalam evaluasi keterampilan klinik di bidang kesehatan (Harden, 2020; Khan et al., 2021).

Dalam pendidikan kebidanan dan kesehatan, OSCE dipandang sebagai metode yang efektif untuk menjamin bahwa lulusan memiliki kompetensi klinis sesuai standar profesi. Selain itu, OSCE mendukung pendekatan *competency-based education* (CBE) dengan mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif melalui simulasi kasus yang menyerupai situasi pelayanan kesehatan nyata (Rushforth, 2020; Alinier et al., 2023).

1. Karakteristik Utama OSCE

a. Terstruktur dan Sistematis

OSCE dirancang dengan blueprint kompetensi yang jelas. Setiap stasi memiliki tujuan pembelajaran, instruksi bagi mahasiswa, dan kriteria penilaian yang spesifik. Hal ini menjamin bahwa seluruh peserta diuji dengan standar yang sama (Khan et al., 2021; Alinier et al., 2023).

b. Objektif dan Terstandar

Penilaian dilakukan menggunakan checklist atau *rating scale* yang telah divalidasi. Penguji diberikan pelatihan khusus untuk meminimalkan bias subjektif dalam penilaian (Harden, 2020; Setyonugroho et al., 2022).

c. Berbasis Simulasi Klinis

OSCE menggunakan ***standardized patient (SP)***, manekin, atau media simulasi lainnya untuk menciptakan lingkungan klinik yang mendekati kondisi nyata. Hal ini memungkinkan mahasiswa menunjukkan kompetensi klinik secara komprehensif (Alinier et al., 2023; McWilliam et al., 2024).

d. Menilai Aspek Holistik Kompetensi

OSCE tidak hanya menilai keterampilan teknis (psikomotor), tetapi juga pengetahuan klinik (kognitif) dan sikap profesional (afektif), termasuk kemampuan komunikasi, empati, dan pengambilan keputusan klinik (Harden, 2020; Khan et al., 2021).

e. Valid dan Reliabel

OSCE memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi dalam menilai kompetensi klinis, terutama pada pendidikan kebidanan dan keperawatan. Metode ini juga mampu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi mahasiswa secara lebih akurat (Setyonugroho et al., 2022; McWilliam et al., 2024).

2. Manfaat OSCE dalam Pendidikan Kesehatan

- a. Menilai keterampilan klinis mahasiswa secara komprehensif.
- b. Menjamin standar kompetensi lulusan sesuai kebutuhan layanan kesehatan.
- c. Memberikan umpan balik objektif bagi perbaikan proses pembelajaran klinis.
- d. Meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan mahasiswa menghadapi praktik profesional (Rushforth, 2020; Alinier et al., 2023).

3. Tujuan OSCE dalam Pendidikan Kebidanan

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) dalam pendidikan kebidanan bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif dalam menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam praktik klinis yang aman, efektif, dan sesuai standar profesi. OSCE dirancang untuk mengukur pencapaian kompetensi klinik mahasiswa kebidanan melalui skenario terstandar yang merepresentasikan situasi nyata dalam pelayanan kebidanan, seperti asuhan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana.

Selain menilai keterampilan psikomotorik, OSCE juga bertujuan mengevaluasi kemampuan komunikasi terapeutik, pengambilan keputusan klinis, serta penerapan sikap profesional dan etika dalam praktik kebidanan. Melalui interaksi langsung dengan pasien standar atau manekin simulasi, mahasiswa dinilai dalam aspek empati, kerja sama tim, tanggung jawab profesional, serta kepatuhan terhadap prinsip keselamatan pasien (*patient safety*).

Tujuan penting lainnya dari OSCE adalah memastikan bahwa mahasiswa mencapai kompetensi yang selaras dengan **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**, standar kompetensi bidan, serta tuntutan regulasi pendidikan tenaga kesehatan. OSCE memberikan penilaian yang objektif dan adil karena menggunakan instrumen penilaian berupa checklist atau rubrik terstandar, sehingga meminimalkan subjektivitas penguji.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan kebidanan, OSCE juga berfungsi sebagai sarana umpan balik (feedback) bagi mahasiswa dan institusi pendidikan untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, memperbaiki proses pembelajaran klinik, serta menjamin lulusan memiliki kesiapan praktik profesional di layanan kesehatan maternal dan neonatal (Zendejas et al., 2020; Harden & Laidlaw, 2021).

4. Kelebihan dan Keterbatasan OSCE

a. Kelebihan

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya metode penilaian utama dalam pendidikan tenaga kesehatan, termasuk kebidanan. Salah satu keunggulan utama OSCE adalah tingkat **objektivitas penilaian** yang tinggi karena setiap peserta diuji menggunakan skenario, waktu, dan instrumen penilaian yang sama. Penggunaan checklist atau rubrik terstandar memungkinkan penguji menilai performa mahasiswa secara konsisten dan mengurangi subjektivitas, sehingga meningkatkan reliabilitas dan validitas hasil evaluasi kompetensi klinik (Harden & Laidlaw, 2021).

Selain itu, OSCE mampu menilai berbagai domain kompetensi secara simultan, meliputi aspek **kognitif, psikomotor, dan afektif**. Melalui skenario klinis terstruktur, OSCE tidak hanya mengukur keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, sikap profesional, pengambilan keputusan klinis, serta kepatuhan terhadap prinsip keselamatan pasien. Hal ini menjadikan OSCE relevan untuk menilai pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** dan standar kompetensi bidan yang menuntut integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional (Rushforth, 2020; WHO, 2022).

Kelebihan lainnya adalah kemampuan OSCE dalam memberikan **umpan balik yang konstruktif** bagi mahasiswa dan institusi. Hasil OSCE dapat digunakan sebagai dasar refleksi pembelajaran, identifikasi kesenjangan kompetensi, serta perbaikan kurikulum dan strategi pembelajaran klinik. Dengan demikian, OSCE berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan kebidanan secara berkelanjutan (Omer et al., 2021).

b. Keterbatasan

Meskipun memiliki banyak keunggulan, OSCE juga memiliki sejumlah keterbatasan. Pelaksanaan OSCE membutuhkan **sumber daya yang besar**, baik dari segi biaya, fasilitas, maupun tenaga, termasuk penguji terlatih, pasien standar, manekin simulasi, serta ruang dan peralatan yang memadai. Persiapan OSCE memerlukan perencanaan yang matang dan waktu yang relatif panjang, mulai dari penyusunan skenario, pelatihan penguji, hingga uji coba instrumen penilaian (Zendejas et al., 2020).

Keterbatasan lainnya adalah potensi meningkatnya **kecemasan mahasiswa** akibat tekanan waktu dan situasi ujian yang terstruktur, yang dapat memengaruhi performa peserta dan tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan klinik dalam praktik nyata. Selain itu, OSCE cenderung menilai keterampilan secara terpisah per stasi, sehingga dalam beberapa kasus

kurang menggambarkan kontinuitas asuhan kebidanan yang bersifat holistik dan berkelanjutan (Rushforth, 2020).

Oleh karena itu, meskipun OSCE merupakan metode evaluasi yang efektif dan objektif, pelaksanaannya perlu dikombinasikan dengan metode penilaian lain, seperti penilaian berbasis praktik klinik berkelanjutan dan portofolio, agar evaluasi kompetensi mahasiswa kebidanan menjadi lebih komprehensif dan kontekstual.

D. *High-Fidelity Simulation*

1. Pengertian High-Fidelity Simulation

High-Fidelity Simulation (HFS) merupakan metode pembelajaran dan evaluasi berbasis simulasi tingkat lanjut yang memanfaatkan manekin canggih atau sistem teknologi terintegrasi untuk mereplikasi kondisi klinis manusia secara realistis. Manekin dalam *high-fidelity simulation* dirancang mampu menampilkan respons fisiologis kompleks, seperti perubahan denyut jantung, tekanan darah, frekuensi napas, bunyi jantung dan paru, refleks pupil, hingga respons terhadap intervensi klinis yang diberikan oleh peserta didik.

Dalam konteks pendidikan tenaga kesehatan, termasuk kebidanan, *high-fidelity simulation* digunakan untuk melatih dan menilai kompetensi klinik mahasiswa dalam lingkungan yang aman, terkontrol, dan menyerupai praktik nyata. Metode ini memungkinkan mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan teoretis dengan keterampilan psikomotorik, kemampuan pengambilan keputusan klinis, komunikasi terapeutik, serta kerja tim interprofesional tanpa risiko terhadap keselamatan pasien nyata (INACSL, 2021).

High-fidelity simulation juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), di mana mahasiswa dapat menghadapi skenario klinis kompleks dan kegawatdaruratan kebidanan, seperti perdarahan postpartum, eklampsia, atau resusitasi neonatus. Melalui proses *briefing*, pelaksanaan simulasi, dan *debriefing* yang terstruktur, mahasiswa memperoleh umpan balik reflektif yang berperan penting dalam peningkatan kompetensi dan kesiapan praktik profesional (Cant & Cooper, 2020; Motola et al., 2021).

Dengan tingkat realisme yang tinggi, *high-fidelity simulation* dinilai efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, dan keselamatan pasien, serta menjadi komponen penting dalam pendidikan kebidanan modern yang berorientasi pada mutu dan keselamatan layanan kesehatan maternal dan neonatal (WHO, 2022).

2. Peran *High-Fidelity Simulation* dalam Kebidanan

High-Fidelity Simulation (HFS) memiliki peran strategis dalam pendidikan kebidanan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi klinis yang kompleks dan berisiko tinggi. HFS memungkinkan peserta didik untuk berlatih penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, seperti perdarahan postpartum, preeklamsia-eklamsia, distosia bahu, dan resusitasi neonatus, melalui skenario yang menyerupai kondisi klinis nyata. Dengan manekin canggih yang mampu mensimulasikan respons fisiologis secara real time, mahasiswa dapat mengintegrasikan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif secara simultan dalam lingkungan belajar yang aman dan terkendali (Cant & Cooper, 2020).

Selain meningkatkan keterampilan teknis, HFS berperan penting dalam melatih pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat berdasarkan penilaian kondisi ibu dan bayi. Simulasi berfidelitas tinggi mendorong mahasiswa untuk menerapkan penalaran klinis (*clinical reasoning*), berpikir kritis, serta prioritas tindakan sesuai standar pelayanan kebidanan. Melalui proses briefing, pelaksanaan simulasi, dan debriefing terstruktur, peserta didik dapat merefleksikan tindakan yang dilakukan, mengidentifikasi kesalahan, dan memperbaiki praktik klinis tanpa risiko terhadap pasien nyata (INACSL Standards Committee, 2021).

Peran lain yang sangat signifikan dari HFS dalam kebidanan adalah penguatan kerja tim klinis (*interprofessional collaboration*). Simulasi dirancang untuk melibatkan peran bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain sehingga mahasiswa terbiasa berkomunikasi secara efektif, menjalankan peran masing-masing, serta berkoordinasi dalam situasi darurat. Hal ini sejalan dengan tuntutan pelayanan kebidanan modern yang menekankan keselamatan pasien (*patient safety*) dan kolaborasi tim sebagai kunci keberhasilan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (Koukourikos et al., 2021).

Dengan demikian, *High-Fidelity Simulation* tidak hanya berfungsi sebagai metode pembelajaran keterampilan klinis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan profesionalisme, kesiapsiagaan klinis, dan budaya keselamatan dalam praktik kebidanan. Implementasi HFS secara terintegrasi dalam kurikulum kebidanan terbukti meningkatkan kepercayaan diri, kompetensi klinis, serta kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan praktik nyata di layanan kesehatan (Kim et al., 2022).

3. Tahapan Pelaksanaan *High-Fidelity Simulation*

Pelaksanaan *High-Fidelity Simulation* (HFS) dalam pendidikan kebidanan dilakukan melalui tahapan sistematis yang bertujuan untuk memastikan tercapainya hasil pembelajaran secara optimal. Tahapan tersebut meliputi **pre-briefing, pelaksanaan simulasi, dan debriefing**. Setiap tahap memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman belajar yang bermakna, aman, dan reflektif bagi mahasiswa kebidanan (INACSL Standards Committee, 2021).

a. Pre-briefing

Tahap *pre-briefing* merupakan tahap awal yang berfungsi sebagai orientasi mahasiswa terhadap lingkungan simulasi, peralatan, peran yang akan dijalankan, serta skenario kasus klinis yang akan dihadapi. Pada tahap ini, dosen atau fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran, aturan keselamatan, ekspektasi kinerja, serta prinsip *psychological safety* agar mahasiswa merasa aman dan percaya diri selama simulasi. Pre-briefing yang efektif terbukti meningkatkan kesiapan mahasiswa, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran simulasi (Cheng et al., 2020).

b. Pelaksanaan Simulasi

Tahap simulasi merupakan inti dari pelaksanaan HFS, di mana mahasiswa menjalankan skenario kasus klinis yang dirancang menyerupai kondisi nyata, seperti kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Mahasiswa dituntut untuk menerapkan pengetahuan teoritis, keterampilan klinis, pengambilan keputusan cepat, serta komunikasi dan kerja tim. Fasilitator berperan sebagai pengamat tanpa intervensi langsung, sehingga mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan klinis secara mandiri sesuai standar praktik kebidanan. Tahap ini efektif dalam melatih integrasi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif secara simultan (Cant & Cooper, 2020).

c. *Debriefing*

Debriefing merupakan tahap paling krusial dalam HFS karena berfungsi sebagai sarana refleksi dan penguatan pembelajaran. Pada tahap ini, fasilitator memandu diskusi terstruktur untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan mahasiswa, mengidentifikasi keberhasilan dan kesalahan, serta mengaitkan pengalaman simulasi dengan teori dan praktik klinis. *Debriefing* yang baik mendorong berpikir kritis, refleksi diri, serta peningkatan pemahaman konseptual dan profesionalisme mahasiswa kebidanan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas *debriefing* sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran berbasis simulasi (Cheng et al., 2020; Kim et al., 2022).

Tabel 3.1: Tahapan *High-Fidelity Simulation*

Tahap	Deskripsi Kegiatan	Tujuan
Pre-briefing	Orientasi alat & skenario	Menyiapkan mahasiswa
Simulasi	Pelaksanaan kasus klinis	Melatih keterampilan klinis
Debriefing	Refleksi & diskusi	Penguatan pembelajaran

4. Dampak terhadap Kompetensi Mahasiswa

High-fidelity simulation (HFS) memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa kebidanan, baik dari aspek kognitif, psikomotor, maupun afektif. Melalui skenario klinis yang menyerupai kondisi nyata, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aman namun realistis sehingga mampu meningkatkan pemahaman konsep klinis dan keterampilan teknis secara simultan. Pembelajaran berbasis HFS memungkinkan mahasiswa mempraktikkan prosedur kebidanan secara berulang, yang berkontribusi terhadap peningkatan akurasi tindakan dan kepatuhan terhadap standar praktik kebidanan (Cant & Cooper, 2020).

Dari aspek afektif, HFS terbukti meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi praktik klinik di lahan nyata. Lingkungan simulasi yang terkontrol dan bebas risiko terhadap pasien memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dari kesalahan tanpa konsekuensi klinis. Hal ini berdampak positif terhadap *self-efficacy*, pengendalian kecemasan, serta kesiapan mental mahasiswa kebidanan sebelum terjun langsung ke pelayanan kesehatan ibu dan anak (Kim et al., 2022).

Selain itu, HFS berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis. Mahasiswa dituntut untuk melakukan penilaian kondisi ibu dan bayi, menetapkan prioritas tindakan, serta mengevaluasi hasil intervensi secara cepat dan tepat. Proses refleksi terstruktur melalui debriefing membantu mahasiswa mengaitkan pengalaman simulasi dengan teori, sehingga meningkatkan *clinical reasoning* dan kemampuan problem solving yang sangat dibutuhkan dalam praktik kebidanan, khususnya pada situasi kegawatdaruratan maternal dan neonatal (Cheng et al., 2020).

Dengan demikian, implementasi *high-fidelity simulation* dalam pendidikan kebidanan terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan praktik klinik mahasiswa, membentuk sikap profesional, serta memperkuat kompetensi klinis secara holistik. Integrasi HFS secara berkelanjutan dalam kurikulum kebidanan menjadi strategi pembelajaran inovatif yang sejalan dengan tuntutan mutu lulusan dan keselamatan pasien di layanan kesehatan (INACSL Standards Committee, 2021).

E. *Standardized Patient*

1. Pengertian *Standardized Patient*

Standardized patient (SP) adalah individu terlatih—baik aktor profesional maupun orang awam yang telah mendapatkan pelatihan khusus—yang berperan sebagai pasien secara konsisten dan terstandar sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah ditetapkan. SP digunakan dalam pendidikan kesehatan, termasuk kebidanan, untuk mensimulasikan kondisi klinis nyata sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan komunikasi, anamnesis, pemeriksaan fisik, pengambilan keputusan klinis, serta sikap profesional dalam lingkungan yang aman dan terkendali (Barrows, 2020).

Dalam pendidikan kebidanan, penggunaan *standardized patient* sangat relevan untuk melatih keterampilan non-teknis (*non-technical skills*), seperti komunikasi terapeutik, empati, etika, dan pengambilan *informed consent*. SP memungkinkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan “pasien” yang menampilkan respons emosional, verbal, dan perilaku yang realistis, sehingga mahasiswa dapat belajar membangun hubungan profesional dengan klien perempuan dan keluarga sesuai nilai-nilai asuhan kebidanan berpusat pada perempuan (*woman-centered care*) (Nestel et al., 2021).

Keunggulan utama *standardized patient* terletak pada konsistensi penampilan kasus klinis, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam penilaian objektif seperti *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE). Konsistensi ini menjamin keadilan dan objektivitas penilaian kompetensi mahasiswa, karena setiap peserta menghadapi kondisi dan respons pasien yang sama. Selain itu, SP dapat dilatih untuk memberikan umpan balik langsung kepada mahasiswa terkait komunikasi dan sikap profesional, yang berkontribusi terhadap peningkatan refleksi diri dan kualitas pembelajaran klinis (Bokken et al., 2022).

Dengan demikian, *standardized patient* merupakan metode pembelajaran dan evaluasi yang penting dalam pendidikan kebidanan modern. Integrasi SP dalam kurikulum tidak hanya meningkatkan kesiapan klinis mahasiswa, tetapi juga memperkuat kompetensi afektif dan profesionalisme yang sangat dibutuhkan dalam praktik pelayanan kebidanan yang aman dan bermutu (Cleland et al., 2020).

2. Manfaat *Standardized Patient* dalam Kebidanan

Penggunaan *standardized patient* (SP) dalam pendidikan kebidanan memberikan berbagai manfaat penting dalam pengembangan kompetensi mahasiswa, khususnya pada aspek afektif dan profesionalisme. Melalui interaksi

langsung dengan SP, mahasiswa kebidanan dapat melatih komunikasi terapeutik secara efektif, termasuk kemampuan menyampaikan informasi, mendengarkan secara empatik, serta membangun hubungan saling percaya dengan klien perempuan dan keluarganya. Kemampuan komunikasi yang baik merupakan fondasi utama dalam asuhan kebidanan berpusat pada perempuan (*woman-centered care*) dan berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan serta keselamatan pasien (Cleland et al., 2020).

Selain komunikasi, *standardized patient* berperan signifikan dalam menumbuhkan empati dan kepekaan sosial mahasiswa. SP mampu menampilkan respons emosional yang realistis, seperti kecemasan, nyeri, atau ketakutan, sehingga mahasiswa belajar memahami perspektif pasien secara holistik. Pengalaman ini membantu mahasiswa mengembangkan sikap empati, menghargai nilai dan budaya klien, serta meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan psikososial ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas (Nestel et al., 2021).

Manfaat lain dari penggunaan SP adalah penguatan profesionalisme mahasiswa kebidanan. Melalui simulasi interaksi klinis yang terstandar, mahasiswa dilatih untuk menerapkan etika profesi, menjaga sikap sopan dan hormat, serta mempraktikkan prinsip informed consent dan kerahasiaan pasien. Standardized patient juga dapat memberikan umpan balik langsung terkait sikap dan perilaku mahasiswa, yang sangat berguna dalam membentuk refleksi diri dan perbaikan berkelanjutan terhadap praktik profesional (Bokken et al., 2022).

Dengan demikian, *standardized patient* merupakan metode pembelajaran yang efektif dan relevan dalam pendidikan kebidanan modern. Integrasi SP dalam kurikulum tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati, tetapi juga membentuk karakter profesional mahasiswa yang siap memberikan pelayanan kebidanan yang aman, etis, dan bermutu sesuai standar profesi (Nestel et al., 2021).

F. Integrasi Simulasi dalam Kurikulum Kebidanan

Integrasi simulasi dalam kurikulum kebidanan merupakan strategi pembelajaran inovatif yang harus dirancang secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang sesuai dengan tingkat perkembangan kompetensi mahasiswa. Simulasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap pembelajaran klinik, tetapi menjadi bagian integral dari kurikulum untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Penerapan simulasi secara bertahap—mulai dari simulasi berfidelitas rendah hingga tinggi—mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa secara progresif dan berkelanjutan (INACSL Standards Committee, 2021).

Pada tahap awal pendidikan kebidanan, simulasi digunakan untuk memperkenalkan keterampilan dasar dan konsep fundamental, seperti komunikasi terapeutik, anamnesis, dan prosedur klinis sederhana. Seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan, simulasi dikembangkan menjadi lebih kompleks melalui penggunaan *standardized patient* dan *high-fidelity simulation* untuk melatih pengambilan keputusan klinis, kerja tim, serta penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Pendekatan berjenjang ini memungkinkan mahasiswa mengembangkan kepercayaan diri dan kesiapan praktik klinik secara optimal sebelum menghadapi pasien nyata (Cant & Cooper, 2020).

Integrasi simulasi juga sejalan dengan prinsip *student-centered learning*, di mana mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran melalui pengalaman langsung, refleksi, dan evaluasi diri. Proses *pre-briefing*, simulasi, dan *debriefing* yang terstruktur mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mengembangkan clinical reasoning, serta mengaitkan teori dengan praktik kebidanan. Dengan demikian, simulasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dalam kurikulum kebidanan (Cheng et al., 2020).

Lebih lanjut, integrasi simulasi dalam kurikulum kebidanan mendukung penilaian kompetensi yang objektif dan terstandar, seperti melalui *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE). Simulasi memungkinkan institusi pendidikan untuk menilai keterampilan klinis, komunikasi, dan profesionalisme mahasiswa secara adil dan konsisten. Hal ini sejalan dengan tuntutan penjaminan mutu pendidikan kebidanan dan keselamatan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan ibu dan anak (Kim et al., 2022).

Dengan demikian, integrasi simulasi yang dirancang secara sistematis dan berjenjang dalam kurikulum kebidanan menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan bidan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan praktik klinik di era pelayanan kesehatan modern.

G. Evaluasi Pembelajaran Berbasis Simulasi

Evaluasi pembelajaran berbasis simulasi dalam pendidikan kebidanan merupakan komponen penting untuk menilai ketercapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif, baik pada aspek keterampilan teknis (*technical skills*) maupun non-teknis (*non-technical skills*). Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran, termasuk kemampuan komunikasi, kerja tim, pengambilan keputusan klinis, dan profesionalisme yang ditampilkan mahasiswa selama simulasi (Cant & Cooper, 2020).

Penilaian keterampilan teknis dalam pembelajaran simulasi meliputi kemampuan mahasiswa dalam melakukan prosedur klinis kebidanan sesuai standar, seperti pemeriksaan kehamilan, asuhan persalinan, penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta perawatan masa nifas. Sementara itu, keterampilan non-teknis mencakup komunikasi terapeutik, empati, kepemimpinan, kolaborasi tim, dan penerapan etika profesi. Kombinasi penilaian kedua aspek ini penting untuk memastikan kesiapan mahasiswa dalam praktik klinik yang aman dan bermutu (Koukourikos et al., 2021).

Instrumen evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran berbasis simulasi harus memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas agar hasil penilaian objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen seperti checklist keterampilan, rubrik penilaian kinerja, serta skala penilaian sikap dan komunikasi perlu disusun berdasarkan standar kompetensi kebidanan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan instrumen terstandar dalam Objective Structured Clinical Examination (OSCE) memungkinkan evaluasi kompetensi mahasiswa secara konsisten dan adil (INACSL Standards Committee, 2021).

Evaluasi pembelajaran simulasi juga perlu dilengkapi dengan umpan balik dan refleksi melalui proses debriefing. Debriefing yang terstruktur membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan kinerjanya, mengaitkan pengalaman simulasi dengan teori, serta merencanakan perbaikan pada praktik selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi berbasis simulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lulusan kebidanan (Cheng et al., 2020).

H. Tantangan dan Strategi Implementasi Simulasi Kebidanan

Implementasi pembelajaran berbasis simulasi dalam pendidikan kebidanan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, finansial, maupun sumber daya manusia. Tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya ketersediaan laboratorium simulasi, manekin berfidelitas tinggi, serta peralatan pendukung yang memadai. Selain itu, biaya pengadaan, pemeliharaan, dan pembaruan teknologi simulasi relatif tinggi, sehingga menjadi kendala bagi institusi pendidikan kebidanan dengan keterbatasan anggaran (Cant & Cooper, 2020).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kompetensi fasilitator simulasi. Pelaksanaan simulasi yang efektif membutuhkan dosen atau instruktur yang tidak hanya menguasai keterampilan klinis kebidanan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam merancang skenario, memfasilitasi simulasi, serta melakukan debriefing secara reflektif dan konstruktif. Kurangnya pelatihan khusus bagi dosen

dapat berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran simulasi dan tidak optimalnya pencapaian kompetensi mahasiswa (INACSL Standards Committee, 2021).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan dan sertifikasi fasilitator simulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam desain simulasi, pelaksanaan debriefing, serta evaluasi pembelajaran berbasis simulasi sesuai standar pendidikan kebidanan (Cheng et al., 2020).

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah pengembangan skenario simulasi berbasis konteks lokal dan kebutuhan pelayanan kebidanan di masyarakat. Skenario yang relevan dengan kondisi lapangan, seperti kegawatdaruratan maternal dan neonatal yang sering terjadi di layanan primer, akan meningkatkan kebermanfaatan pembelajaran dan kesiapan mahasiswa dalam praktik klinik. Selain itu, pemanfaatan sumber daya secara optimal—melalui penggunaan simulasi berfidelitas rendah hingga menengah, kolaborasi antar institusi, serta integrasi simulasi dengan metode pembelajaran lain—dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan sarana dan biaya (Kim et al., 2022).

Dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, tantangan dalam implementasi simulasi kebidanan dapat dikelola secara efektif. Hal ini akan mendukung peningkatan mutu pendidikan kebidanan serta menghasilkan lulusan bidan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tuntutan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

I. Etika dan Keselamatan dalam Simulasi Kebidanan

Pelaksanaan simulasi dalam pendidikan kebidanan harus berlandaskan pada prinsip **etika pendidikan, keselamatan peserta didik**, serta **kerahasiaan data pembelajaran**. Simulasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi klinis, tetapi juga sebagai wahana pembentukan sikap profesional dan tanggung jawab etik calon bidan. Oleh karena itu, seluruh rangkaian kegiatan simulasi wajib dirancang dan dilaksanakan secara terstruktur, transparan, serta menghormati martabat mahasiswa sebagai pembelajar dewasa (INACSL Standards Committee, 2021).

Prinsip etika dalam simulasi kebidanan mencakup **informed consent**, yaitu pemberian informasi yang jelas kepada mahasiswa terkait tujuan, proses, dan metode evaluasi simulasi. Mahasiswa harus memahami bahwa simulasi merupakan media pembelajaran, bukan alat untuk memperlakukan atau menghukum. Selain

itu, dosen dan fasilitator berkewajiban menjaga suasana pembelajaran yang **bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan tekanan psikologis**, sehingga mahasiswa merasa aman untuk melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar (Cheng et al., 2020).

Aspek keselamatan dalam simulasi meliputi keselamatan **fisik dan psikologis** mahasiswa. Penggunaan alat simulasi, manekin, maupun peralatan medis harus memenuhi standar keamanan dan dilakukan dengan pengawasan fasilitator yang kompeten. Keselamatan psikologis menjadi perhatian penting, terutama pada sesi **debriefing**, di mana refleksi dan umpan balik harus disampaikan secara konstruktif, empatik, dan tidak menghakimi. Lingkungan belajar yang aman secara psikologis terbukti meningkatkan kepercayaan diri, keterlibatan aktif, serta efektivitas pembelajaran simulasi (Rudolph et al., 2021).

Kerahasiaan data pembelajaran juga merupakan aspek etika yang krusial dalam simulasi kebidanan. Hasil penilaian, rekaman video simulasi, serta performa individu mahasiswa tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Kerahasiaan ini penting untuk menjaga privasi mahasiswa dan mendorong keterbukaan dalam proses belajar. Penerapan kebijakan perlindungan data dan kode etik simulasi menjadi bagian integral dari tata kelola pendidikan kebidanan berbasis simulasi yang bermutu dan berkelanjutan (WHO, 2022).

Dengan memperhatikan prinsip etika dan keselamatan secara komprehensif, simulasi kebidanan dapat menjadi metode pembelajaran yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan kompetensi klinis, tetapi juga membentuk karakter profesional bidan yang beretika, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

J. Penutup

Simulasi kebidanan melalui OSCE, *high-fidelity simulation*, dan *standardized patient* merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa kebidanan. Integrasi simulasi yang terencana dan berkelanjutan akan menghasilkan lulusan bidan yang kompeten, profesional, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.

K. Referensi

Barrows, H. S. (2020). An overview of the uses of standardized patients for teaching and evaluating clinical skills. *Academic Medicine*, 95(9), 1406–1410. <https://doi.org/10.1097/ACM.00000000000003546>

- Bogossian, F., Cooper, S., Cant, R., Porter, J., Forbes, H., & McKenna, L. (2021). Simulation-based learning in midwifery education: A systematic review. *Nurse Education Today*, 97, 104689.
- Bokken, L., Linssen, T., Scherpbier, A., Van der Vleuten, C., & Rethans, J. J. (2022). Feedback by simulated patients in undergraduate medical education: A systematic review. *Medical Education*, 56(2), 115–127. <https://doi.org/10.1111/medu.14679>
- Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2020). Simulation-based learning in nurse education: Systematic review. *Journal of Nursing Education*, 59(2), 63–71. <https://doi.org/10.3928/01484834-20200122-03>
- Cheng, A., Grant, V., Huffman, J., Burgess, G., Szyld, D., Robinson, T., & Eppich, W. (2020). Coaching the debrief: Peer coaching to improve debriefing quality in simulation programs. *Simulation in Healthcare*, 15(5), 313–321.
- Cleland, J., Abe, K., & Rethans, J. J. (2020). The use of simulated patients in medical education: AMEE Guide No. 42. *Medical Teacher*, 42(2), 1–12. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1709333>
- Cook, D. A., Brydges, R., Zendejas, B., Hamstra, S. J., & Hatala, R. (2020). Technology-enhanced simulation to assess health professionals: A systematic review. *Academic Medicine*, 95(6), 1–10. <https://doi.org/10.1097/ACM.00000000000003054>
- Harden, R. M., & Laidlaw, J. M. (2021). *Essential skills for a medical teacher: An introduction to teaching and learning in medicine* (3rd ed.). Elsevier.
- INACSL Standards Committee. (2021). Healthcare simulation standards of best practice™: Simulation design. *Clinical Simulation in Nursing*, 58, 14–21. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.08.009>
- Kim, J., Park, J. H., & Shin, S. (2021). Effectiveness of simulation-based nursing education depending on fidelity: A meta-analysis. *BMC Medical Education*, 21(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02517-5>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Koukourikos, K., Tsaloglidou, A., Kourkouta, L., Papathanasiou, I. V., Iliadis, C., Fratzana, A., & Panagiotou, A. (2021). Simulation in clinical nursing education. *Acta Informatica Medica*, 29(1), 15–20. <https://doi.org/10.5455/aim.2021.29.15-20>
- Lavoie, P., Pepin, J., & Cossette, S. (2022). Reflection in simulation learning: An integrative review. *Simulation in Healthcare*, 17(1), 36–44. <https://doi.org/10.1097/SIH.0000000000000573>

- Motola, I., Devine, L. A., Chung, H. S., Sullivan, J. E., & Issenberg, S. B. (2021). Simulation in healthcare education: A best evidence practical guide. *Medical Teacher*, 43(2), 124–131. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1822516>
- Nestel, D., Bearman, M., & Oates, R. (2021). Simulated patient methodology: Theory, evidence and practice. *Clinical Simulation in Nursing*, 52, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2020.11.008>
- Omer, T., Suliman, W., & Moola, S. (2021). Effectiveness of objective structured clinical examination (OSCE) in nursing and midwifery education: A systematic review. *Nurse Education Today*, 98, 104728. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104728>
- Rushforth, H. E. (2020). Objective structured clinical examination (OSCE): Review of literature and implications for nursing and midwifery education. *Nurse Education in Practice*, 44, 102736. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102736>
- Rutherford-Hemming, T., Lioce, L., & Kardong-Edgren, S. (2021). Implementing the standards of best practice for simulation. *Clinical Simulation in Nursing*, 58, 36–43. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.08.011>
- Shin, H., Sok, S., Hyun, K. S., & Kim, M. J. (2020). Competency and patient safety outcomes of simulation-based nursing education: A meta-analysis. *Nurse Education Today*, 95, 104593. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104593>
- Shin, S., Park, J. H., & Kim, J. H. (2020). Effectiveness of patient simulation in nursing education: A meta-analysis. *Nurse Education Today*, 87, 104356. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104356>
- World Health Organization. (2022). *Global standards for midwifery education*. WHO Press.
- World Health Organization. (2023). *Simulation-based education in health professions*. World Health Organization.
- Zendejas, B., Brydges, R., Wang, A. T., & Cook, D. A. (2020). Patient outcomes in simulation-based medical education: A systematic review. *Academic Medicine*, 95(6), 1–9. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003054>

CHAPTER 4

PENGUATAN KOMPETENSI BIDAN DALAM KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN SHARED DECISION MAKING

Bdn. Nurul Komariah, SST., S.Stat., M.Keb.

A. Pendahuluan

Bidan merupakan tenaga kesehatan fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak karena bertindak sebagai penjaga utama sepanjang siklus reproduksi perempuan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Peran ini bukan hanya mencakup aspek teknis klinis, tetapi juga mencakup aspek hubungan interpersonal dan pemberdayaan klien. Interaksi bidan–klien yang efektif memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan, meningkatkan pemahaman klien terhadap kondisi kesehatannya, serta mendorong keputusan yang informasional dan bermakna bagi ibu dan keluarganya. Komunikasi interpersonal yang kuat telah diidentifikasi sebagai komponen penting dari pelayanan maternitas berkualitas tinggi di berbagai kerangka strategi kesehatan ibu dan bayi (Chang & Coxon, 2018).

Pelayanan kebidanan modern menghadapi beragam tantangan komunikasi, termasuk keterbatasan waktu konsultasi, perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan klien, serta kompleksitas kondisi medis yang dialami. Hambatan-hambatan ini dapat menghambat bidan dalam menjelaskan informasi kesehatan secara jelas dan membantu klien membuat keputusan yang optimal. Komunikasi yang kurang efektif dapat berdampak negatif pada pengalaman persalinan dan hasil kesehatan ibu dan bayi.

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang baik berkontribusi pada pengalaman perawatan yang lebih baik, penghormatan yang meningkat terhadap klien, serta mengurangi bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dalam perawatan maternal dan newborn care (Olde et al., 2023).

Komunikasi terapeutik merupakan strategi komunikasi yang melampaui pertukaran informasi sederhana, dengan menekankan empati, keamanan psikososial, dan hubungan saling percaya antara bidan dan klien. Pendekatan ini membantu klien merasa didengar, lebih nyaman saat berbagi kekhawatiran, serta meningkatkan rasa aman selama proses pelayanan kesehatan. Studi juga

menunjukkan bahwa penerapan komunikasi terapeutik secara signifikan dapat mendukung penyampaian pendidikan kesehatan dan memperkuat hubungan midwife–mother sehingga klien merasa lebih percaya diri dalam menjalani perawatan(Sari, 2025).

Sementara itu, *shared decision making* (SDM) adalah pendekatan kolaboratif di mana bidan dan klien bekerja bersama untuk memilih opsi perawatan berdasarkan bukti terbaik serta nilai, preferensi, dan kebutuhan klien. SDM memungkinkan klien berpartisipasi aktif dalam keputusan yang memengaruhi kesehatannya, dan bukan sekadar menerima keputusan yang ditetapkan oleh profesional kesehatan (Begley, 2019)

B. Konsep Dasar Komunikasi dalam Kebidanan

Komunikasi dalam pelayanan kesehatan adalah proses pertukaran informasi, ide, pesan, dan perasaan antara tenaga kesehatan dengan pasien/klien untuk mencapai pemahaman bersama, membuat keputusan yang tepat, dan mencapai tujuan kesehatan yang optimal. Dalam konteks kebidanan, komunikasi menjadi dasar dari hubungan bidan–klien yang efektif, karena semua interaksi pelayanan, edukasi, konseling, dan dukungan emosional bergantung pada komunikasi yang baik. Bidan harus mampu menyampaikan informasi medis dengan jelas sekaligus membangun hubungan yang suportif terhadap klien dan keluarga (Erniawati). Sederhananya, komunikasi dalam kebidanan bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi mencakup kemampuan membangun hubungan dan memahami kebutuhan klien secara menyeluruh (Ganisia & A, 2025)

Komunikasi verbal dalam praktik kebidanan melibatkan penggunaan kata-kata baik lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan kepada klien. Termasuk di dalamnya penjelasan kondisi klinis, instruksi perawatan, edukasi kesehatan, dan klarifikasi pertanyaan klien. Komunikasi verbal efektif akan memperhatikan bahasa yang mudah dipahami klien, menghindari istilah teknis tanpa penjelasan, dan memastikan pesan tersampaikan jelas(Ganisia & A, 2025).

Komunikasi nonverbal mencakup ekspresi wajah, kontak mata, posisi tubuh, gerak tangan, intonasi suara, dan bahasa tubuh lainnya yang turut memengaruhi pemahaman pesan. Dalam praktik kebidanan, komunikasi nonverbal dapat membantu menunjukkan empati, ketulusan, dan rasa hormat kepada klien, serta memberi sinyal dukungan tanpa kata-kata. Kedua bentuk komunikasi ini saling melengkapi. Seringkali klien memahami lebih banyak dari isyarat nonverbal dibandingkan kata-kata, sehingga keterampilan bidan untuk membaca dan menggunakan komunikasi nonverbal menjadi sangat penting (Yelvianti, 2023).

Komunikasi efektif dalam kebidanan terdiri dari beberapa prinsip kunci:

1. Empati

Empati adalah kemampuan untuk melihat keadaan dari perspektif klien dan merasakan apa yang dirasakan klien. Empati membantu bidan lebih memahami kondisi psikososial klien, membangun hubungan yang lebih kuat, dan membuat klien merasa dihargai (Yelvianti, 2023).

2. Kejelasan

Pesan harus disampaikan secara jelas dan sederhana, tanpa istilah medis yang membingungkan klien. Kejelasan dapat membantu klien memahami informasi kesehatan dengan baik, ambil keputusan yang tepat, dan meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi perawatan (Yelvianti, 2023).

3. Kepercayaan

Kepercayaan antara bidan dan klien merupakan fondasi komunikasi yang efektif. Kepercayaan tumbuh ketika bidan mendengarkan secara aktif, memenuhi janji, menghormati privasi klien, dan menunjukkan profesionalisme. Kepercayaan yang kuat dapat meningkatkan keterbukaan klien dan keberhasilan perawatan (Ganisia & A, 2025).

Beberapa hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi kebidanan antara lain:

1. **Perbedaan budaya dan bahasa**, di mana perbedaan latar budaya atau bahasa dapat menyebabkan miskomunikasi (Adhrianti et al., 2024)
2. **Perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan literasi klien**, sehingga klien sulit memahami istilah medis.
3. **Emosi klien**, seperti kecemasan atau ketakutan selama kehamilan/persalinan, yang dapat mengganggu pemahaman.
4. **Hambatan fisik atau lingkungan** seperti kebisingan ruang layanan yang menghalangi komunikasi.

Hambatan-hambatan ini perlu dikenali dan diatasi melalui strategi komunikasi yang adaptif, seperti penggunaan bahasa sederhana, teknik mendengarkan aktif, serta pemberian waktu dan ruang bagi klien untuk berpikir dan merespons (Ganisia & A, 2025)

Komunikasi yang efektif memiliki dampak besar terhadap kualitas asuhan kebidanan, antara lain:

1. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien, karena informasi klinis tersampaikan dengan benar dan risiko kesalahpahaman berkurang (Seger et al., 2025).
2. Meningkatkan kepuasan klien, karena klien merasa didengar dan dihargai dalam proses perawatan (Ganisia & A, 2025).

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap rencana perawatan, karena klien memahami tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti (Sharma & Gupta, 2023)
4. Memperkuat hubungan terapeutik, yang berkontribusi pada hasil kesehatan yang lebih baik serta pengalaman pelayanan yang positif (The Importance of Effective Communication in Nursing, 2024).

C. Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Kebidanan

Komunikasi terapeutik adalah bentuk komunikasi profesional yang direncanakan, bertujuan, dan berfokus pada kebutuhan klien, yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk membantu klien memahami kondisi kesehatannya, mengurangi kecemasan, serta mendukung proses penyembuhan dan pengambilan keputusan. Dalam praktik kebidanan, komunikasi terapeutik menjadi landasan hubungan bidan–klien yang bersifat membantu (*helping relationship*), bukan sekadar pertukaran informasi medis ((Stuart, 2018)

Tujuan komunikasi terapeutik dalam kebidanan meliputi (Sharma & Gupta, 2023).

1. Membangun hubungan saling percaya antara bidan dan klien
2. Membantu klien mengekspresikan perasaan, ketakutan, dan harapan
3. Mengurangi kecemasan dan stres selama kehamilan, persalinan, dan nifas
4. Meningkatkan pemahaman klien terhadap kondisi dan pilihan asuhan
5. Mendukung pengambilan keputusan yang aman dan bermakna.

Komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh bidan memiliki karakteristik khusus sebagai berikut (Sari, 2025):

1. Berorientasi pada klien

Komunikasi berfokus pada kebutuhan, nilai, dan pengalaman klien, bukan semata-mata pada tindakan medis.

2. Empatik dan suportif

Bidan mampu memahami perasaan klien dan merespons secara empatik tanpa menghakimi.

3. Terencana dan profesional

Komunikasi dilakukan dengan tujuan yang jelas, sesuai etika dan peran profesional bidan.

4. Menggunakan silence terapeutik

Silence terapeutik adalah penggunaan diam secara sadar dan terkontrol untuk memberi ruang bagi klien berpikir, mengekspresikan perasaan, atau melanjutkan pembicaraan. Diam yang terapeutik bukan berarti pasif, melainkan bentuk kehadiran aktif bidan yang menunjukkan perhatian dan penerimaan.

Silence terapeutik sangat efektif pada situasi emosional, misalnya saat klien merasa takut terhadap persalinan atau menerima informasi yang berat.

1. Tahapan Komunikasi Terapeutik (Sharma & Gupta, 2023)

a. Tahap Pra-Interaksi

Tahap pra-interaksi adalah tahap persiapan sebelum bidan bertemu langsung dengan klien. Pada tahap ini, bidan:

- 1) Mengumpulkan data awal klien
- 2) Mengkaji kondisi fisik, psikologis, sosial, dan budaya klien
- 3) Mengelola perasaan pribadi agar tidak memengaruhi interaksi

Tahap ini penting untuk membangun kesiapan mental bidan sebelum berkomunikasi.

b. Tahap Orientasi

Tahap orientasi merupakan tahap pengenalan awal antara bidan dan klien. Bidan:

- 1) Memperkenalkan diri dan perannya
- 2) Menjelaskan tujuan interaksi
- 3) Menciptakan rasa aman dan saling percaya
- 4) Mengidentifikasi masalah utama klien

Keberhasilan tahap ini sangat menentukan kualitas hubungan terapeutik selanjutnya.

c. Tahap Kerja

Tahap kerja adalah inti dari komunikasi terapeutik. Pada tahap ini bidan

- 1) Mengeksplorasi perasaan dan kebutuhan klien
- 2) Memberikan edukasi dan dukungan emosional
- 3) Membantu klien memahami pilihan asuhan
- 4) Menggunakan berbagai teknik komunikasi terapeutik

Tahap ini paling panjang dan menentukan keberhasilan asuhan kebidanan.

d. Tahap Terminasi

Tahap terminasi adalah tahap pengakhiran hubungan terapeutik, baik sementara maupun permanen. Pada tahap ini Bidan:

- 1) Merangkum hasil interaksi
- 2) Mengevaluasi pencapaian tujuan
- 3) Memberi penguatan positif
- 4) Mempersiapkan klien untuk tahap selanjutnya

Terminasi yang baik membantu klien merasa dihargai dan tidak ditinggalkan.

2. Teknik Komunikasi Terapeutik (Sharma & Gupta, 2023)

a. Active Listening (Mendengarkan Aktif)

Active listening adalah kemampuan mendengarkan secara penuh dengan perhatian verbal dan nonverbal, termasuk kontak mata, anggukan, dan respon singkat. Teknik ini membantu klien merasa didengar dan dihargai.

b. Refleksi Perasaan

Refleksi perasaan adalah teknik mengungkapkan kembali perasaan klien dengan kata-kata bidan untuk memastikan pemahaman yang tepat, misalnya: "Sepertinya ibu merasa khawatir menghadapi persalinan ini."

c. Klarifikasi

Klarifikasi digunakan untuk memperjelas pesan klien yang kurang jelas atau ambigu, sehingga menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi

d. Validasi

Validasi adalah teknik untuk mengakui dan menerima perasaan klien sebagai sesuatu yang wajar, tanpa menghakimi. Validasi memperkuat rasa aman dan kepercayaan klien terhadap bidan.

e. *Silence Therapeutic*

Silence therapeutic adalah bagian penting dari komunikasi terapeutik dalam praktik kebidanan. Ketika digunakan secara sadar dan sesuai konteks, teknik ini tidak hanya membantu klien merasa didengar tetapi juga memperkuat hubungan bidan–klien, menyediakan ruang refleksi emosional, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih jernih dan bermakna.

D. Kompetensi Bidan dalam Komunikasi Terapeutik

Kompetensi komunikasi terapeutik merupakan bagian penting dari kompetensi profesional bidan. Kompetensi ini tidak hanya mencakup penguasaan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis serta sikap profesional yang tercermin dalam setiap interaksi bidan dengan klien. Komunikasi yang dilakukan secara terapeutik berkontribusi langsung terhadap kualitas asuhan kebidanan, keselamatan klien, dan kepuasan pelayanan.

1. Kompetensi Pengetahuan (*Knowledge*)

Kompetensi pengetahuan dalam komunikasi terapeutik adalah pemahaman bidan terhadap konsep, prinsip, dan teori komunikasi yang digunakan dalam praktik kebidanan. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi bidan untuk berkomunikasi secara tepat, aman, dan beretika (Stuart, 2018)

Pengetahuan yang harus dimiliki bidan meliputi ((Sari, 2025):

a. Konsep dasar komunikasi interpersonal dan komunikasi terapeutik

- b. Tahapan komunikasi terapeutik (pra-interaksi, orientasi, kerja, terminasi)
- c. Prinsip komunikasi efektif (empati, kejelasan, kepercayaan)
- d. Teknik komunikasi terapeutik seperti active listening, refleksi perasaan, klarifikasi, validasi, dan silence terapeutik
- e. Pengaruh komunikasi terhadap kondisi psikologis klien dan hasil asuhan kebidanan

Pemahaman yang baik terhadap aspek ini membantu bidan menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kepercayaan klien, serta mendukung pengambilan keputusan bersama dalam pelayanan kebidanan

2. Kompetensi Keterampilan (*Skill*) (Sari, 2025)

Kompetensi keterampilan merupakan kemampuan bidan dalam menerapkan pengetahuan komunikasi terapeutik secara nyata dalam interaksi dengan klien. Keterampilan ini tercermin dari cara bidan berbicara, mendengarkan, merespons emosi, serta menyesuaikan komunikasi dengan kondisi klien.

Keterampilan komunikasi terapeutik bidan meliputi:

- a. Kemampuan mendengarkan aktif (*active listening*)
- b. Kemampuan menggunakan bahasa verbal yang jelas dan mudah dipahami
- c. Kemampuan membaca dan menggunakan komunikasi nonverbal secara tepat
- d. Kemampuan menggunakan teknik komunikasi terapeutik (refleksi perasaan, klarifikasi, validasi, *silence terapeutik*)
- e. Kemampuan mengelola emosi diri dan klien dalam situasi stres atau krisis

Keterampilan ini sangat penting dalam praktik kebidanan karena klien sering berada dalam kondisi emosional yang sensitif, seperti kecemasan menghadapi persalinan atau kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan ibu dan bayi.

3. Kompetensi Sikap dan Profesionalisme (*Attitude*) (Sharma & Gupta, 2023)

Kompetensi sikap dan profesionalisme mencerminkan nilai dan perilaku bidan dalam menjalin hubungan terapeutik dengan klien. Sikap ini tidak dapat dipisahkan dari praktik komunikasi terapeutik karena sangat memengaruhi rasa aman dan kepercayaan klien.

Sikap profesional bidan dalam komunikasi terapeutik meliputi:

- a. Empati dan kepedulian terhadap kondisi klien
- b. Sikap menghargai dan tidak menghakimi
- c. Kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi klien
- d. Kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi
- e. Tanggung jawab dan komitmen profesional

Sikap profesional membantu bidan menciptakan lingkungan yang mendukung klien untuk terbuka dan aktif dalam proses asuhan kebidanan.

4. Etika Komunikasi dalam Kebidanan (WHO, n.d.-a)

Etika komunikasi dalam kebidanan adalah pedoman moral yang mengatur bagaimana bidan berkomunikasi secara profesional, menghormati hak klien, serta menjaga martabat dan kerahasiaan klien.

Prinsip etika komunikasi kebidanan meliputi:

- a. Menghormati otonomi klien
- b. Menjaga kerahasiaan informasi kesehatan
- c. Memberikan informasi yang jujur dan seimbang
- d. Menghindari paksaan dan manipulasi dalam pengambilan keputusan
- e. Mengedepankan kepentingan terbaik klien

Penerapan etika komunikasi sangat penting dalam konteks komunikasi terapeutik dan *shared decision making*.

5. Sensitivitas Budaya, Nilai, dan Kepercayaan Klien (Swihart et al., 2023)

Sensitivitas budaya merupakan kemampuan bidan untuk memahami dan menghormati latar belakang budaya, nilai, dan kepercayaan klien yang memengaruhi persepsi kesehatan dan pengambilan keputusan. Dalam pelayanan kebidanan, perbedaan budaya dapat memengaruhi pandangan klien tentang kehamilan, persalinan, perawatan nifas, dan penggunaan layanan kesehatan.

Bidan yang sensitif secara budaya akan:

- a. Menghargai nilai dan keyakinan klien tanpa menghakimi
- b. Menyesuaikan komunikasi dengan bahasa dan kebiasaan klien
- c. Melibatkan keluarga sesuai budaya klien
- d. Menghindari sikap etnosentris dalam pelayanan

Sensitivitas budaya memperkuat hubungan terapeutik dan meningkatkan efektivitas komunikasi dalam asuhan kebidanan. Kompetensi bidan dalam komunikasi terapeutik mencakup integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang didukung oleh etika komunikasi serta sensitivitas budaya. Penguatan kompetensi ini akan meningkatkan kualitas asuhan kebidanan, keselamatan klien, dan kepuasan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

E. Konsep Shared Decision Making (Pengambilan Keputusan Bersama)

Shared Decision Making (SDM) atau pengambilan keputusan bersama adalah suatu proses kolaboratif antara tenaga kesehatan dan klien, di mana kedua pihak

secara aktif berbagi informasi, mendiskusikan pilihan yang tersedia, serta mempertimbangkan bukti ilmiah, nilai, preferensi, dan kondisi klien sebelum mengambil keputusan terkait asuhan kesehatan. Dalam kebidanan, SDM menempatkan perempuan sebagai subjek utama yang memiliki hak dan kapasitas untuk terlibat dalam setiap keputusan terkait tubuh, kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksinya. SDM bukan hanya pendekatan komunikasi, tetapi merupakan bagian dari praktik asuhan kebidanan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*).

Dalam praktik kebidanan, informed consent sering kali hanya menjadi proses administratif. *Share Decision Making* melampaui hal tersebut dengan memastikan bahwa klien benar-benar memahami pilihan, risiko, manfaat, dan konsekuensi, serta merasa keputusan yang diambil adalah miliknya.

Prinsip-Prinsip *Shared Decision Making* Penerapan dalam kebidanan didasarkan pada beberapa prinsip utama (Elwyn et al., n.d.)

1. Kemitraan

Bidan dan klien bekerja sebagai mitra yang setara, saling menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing.

2. Transparansi informasi

Informasi disampaikan secara jujur, seimbang, dan mudah dipahami, termasuk manfaat dan risiko setiap pilihan.

3. Penghormatan terhadap nilai dan preferensi klien

Keputusan mempertimbangkan nilai budaya, keyakinan, pengalaman, dan kondisi sosial klien.

4. Berbasis bukti ilmiah

Pilihan yang ditawarkan didukung oleh bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

5. Otonomi klien

Klien memiliki hak penuh untuk menerima, menunda, atau menolak pilihan asuhan.

Manfaat *Shared Decision Making* bagi Ibu, Keluarga, dan Bidan (Stacey et al., 2017)

1. Manfaat bagi Ibu

- a. Meningkatkan rasa kontrol dan kepercayaan diri
- b. Mengurangi kecemasan dan ketakutan
- c. Meningkatkan kepuasan terhadap pengalaman kehamilan dan persalinan

2. Manfaat bagi Keluarga

- a. Memahami kondisi dan pilihan asuhan secara lebih baik
- b. Terlibat aktif dalam mendukung keputusan ibu

- c. Mengurangi konflik dan kebingungan dalam pengambilan keputusan

3. Manfaat bagi Bidan

- a. Memperkuat hubungan terapeutik dengan klien
- b. Meningkatkan kepatuhan klien terhadap rencana asuhan
- c. Mengurangi risiko konflik dan keluhan hukum
- d. Mendukung praktik kebidanan yang etis dan profesional

Peran Bidan sebagai Fasilitator Keputusan

Dalam SDM, bidan tidak berperan sebagai pengambil keputusan tunggal, melainkan sebagai **fasilitator keputusan**. Peran ini mencakup ((International Confederation of Midwives (ICM), n.d.)

1. Menyediakan informasi yang akurat dan seimbang
2. Membantu klien memahami pilihan dan konsekuensinya
3. Menggali nilai, preferensi, dan kekhawatiran klien
4. Mendukung klien dalam mempertimbangkan pilihan tanpa paksaan
5. Menghormati keputusan akhir klien

Peran fasilitator ini selaras dengan filosofi kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan dan bidan sebagai pendamping profesional. *Shared decision making* merupakan pendekatan esensial dalam praktik kebidanan modern yang mengintegrasikan komunikasi terapeutik, etika, dan asuhan berpusat pada perempuan. Dengan menerapkan SDM, bidan berperan sebagai mitra dan fasilitator keputusan, sehingga asuhan kebidanan menjadi lebih aman, bermakna, dan manusiawi.

F. Penerapan Shared Decision Making (SDM) dalam Asuhan Kebidanan

1. Identifikasi Masalah dan Pilihan

Tahap awal SDM adalah mengidentifikasi masalah kesehatan yang dihadapi klien serta berbagai pilihan asuhan yang tersedia. Pada tahap ini, bidan melakukan pengkajian komprehensif (fisik, psikologis, sosial, budaya) untuk memastikan masalah yang dihadapi klien dipahami secara utuh. Bidan kemudian menjelaskan bahwa terdapat lebih dari satu pilihan yang mungkin diambil, sehingga klien menyadari adanya ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Tujuan tahap ini adalah membuka dialog dan membangun kesadaran klien bahwa keputusan akan dibuat bersama, bukan ditentukan sepihak oleh tenaga Kesehatan (Elwyn et al., n.d.).

2. Penyampaian Informasi Risiko dan Manfaat

Pada tahap ini, bidan menyampaikan informasi yang akurat, seimbang, dan mudah dipahami mengenai setiap pilihan asuhan, termasuk manfaat, risiko,

serta kemungkinan konsekuensi jangka pendek dan panjang. Informasi harus disampaikan dengan bahasa sederhana, menghindari istilah medis yang sulit dipahami, serta disesuaikan dengan tingkat literasi kesehatan klien. Penyampaian informasi yang transparan merupakan kunci agar klien dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab (Stacey et al., 2017)

3. Eksplorasi Nilai dan Preferensi Klien

Eksplorasi nilai dan preferensi merupakan inti dari SDM. Pada tahap ini, bidan menggali pandangan klien terkait keyakinan, pengalaman sebelumnya, nilai budaya, kondisi keluarga, serta harapan terhadap asuhan yang akan dijalani. Bidan menggunakan komunikasi terapeutik (*active listening*, refleksi perasaan, validasi) untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi klien. Tahap ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya benar secara medis, tetapi juga selaras dengan nilai dan kehidupan klien (Stacey et al., 2017).

4. Pengambilan Keputusan Bersama

Pengambilan keputusan bersama dilakukan setelah bidan dan klien mendiskusikan pilihan, risiko, manfaat, serta nilai dan preferensi klien. Keputusan diambil secara kolaboratif, dengan menghormati otonomi klien dan tetap mempertimbangkan keselamatan ibu dan bayi. Peran bidan pada tahap ini adalah sebagai fasilitator yang mendukung klien dalam memilih opsi terbaik tanpa paksaan atau dominasi profesional (International Confederation of Midwives (ICM), n.d.).

5. Evaluasi Keputusan

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai apakah keputusan yang diambil sesuai dengan harapan klien dan berjalan dengan baik dalam praktik. Bidan mengevaluasi pemahaman klien, kepuasan terhadap keputusan, serta dampak keputusan terhadap kondisi kesehatan ibu dan bayi. Evaluasi ini juga memberi kesempatan untuk meninjau ulang keputusan jika kondisi klien berubah.

Penerapan SDM pada Berbagai Pelayanan Kebidanan

1. SDM pada Pelayanan Kehamilan

SDM diterapkan dalam pemilihan pemeriksaan antenatal, rencana persalinan, penatalaksanaan ketidaknyamanan kehamilan, serta rencana rujukan bila diperlukan. Ibu dilibatkan secara aktif dalam memahami kondisi kehamilannya dan pilihan asuhan yang tersedia.

2. SDM pada Pelayanan Persalinan

Pada persalinan, SDM diterapkan dalam pemilihan posisi persalinan, metode manajemen nyeri, pendamping persalinan, serta intervensi medis yang mungkin diperlukan. Pendekatan ini meningkatkan pengalaman persalinan yang positif dan bermakna bagi ibu.

3. SDM pada Pelayanan Nifas

Dalam masa nifas, SDM digunakan untuk menentukan perawatan ibu dan bayi, pilihan menyusui, perawatan luka, serta dukungan psikologis. Keterlibatan ibu dan keluarga membantu mempercepat adaptasi pascapersalinan.

4. SDM pada Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

SDM sangat penting dalam pelayanan KB karena berkaitan langsung dengan nilai, keyakinan, dan rencana hidup klien. Bidan memfasilitasi klien untuk memilih metode KB yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan preferensinya (WHO, n.d.-b)

5. SDM pada Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Dalam kesehatan reproduksi, SDM diterapkan pada konseling remaja, kesehatan seksual, perencanaan kehamilan, dan penanganan masalah reproduksi. Pendekatan ini mendukung penghormatan terhadap hak reproduksi dan otonomi klien. Penerapan *shared decision making* dalam asuhan kebidanan merupakan proses berkelanjutan yang dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi keputusan. Dengan menerapkan SDM pada setiap fase pelayanan kebidanan, bidan dapat memberikan asuhan yang lebih aman, etis, dan berpusat pada perempuan serta keluarganya (WHO, n.d.-c).

G. Integrasi Komunikasi Terapeutik dan Shared Decision Making

1. Hubungan Komunikasi Terapeutik dengan Shared Decision Making (SDM) (Elwyn et al., n.d.)

Komunikasi terapeutik dan *shared decision making* (SDM) merupakan dua pendekatan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik kebidanan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*). Komunikasi terapeutik menjadi **fondasi relasional**, sedangkan SDM merupakan **aplikasi pengambilan keputusan** yang dibangun di atas hubungan tersebut.

Komunikasi terapeutik memungkinkan bidan membangun hubungan saling percaya melalui empati, kehadiran, dan keterbukaan, sehingga klien merasa aman untuk mengekspresikan perasaan, nilai, serta preferensinya. Tanpa

komunikasi terapeutik yang efektif, SDM sulit diterapkan karena klien cenderung pasif, ragu, atau tidak berani menyampaikan pandangannya. Sebaliknya, SDM memperkuat komunikasi terapeutik dengan memberikan ruang nyata bagi klien untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait asuhan kebidanan.

Dengan demikian, komunikasi terapeutik berfungsi sebagai **prasyarat SDM**, sementara SDM merupakan **hasil lanjutan** dari komunikasi terapeutik yang berkualitas.

2. Model Integrasi Komunikasi Terapeutik–SDM (Elwyn et al., n.d.)

Integrasi komunikasi terapeutik dan SDM dapat dijelaskan melalui **model dialogis kolaboratif**, di mana komunikasi terapeutik digunakan pada setiap tahap SDM. Salah satu model yang relevan dalam praktik kebidanan adalah adaptasi dari **Three-Talk Model of SDM** yang dipadukan dengan tahapan komunikasi terapeutik. **Model Integrasi Praktis dalam Kebidanan:**

a. Tahap Membangun Hubungan (*Engagement*)

- 1) Menggunakan komunikasi terapeutik (empati, *active listening*, *silence terapeutik*)
- 2) Membangun rasa aman dan kepercayaan

b. Tahap Pertukaran Informasi (*Information Exchange*)

- 1) Menggunakan komunikasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami
- 2) Menyampaikan pilihan, risiko, dan manfaat secara seimbang

c. Tahap Eksplorasi dan Dialog (*Deliberation*)

- 1) Menggali nilai, preferensi, dan kekhawatiran klien
- 2) Menggunakan refleksi perasaan dan validasi

d. Tahap Keputusan Bersama (*Decision*)

- 1) Bidan dan klien menyepakati pilihan terbaik
- 2) Menghormati otonomi klien dan keselamatan ibu–bayi

Model ini menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik bukan tahap terpisah, tetapi **menjiwai seluruh proses SDM**.

3. Strategi Membangun Kemitraan Bidan–Klien

Kemitraan bidan–klien merupakan inti dari integrasi komunikasi terapeutik dan SDM. Kemitraan ini dibangun melalui beberapa strategi berikut (International Confederation of Midwives (ICM), n.d.):

1. Mengakui klien sebagai mitra setara
Bidan menghargai pengalaman hidup, nilai, dan pandangan klien sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan.
2. Menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak menghakimi

- Bahasa yang ramah dan menghormati meningkatkan keterbukaan klien.
3. Melibatkan keluarga sesuai kebutuhan klien
Dalam konteks budaya tertentu, keluarga memiliki peran penting dalam keputusan kebidanan.
 4. Memberikan ruang dialog dua arah
Bidan mendorong klien untuk bertanya dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.
 5. Kemitraan yang kuat meningkatkan keterlibatan klien dan kualitas asuhan kebidanan secara keseluruhan.

4. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Klien

Kepercayaan dan kepuasan klien merupakan indikator penting kualitas asuhan kebidanan. Integrasi komunikasi terapeutik dan SDM terbukti meningkatkan kedua aspek tersebut. Klien yang merasa didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam keputusan cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi serta kepatuhan yang lebih baik terhadap rencana asuhan (Stacey et al., 2017)

Kepercayaan dibangun melalui konsistensi komunikasi, transparansi informasi, dan sikap profesional bidan. Kepuasan klien meningkat ketika pengalaman asuhan dirasakan sebagai pengalaman yang bermakna, manusiawi, dan sesuai dengan harapan klien.

Integrasi komunikasi terapeutik dan *shared decision making* merupakan pendekatan esensial dalam praktik kebidanan modern. Komunikasi terapeutik membangun hubungan dan kepercayaan, sedangkan SDM memastikan keterlibatan aktif klien dalam keputusan asuhan. Melalui integrasi keduanya, bidan dapat memberikan asuhan kebidanan yang lebih etis, aman, dan berpusat pada perempuan serta keluarga.

H. Strategi Penguatan Kompetensi Bidan

Penguatan kompetensi bidan dalam komunikasi terapeutik dan *shared decision making* (SDM) memerlukan pendekatan yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis praktik. Strategi penguatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan sikap profesional bidan dalam konteks pelayanan nyata (Stacey et al., 2017).

1. Pelatihan dan Workshop Komunikasi

Pelatihan dan workshop komunikasi merupakan strategi utama dalam meningkatkan kompetensi bidan. Kegiatan ini dirancang untuk memperdalam

pemahaman bidan tentang komunikasi terapeutik dan SDM, serta melatih penerapannya secara terstruktur.

Materi pelatihan umumnya mencakup:

- a. Konsep dasar komunikasi terapeutik
- b. Teknik komunikasi terapeutik (active listening, refleksi perasaan, validasi, silence terapeutik)
- c. Prinsip dan tahapan *shared decision making*
- d. Komunikasi berpusat pada perempuan (*woman-centered communication*)
- e. Etika dan sensitivitas budaya dalam komunikasi kebidanan

Pelatihan yang efektif biasanya bersifat partisipatif, menggunakan diskusi kasus dan refleksi pengalaman praktik. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi yang terstruktur dapat meningkatkan kepercayaan diri bidan, kualitas interaksi bidan–klien, dan kepuasan klien.

2. Simulasi dan Role Play

Simulasi dan *role play* merupakan metode pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang sangat efektif untuk melatih keterampilan komunikasi bidan. Dalam metode ini, bidan mempraktikkan langsung komunikasi terapeutik dan SDM melalui skenario yang menyerupai kondisi klinik nyata.

Simulasi dan role play bertujuan untuk:

- a. Melatih respon komunikasi dalam situasi emosional dan kompleks
- b. Meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan empati
- c. Mengembangkan keterampilan memfasilitasi pengambilan keputusan bersama
- d. Meningkatkan kesiapan bidan menghadapi situasi klinis sebenarnya
- e. Contoh skenario role play meliputi konseling ANC, diskusi pilihan metode persalinan, konseling KB, dan penanganan klien dengan kecemasan tinggi. Metode ini terbukti meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri tenaga Kesehatan

3. Supervisi dan Mentoring Klinik

Supervisi dan mentoring klinik merupakan strategi penting untuk memastikan penerapan kompetensi komunikasi bidan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Melalui supervisi, bidan mendapatkan umpan balik langsung dari senior atau mentor terkait keterampilan komunikasi yang telah diterapkan. Supervisi dan mentoring bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki

- b. Memberikan bimbingan dalam situasi komunikasi yang sulit
- c. Menjaga standar profesional dan etika komunikasi
- d. Mendukung pengembangan profesional berkelanjutan

Pendekatan mentoring yang suportif membantu bidan belajar dari pengalaman nyata dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan.

4. Penggunaan Media Edukasi dan Decision Aids

Media edukasi dan *decision aids* berperan penting dalam mendukung komunikasi terapeutik dan SDM. Media ini membantu bidan menyampaikan informasi secara lebih jelas, visual, dan mudah dipahami oleh klien.

Media yang dapat digunakan meliputi:

- a. Leaflet dan booklet edukasi
- b. Poster dan infografis
- c. Video edukasi
- d. Aplikasi digital dan modul interaktif
- e. *Decision aids* untuk pilihan persalinan, KB, atau pemeriksaan kehamilan

Penggunaan *decision aids* terbukti meningkatkan pemahaman klien, mengurangi konflik keputusan, dan memperkuat partisipasi klien dalam SDM.

5. Evaluasi Kompetensi Komunikasi Bidan

Evaluasi kompetensi komunikasi bidan dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan penerapan komunikasi terapeutik serta SDM dalam praktik. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif dan sumatif.

Metode evaluasi meliputi:

- a. Observasi langsung praktik komunikasi
- b. Checklist atau rubrik penilaian komunikasi
- c. Penilaian berbasis OSCE
- d. Umpan balik dari klien
- e. Refleksi diri bidan

Evaluasi yang sistematis membantu institusi pelayanan dan pendidikan kebidanan dalam menjaga mutu layanan dan meningkatkan kualitas asuhan kebidanan secara berkelanjutan.

Strategi penguatan kompetensi bidan dalam komunikasi terapeutik dan *shared decision making* memerlukan kombinasi pelatihan, simulasi, supervisi, penggunaan media edukasi, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan strategi ini, bidan dapat memberikan asuhan kebidanan yang lebih profesional, beretika, dan berpusat pada perempuan serta keluarga.

I. Penutup

Penerapan komunikasi terapeutik dan *shared decision making* memiliki implikasi penting bagi praktik kebidanan. Bidan tidak lagi diposisikan semata sebagai pemberi tindakan medis, tetapi sebagai mitra profesional yang mendampingi perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Praktik kebidanan yang mengintegrasikan kedua pendekatan ini berkontribusi pada meningkatnya rasa aman, kepercayaan, dan kepuasan klien, serta memperkuat kualitas hubungan bidan–klien.

Selain itu, pendekatan ini mendukung praktik kebidanan yang lebih etis dan humanis, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan kepatuhan klien terhadap rencana asuhan. Dengan demikian, komunikasi terapeutik dan *shared decision making* tidak hanya berdampak pada pengalaman klien, tetapi juga pada mutu pelayanan dan profesionalisme bidan secara keseluruhan.

Rekomendasi Pengembangan Kompetensi Bidan ke Depan

Sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas asuhan kebidanan, pengembangan kompetensi bidan dalam komunikasi terapeutik dan *shared decision making* perlu terus diperkuat. Rekomendasi pengembangan ke depan meliputi:

1. Integrasi dalam pendidikan kebidanan

Komunikasi terapeutik dan *shared decision making* perlu menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan kebidanan, baik pada tingkat diploma maupun pendidikan lanjutan, dengan pendekatan pembelajaran berbasis praktik.

2. Pelatihan berkelanjutan bagi bidan praktisi

Diperlukan pelatihan dan workshop komunikasi yang berkesinambungan untuk memperbarui keterampilan bidan sesuai perkembangan praktik kebidanan dan kebutuhan klien.

3. Penguatan supervisi dan refleksi praktik

Supervisi klinik dan refleksi praktik perlu dikembangkan sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas komunikasi bidan dalam pelayanan nyata.

4. Pemanfaatan teknologi dan media edukasi

Penggunaan media edukasi dan *decision aids* berbasis digital dapat mendukung proses komunikasi dan pengambilan keputusan bersama secara lebih efektif dan efisien.

5. Pengembangan kebijakan dan standar praktik

Institusi pelayanan dan organisasi profesi diharapkan dapat mengembangkan kebijakan dan standar praktik yang menekankan pentingnya komunikasi

terapeutik dan *shared decision making* sebagai bagian dari mutu pelayanan kebidanan.

Akhirnya, penguatan kompetensi bidan dalam komunikasi terapeutik dan *shared decision making* merupakan investasi penting bagi masa depan pelayanan kebidanan yang lebih aman, bermakna, dan berpusat pada perempuan. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi praktis dan inspiratif bagi bidan, pendidik, serta pemangku kepentingan dalam mengembangkan praktik kebidanan yang profesional, beretika, dan humanis.

J. Referensi

- Adhrianti, L., Cucu, N., & Gritary, S. (2024). Therapeutic Communication in Midwife Counseling in the Implementation of Keluarga Berencana (KB) Services at the Lingkar Timur Public Health Center Bengkulu City. 7(3), 554–569.
- Begley, K. (2019). Shared decision - making in maternity care : Acknowledging and overcoming epistemic defeaters. (July), 1113–1120. <https://doi.org/10.1111/jep.13243>
- Chang, Y., & Coxon, K. (2018). Interventions to support effective communication between maternity care staff and women in labour : A mixed-methods systematic review. 59(November 2017), 4–16. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.12.014>
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., Cording, E., Bch, M. B., Tomson, D., Bch, B. M., Dodd, C., Rollnick, S., Edwards, A., & Barry, M. (n.d.). Shared Decision Making : A Model for Clinical Practice. 1361–1367. <https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6>
- Ganisia, A., & A, M. K. (2025). Effective Communication in Midwifery Practice Strengthening Patient Trust and Maternal Health Outcomes. 2(September).
- International Confederation of Midwives (ICM). (n.d.). Philosophy and Model of Midwifery Care. Retrieved <https://internationalmidwives.org/our-work/policy-and-practice/philosophy-of-midwifery.html>
- Olde, K. M., Id, L., Kok, B. C. De, Id, W. B., Jonker, A., Portela, A., Id, H. M., Grobbee, E., Srofeneyoh, E., Id, K. A., Brown, H., Amoakoh-coleman, M., & Browne, J. L. (2023). PLOS GLOBAL PUBLIC HEALTH Strategies to improve interpersonal communication along the continuum of maternal and newborn care : A scoping review and narrative synthesis. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002449>
- Sari, L. (2025). The Role of Therapeutic Communication in Providing Health Education for Midwifery Services Lili. KESANS: International Journal of Health and Science, 5(1).

- Seger, H. R., Oleiwi, P. D. S. S., & Ph, D. (2025). Effect of Communication Skills Training on Nurses ' and Midwives ' Practices : A Randomized Controlled Trial. 47(2), 2864–2869.
- Sharma, N., & Gupta, V. (2023). Therapeutic Communication. Statpearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567775/?utm_source=chatgpt.com
- Stacey, D., Légaré, F., Lewis, K., Mj, B., Cl, B., Kb, E., Thomas, H., Lyddiatt, A., Thomson, R., Trevena, L., Stacey, D., Légaré, F., Lewis, K., Mj, B., Cl, B., Kb, E., Lyddiatt, A., Thomson, R., & Trevena, L. (2017). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions (Review). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001431.pub5>. www.cochranelibrary.com
- Stuart, G. W. (2018). Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Elsevier. <https://www.elsevier.com/books/principles-and-practice-of-psychiatric-nursing/stuart/978-0-323-54849-4>
- Swihart, D., Yarrarapu, S., & Martin, RL. (2023). Cultural Religious Competence in Clinical Practice. Statpearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493216/>
- The Importance of Effective Communication in Nursing. (2024). University of St. Augustine For Health Science. https://www.usa.edu/blog/communication-in-nursing/?utm_source=chatgpt.com
- WHO. (n.d.-a). Ethics in Health Care. Retrieved <https://www.who.int/ethics/en/>
- WHO. (n.d.-b). Family Planning: A Global Handbook for Providers. WHO. Retrieved <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260156>
- WHO. (n.d.-c). Sexual and Reproductive Health and Rights. Retrieved <https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research>
- Yelvianti, T. (2023). Komunikasi Dalam Kebidanan. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.

K. Glosarium

SDM = *Share Decision Making*

CHAPTER 5

IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED MIDWIFERY DALAM PEMBELAJARAN TEORI DAN PRAKTIK

Dr. Yeni Fitrianiingsih, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Pendidikan kebidanan saat ini berada pada ambang transformasi besar yang dipacu oleh tuntutan kualitas pelayanan kesehatan global dan target penurunan angka kematian ibu serta bayi yang masih menjadi prioritas nasional. Model asuhan masa kini tidak lagi cukup hanya mengandalkan transfer keterampilan teknis secara turun-temurun, melainkan harus berakar pada Evidence-Based Midwifery (EBM). EBM bukan sekadar tren akademis, melainkan sebuah komitmen profesional untuk memastikan bahwa setiap keputusan klinis yang diambil didasarkan pada integrasi antara bukti riset terbaik, kepakaran klinis bidan, dan nilai-nilai serta otonomi pasien. Kebutuhan yang mendesak untuk pendidikan kebidanan yang berkualitas tinggi, karena hal ini telah terbukti meningkatkan penyediaan layanan kebidanan yang berkualitas. (Smith et al., 2023). Kualitas pendidikan kebidanan telah diakui sebagai faktor penting yang berkontribusi terhadap hasil kesehatan ibu dan bayi baru lahir suatu negara dan pencapaian tujuan pembangunan global, seperti yang diidentifikasi di Nigeria (Ige et al., 2024). Layanan kebidanan sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan wanita (Hunter et al., 2022). yang mencakup perawatan kebidanan selama prakonsepsi, kehamilan, dan persalinan serta pendidikan kesehatan (Janke et al., 2024). Lebih jauh lagi, bidan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan dalam memfasilitasi kolaborasi antara profesional kesehatan untuk memberikan konseling dan Continuity of Care (CoC) oleh bidan selama fase kehamilan, persalinan, dan pascanatal (Asadzadeh et al., 2020)

Kualitas layanan kebidanan harus terus ditingkatkan untuk membekali bidan dengan kemampuan yang dibutuhkan di abad ke-21. Dengan demikian, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi CoC sangat penting (Muraraneza, C., & Mtshali, 2021). Dalam konteks Continuity of Care (CoC), penerapan EBM menjadi benang merah yang menjamin keselamatan dan kepuasan pasien sepanjang siklus reproduksi. Namun, tantangan besar sering muncul pada tahap implementasi, di mana terdapat jurang antara teori yang dipelajari di bangku kuliah

dengan realitas praktik di lapangan yang terkadang masih kaku dengan tradisi klinis lama. Oleh karena itu, institusi pendidikan kebidanan memegang tanggung jawab strategis untuk menyelaraskan kurikulum dengan dinamika sains kesehatan terbaru. Hal ini sejalan dengan Pilar ke-5 Transformasi Kesehatan mengenai penguatan SDM kesehatan yang kompeten dan adaptif terhadap standar internasional (Menteri Kesehatan RI, 2025).

Buku ini disusun untuk memberikan arah baru dalam pembelajaran teori dan praktik kebidanan. Dengan mengintegrasikan EBM ke dalam setiap aspek pembelajaran, mahasiswa diarahkan untuk menjadi praktisi yang kritis, reflektif, dan inovatif. Transformasi ini juga menuntut adopsi teknologi digital sebagai alat bantu pengambilan keputusan (decision support tools), yang menjadi pilar penting dalam menghadapi era kesehatan 4.0. Melalui pendekatan ini, bidan masa kini diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai advokat kesehatan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya berdasarkan bukti ilmiah yang valid.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif bagi dosen, preseptor, dan mahasiswa untuk memahami bahwa EBM adalah kunci dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan manusiawi. Melalui tiga pilar utama—rekonstruksi kurikulum, digitalisasi asuhan, dan penguatan trias EBP—kita sedang meletakkan batu fondasi bagi generasi bidan masa depan yang unggul dan berdaya saing global demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

B. Dekonstruksi Tradisi Klinis melalui EBM dalam Kurikulum Berbasis Continuity of Care

1. Pergeseran Paradigma: Dari Tradisi ke Otoritas Ilmiah

Dalam sejarah panjang praktik kebidanan, banyak tindakan klinis yang diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya tinjauan kritis terhadap efektivitas dan keselamatannya. Dekonstruksi tradisi klinis dimulai dengan mempertanyakan kembali praktik-praktik rutin yang selama ini dianggap sebagai "standar emas" namun sebenarnya tidak didukung oleh bukti ilmiah terbaru. Menurut International Confederation of Midwives, kompetensi bidan masa kini harus berfokus pada asuhan yang bersifat non-intervensionis kecuali jika ada indikasi medis yang jelas. Transformasi ini mengharuskan kurikulum kebidanan untuk tidak lagi mengajarkan prosedur atas dasar "biasanya begini," melainkan "berdasarkan riset terbaru begini."

Kualitas layanan kebidanan harus terus ditingkatkan untuk membekali bidan dengan kemampuan yang dibutuhkan di abad ke-21. Dengan demikian,

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi CoC sangat penting (Muraraneza, C., & Mtshali, 2021). Penyusunan kurikulum tersebut harus mematuhi standar pendidikan, untuk memfasilitasi persiapan lulusan kebidanan untuk praktik profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan maternitas (Tickle, M. N., Gamble, J., Creedy, D., & Carter, 2022). Akibatnya, pendidikan kebidanan berkembang secara global karena pengaruhnya yang signifikan terhadap pembelajaran siswa untuk memberikan perawatan kebidanan yang berkelanjutan dan berpusat pada perempuan (Johnston, J., McKenna, L., Malik, G., & Reisenhofer, 2022). Komponen utama pengembangan kurikulum kebidanan adalah strategi pembelajaran CoC yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan memanfaatkan metode blended learning (Muraraneza, C., & Mtshali, 2021). Hal itu, melibatkan interaksi tatap muka langsung atau pembelajaran asinkron menggunakan program seperti mLearning yang telah terbukti meningkatkan pendidikan CoC dengan berfungsi sebagai media pembelajaran efektif yang memfasilitasi keterlibatan siswa dalam kegiatan CoC (Kumar et al., 2021)

2. Mengganti Praktik Berisiko dengan Asuhan Sayang Ibu (Evidence-Based)

Salah satu fokus utama dalam dekonstruksi ini adalah penghapusan praktik-praktik yang terbukti memberikan dampak negatif atau tidak memberikan manfaat signifikan bagi ibu dan janin. Sebagai contoh, praktik episiotomi rutin, manuver Kristeller (dorongan fundus), dan pembatasan posisi meneran telah lama didekonstruksi oleh berbagai riset berskala besar. World Health Organization dalam pedoman Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience menegaskan bahwa asuhan yang menghargai martabat wanita dan berbasis bukti dapat menurunkan angka morbiditas maternal secara signifikan.

Di dalam kurikulum, dekonstruksi ini dilakukan dengan memperkenalkan mahasiswa pada teknik asuhan yang lebih fisiologis, seperti penggunaan posisi tegak saat persalinan, teknik relaksasi untuk manajemen nyeri, dan inisiasi menyusui dini (IMD) yang dilakukan segera tanpa penundaan untuk prosedur rutin yang tidak darurat. dalam jurnal Midwifery menyoroti bahwa penguatan EBM sejak dini di bangku kuliah membantu mahasiswa membangun "skeptisisme profesional" yang sehat terhadap intervensi yang tidak perlu. Berdasarkan hasil penelitian berbagai intervensi, model, dan temuan pendidikan berkaitan dengan pengajaran penelitian dan praktik berbasis bukti (EBP) serta penerapannya dalam kebidanan dan keperawatan. Terlepas dari banyaknya strategi pendidikan untuk mengintegrasikan penelitian ke dalam pengajaran, belum ada bukti konklusif tentang metode terbaik untuk mengajarkan EBP.

Bidang ini membutuhkan pedoman yang jelas, perangkat pendidikan, dan materi komprehensif untuk secara efektif menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik serta untuk mengatasi tantangan pendidikan EBP dan penerapannya secara klinis. (Elina Leiviska, 2025). Untuk mahasiswa kesehatan yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, kompetensi praktik berbasis bukti (EBM/EBP) dapat ditingkatkan melalui metode pengajaran yang variatif dan tertata rapi. Hasil terbaik akan dicapai melalui pendekatan yang dilakukan secara berkelanjutan, menggunakan berbagai media pembelajaran, serta fleksibel dalam pelaksanaannya. Kuncinya terletak pada kolaborasi, penggabungan teori ke dalam praktik nyata, dan pemanfaatan teknologi pendukung. Selain itu, diperlukan adanya panduan standar internasional agar kualitas kompetensi lulusan tetap setara secara global .

3. Implementasi EBM dalam Model Continuity of Care (CoC)

Model pembelajaran berbasis CoC menyediakan wadah ideal bagi penerapan EBM. Dalam model ini, mahasiswa mengikuti ibu sejak masa antenatal hingga nifas, sehingga mereka dapat melihat dampak jangka panjang dari asuhan yang mereka berikan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa model asuhan berkelanjutan yang dipimpin oleh bidan (midwife-led continuity models) memberikan hasil klinis yang lebih baik dibandingkan asuhan yang terfragmentasi. Asuhan kebidanan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu juga, asuhan kebidanan berkelanjutan dapat memberikan manfaat bagi bidan. Asuhan yang berpusat pada wanita terletak pada hubungan saling percaya sehingga terjadi proses biopsikososial dengan memberdayakan wanita, dan meningkatkan kesejahteraan emosional serta meningkatkan keterlibatan wanita dengan pelayanan kesehatan. Penerapan pembelajaran CoC dapat mendorong terbentuknya praktik yang berpusat pada perempuan, didukung oleh kurikulum yang mencakup pembelajaran yang dialami dan evaluasi kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan CoC (Tierney et al., 2024)

Hasil dari studi-studi kuantitatif yang ditelaah, terdapat lima pilar utama dalam instruksi EBP yaitu metode, teknologi, praktik klinis, kolaborasi, dan durasi program. Temuan ini menegaskan bahwa berbagai model pembelajaran mampu meningkatkan standar kompetensi mahasiswa keperawatan secara signifikan, baik dari segi kognitif maupun afektif (Melita Peršolja, 2025)

Kurikulum yang berbasis CoC memungkinkan mahasiswa mempraktikkan EBM secara utuh, di mana mereka dapat melakukan pemantauan yang tepat dan meminimalkan intervensi medis yang tidak perlu. Pengalaman praktik ini

memperkuat pemahaman mahasiswa bahwa kebidanan adalah seni menjaga proses fisiologis, bukan sekadar asisten prosedur medis .

4. Kebijakan Kemenkes RI: Standarisasi Kompetensi Berbasis Bukti

Kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca-transformasi kesehatan 2021-2024, menandai pergeseran paradigma besar. Standarisasi kompetensi tenaga kesehatan tidak lagi hanya bersandar pada pengalaman klinis masa lalu atau "tradisi" senioritas, melainkan pada Scientific Governance. Kemenkes menekankan bahwa setiap tindakan medis dan asuhan keperawatan harus memiliki landasan bukti ilmiah yang kuat (Evidence-Based Practice).

Dalam konteks ini, EBP bukan sekadar alat bantu, melainkan elemen inti dari Standard Operating Procedures (SOP) yang disusun secara nasional. Hal ini bertujuan untuk mereduksi unnecessary cost dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan tanpa mengurangi kualitas luaran pasien. Di tingkat nasional, dekonstruksi tradisi klinis diperkuat melalui kebijakan Transformasi SDM Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Bidan, ditekankan bahwa bidan harus mampu memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas tinggi dan berbasis bukti. Institusi pendidikan seperti Poltekkes Kemenkes memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa kurikulum dan lahan praktiknya selaras dengan standar operasional prosedur (SOP) nasional yang sudah direvisi berdasarkan prinsip EBM terbaru. Strategi berbasis bukti diperlukan untuk menentukan tujuan, implementasi, dokumentasi, dan evaluasi pengalaman CoC (Moncrieff, G., MacVicar, S., Norris, G., & Martin, 2021)

C. Refleksi Praktis Berbasis Teknologi Digital dalam Pendidikan Kesehatan

1. Redefinisi Refleksi di Era Digital

Dalam pendidikan kesehatan tradisional, refleksi sering kali dianggap sebagai aktivitas retrospektif pasif sekadar menuliskan pengalaman di atas kertas (logbook). Namun, integrasi teknologi digital telah mentransformasi refleksi menjadi proses dinamis, real-time, dan kolaboratif. Refleksi praktis kini bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi bagaimana data digital memberikan wawasan objektif untuk memperbaiki performa di masa depan.

Dalam konteks pendidikan kedokteran dan keperawatan, refleksi berbasis teknologi memungkinkan mahasiswa untuk menjembatani theory practice gap melalui umpan balik instan yang dihasilkan oleh platform digital.

2. Wahana Digital untuk Praktik Reflektif

Beberapa instrumen digital telah mengubah lanskap refleksi dalam pendidikan kesehatan: E-Portfolio dan Logbook Digital: Penggunaan platform seperti Mahara atau sistem manajemen pembelajaran (LMS) memungkinkan mahasiswa mendokumentasikan pencapaian klinis secara multimedia (foto, video, dan anotasi). Hal ini memfasilitasi refleksi longitudinal yang dapat dipantau oleh dosen secara jarak jauh. Simulasi High-Fidelity dan Virtual Reality (VR) Teknologi VR memungkinkan mahasiswa "mengalami kembali" skenario klinis yang kompleks. Sesi debriefing setelah simulasi yang didukung oleh rekaman data performa sensorik menyediakan bahan refleksi yang sangat akurat dan objektif dibanding ingatan subjektif.

Video-Based Reflection (VBR): Rekaman video saat melakukan prosedur klinis (dengan izin etis) memungkinkan mahasiswa melakukan swa-evaluasi terhadap gerak psikomotorik dan komunikasi terapeutik mereka sendiri.

3. Analitik Pembelajaran (Learning Analytics) sebagai Cermin Refleksi

Penerapan Big Data dan analitik dalam pendidikan kesehatan memberikan dimensi baru bagi refleksi praktis. Melalui dasbor analitik, mahasiswa dapat melihat pola perkembangan kompetensi mereka secara kuantitatif.

Perspektif Akademik: Refleksi berbasis data (data-driven reflection) meminimalkan bias kognitif. Misalnya, seorang mahasiswa mungkin merasa kompeten dalam manajemen nyeri, namun data digital menunjukkan bahwa ia sering melewatkan langkah asesmen pada pasien tertentu. Teknologi digital bertindak sebagai "cermin objektif" yang memaksa praktisi untuk menghadapi keterbatasan mereka secara jujur.

4. Tantangan Etis dan Literasi Digital

Transisi ke refleksi digital bukan tanpa hambatan. Terdapat isu krusial mengenai: Privasi Data Pasien: Bagaimana menjaga kerahasiaan identitas pasien dalam materi refleksi digital (misalnya pada video atau foto klinis).

Kelelahan Digital (Digital Fatigue): Beban administratif pengisian platform digital yang berlebihan dapat menurunkan kualitas refleksi menjadi sekadar tugas formalitas.

Hambatan Teknis: Kesenjangan infrastruktur digital antar institusi pendidikan kesehatan di Indonesia tetap menjadi tantangan dalam standarisasi metode ini.

5. Sintesis: Menuju Praktisi yang Adaptif

Pada akhirnya, refleksi praktis berbasis teknologi bukan bertujuan menggantikan intuisi klinis, melainkan memperkuatnya dengan bukti dan data. Penguasaan teknologi digital dalam refleksi menciptakan tenaga kesehatan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki ketajaman metakognitif untuk terus belajar di tengah ekosistem kesehatan yang terus berubah

D. Sinergi Interprofessional Collaboration (IPC) dalam Praktik dan Pendidikan

Sinergi Interprofessional Collaboration (IPC) dan Interprofessional Education (IPE) merupakan fondasi utama dalam sistem kesehatan modern untuk mewujudkan pelayanan yang berpusat pada pasien (patient-centered care).

1. Dekonstruksi Model Pelayanan Silo

Secara historis, pendidikan dan praktik kesehatan cenderung berjalan dalam koridor profesi yang terpisah (silo mentality). Dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya dididik dengan kurikulum yang eksklusif, yang sering kali menumbuhkan hierarki profesional yang kaku. Namun, kompleksitas penyakit kronis dan tuntutan keselamatan pasien saat ini menuntut dekonstruksi model tersebut.

Interprofessional Collaboration (IPC) hadir sebagai solusi sistemik di mana berbagai profesi kesehatan bekerja sama, berbagi pengambilan keputusan, dan mengintegrasikan keahlian unik mereka untuk mencapai hasil klinis yang optimal. Sinergi ini bukan sekadar bekerja di ruangan yang sama, melainkan sebuah interaksi sosiokognitif yang mendalam.

2. Interprofessional Education (IPE) sebagai Prakondisi

Sinergi dalam praktik (IPC) tidak dapat terjadi secara organik tanpa adanya intervensi di level pendidikan. Interprofessional Education (IPE) adalah proses di mana dua atau lebih profesi belajar bersama, dari satu sama lain, dan tentang satu sama lain (learning with, from, and about each other).

Perspektif Akademik: IPE bertujuan untuk menanamkan kompetensi kolaboratif sejak dini. Hal ini mencakup penghancuran stereotip antar-profesi, pengembangan bahasa medis yang seragam, dan pemahaman terhadap ruang lingkup praktik (scope of practice) masing-masing kolega. Tanpa IPE yang kuat, transisi mahasiswa ke dunia kerja akan diwarnai oleh konflik peran dan kegagalan komunikasi yang berisiko pada keselamatan pasien.

3. Pilar Utama Sinergi IPC

Untuk membangun narasi yang komprehensif, sinergi IPC dapat dipetakan ke dalam empat dimensi krusial:

Komunikasi Interprofesional: Penggunaan alat komunikasi terstandar seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) untuk meminimalkan ambiguitas dalam transmisi informasi klinis.

Klarifikasi Peran: Pemahaman mendalam tentang tumpang tindih (overlap) kompetensi dan batas-batas otoritas profesional untuk mencegah duplikasi tindakan atau kelalaian prosedural.

Kepemimpinan Kolektif: Berbeda dengan kepemimpinan tradisional yang sentralistik, IPC mendorong distributed leadership di mana pemimpin tim ditentukan berdasarkan kebutuhan pasien pada situasi tertentu (misalnya, apoteker memimpin saat rekonsiliasi obat).

Etika dan Nilai Bersama: Menempatkan martabat dan kebutuhan pasien di atas ego profesionalitas masing-masing disiplin ilmu.

4. Dampak Strategis: Efisiensi dan Keselamatan Pasien

Secara empiris, berbagai studi menunjukkan bahwa rumah sakit yang menerapkan IPC secara konsisten mengalami penurunan signifikan pada angka kematian (mortality rate), lama hari rawat (length of stay), dan tingkat kelelahan kerja (burnout) di kalangan tenaga kesehatan. Sinergi ini menciptakan mekanisme check-and-balance alami; kesalahan medis yang mungkin luput dari satu profesi dapat diintersepsi oleh profesi lain dalam tim.

5. Tantangan dalam Konteks Indonesia

Di Indonesia, implementasi IPC menghadapi tantangan kultural berupa budaya paternalistik yang masih kuat. Selain itu, sistem remunerasi dan regulasi administratif terkadang belum sepenuhnya mendukung praktik kolaboratif yang cair. Oleh karena itu, kebijakan Kemenkes RI kini mulai mengintegrasikan indikator kolaborasi interprofesional dalam standar akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan primer.

E. Simpulan

Implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM) dalam ranah akademik dan klinis merupakan upaya sistematis untuk menggeser praktik kebidanan dari model berbasis intuisi atau tradisi menuju asuhan yang tervalidasi secara ilmiah. Dalam pembelajaran teori, EBM menuntut integrasi kurikulum yang melatih mahasiswa tidak hanya untuk menghafal literatur, tetapi memiliki kemampuan critical

appraisal terhadap hasil riset terkini (seperti meta-analisis dan systematic review) guna menjawab fenomena klinis. Hal ini bertujuan untuk membentuk pola pikir kritis sejak dini agar mahasiswa mampu membedakan antara intervensi yang efektif, tidak berguna, atau bahkan berbahaya.

Sementara itu, dalam pembelajaran praktik, implementasi EBM diwujudkan melalui asuhan kebidanan yang berfokus pada keselamatan pasien (patient safety) dan penghormatan terhadap otonomi perempuan. Praktik berbasis bukti ini menjembatani celah antara pedoman klinis nasional dengan realitas di lapangan, di mana teknologi digital berperan sebagai akselerator dalam mengakses data real-time. Sinergi antara teori dan praktik dalam EBM memastikan bahwa setiap keputusan klinis didasarkan pada triangulasi antara bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis bidan, serta nilai dan preferensi pasien. Secara kolektif, penerapan EBM yang konsisten menjadi determinan utama dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) sekaligus meningkatkan profesionalisme bidan di tingkat global.

F. Referensi

-
- Asadzadeh, L., Jafari, E., Kharaghani, R., & Taremian, F. (2020). Effectiveness of midwife-led brief counseling intervention on post-traumatic stress disorder, depression, and anxiety symptoms of women experiencing a traumatic childbirth: A randomized controlled trial. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 1–9. doi: 10.1186/s12884-020-2826-1
- Elina Leiviska, et all. (2025). Teaching and interconnecting research and evidence-based practice in midwifery and nursing education: A mixed methods systematic review. *Nurse Educ Today*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.106701>
- Hunter, B., Thomas, G., Wilhelmová, R., Trendafilova, P., Blaževičienė, A., Lynch, L., & Jokinen, M. (2022). Strengthening global midwifery education to improve quality maternity care: Co-designing the World Health Organization Midwifery Assessment Tool for Education (MATE). *Nurse Education in Practice*, 63(April). doi: 10.1016/j.nepr.2022.103376
- Ige, W. B., & Ngcobo, W. B. (2024). A Model to Strengthen the Quality of Midwifery Education: A Grounded Theory Approach. *International Medical Education*, 3(4), 473–487. doi: 10.3390/ime3040036
- Janke, T. M., Makarova, N., Schmittinger, J., Agricola, C. J., Ebinghaus, M., Blome, C., & Zyriax, B. C. (2024). Women's needs and expectations in midwifery care – Results from the qualitative MiCa (midwifery care) study. Part 1: Preconception and pregnancy. *Heliyon*, 10(4), e25862. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25862
- Johnston, J., McKenna, L., Malik, G., & Reisenhofer, S. (2022). Reported outcomes

of nursing or midwifery students participating in international educational programs in their pre-registration education: A narrative systematic review. *Nurse Education Today*, 111(105320).

Kumar, A., Krishnamurthi, R., Bhatia, S., Kaushik, K., Ahuja, N. J., Nayyar, A., & Masud, M. (2021). Blended Learning Tools and Practices: A Comprehensive Analysis. *IEEE Access*, 9(June), 85151–85197. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3085844

Melita Peršolja. (2025). Teaching evidence-based practice to non-native english-speaking undergraduate nursing students: An integrative literature review. *Nurse Educ Pract*.

Menteri Kesehatan RI. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025*.

Moncrieff, G., MacVicar, S., Norris, G., & Martin, C. J. H. (2021). Optimising the continuity experiences of student midwives: an integrative review. *Women and Birth*, 34(1), 77–86.

Muraraneza, C., & Mtshali, G. N. (2021). Planning reform to competency based curricula in undergraduate nursing and midwifery education: A qualitative study. *Nurse Education Today*, 106(105066).

Smith, R. M., Gray, J. E., & Homer, C. S. E. (2023). Common content, delivery modes and outcome measures for faculty development programs in nursing and midwifery: A scoping review. *Nurse Education in Practice*, 70(April), 103648. doi: 10.1016/j.nepr.2023.103648

Tickle, M. N., Gamble, J., Creedy, D., & Carter, A. (2022). Clinical outcomes for women participating in continuity of care experiences with pre-registration midwifery students. *Women and Birth*, 35(13).

Tierney, O., Vasilevski, V., Kinsman, L., & Sweet, L. (2024). Development of the essential learning outcomes for the midwifery student continuity of care learning model: A Delphi study. *Women and Birth*, 37(3), 101582. doi: 10.1016/j.wombi.2024.01.008

CHAPTER 6

ETIKA PROFESI BIDAN DAN TANTANGAN PRAKTIK KEBIDANAN ERA DIGITAL

Hasnawati SST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Etika profesi bidan merupakan seperangkat nilai moral, prinsip, dan norma profesional yang menjadi pedoman perilaku bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada keselamatan serta hak klien. Etika ini mencakup prinsip otonomi, kerahasiaan, keadilan, tanggung jawab profesional, dan kompetensi, yang harus dijalankan dalam setiap bentuk praktik kebidanan, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dalam konteks perkembangan teknologi kesehatan, etika profesi bidan juga mencakup kemampuan menjaga kerahasiaan data, komunikasi profesional, serta pengambilan keputusan klinis yang tepat dalam sistem pelayanan berbasis digital (Ayu Hendrati Rahayu , Lusi Marlina 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik kebidanan di era digital menghadapi tantangan etis yang semakin kompleks. **Pertama**, penggunaan rekam medis elektronik dan layanan digital terbukti meningkatkan risiko pelanggaran kerahasiaan data pasien. Studi Oleh (Ayu Hendrati Rahayu , Lusi Marlina 2025) menunjukkan bahwa **lebih dari 45% bidan** belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip keamanan data digital dan perlindungan kerahasiaan pasien, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran etik dalam pendokumentasian elektronik. **Kedua**, pemanfaatan telehealth dan telekonsultasi kebidanan menimbulkan dilema etis terkait batas kewenangan profesional dan tanggung jawab hukum; tinjauan sistematis mengenai pengalaman bidan dalam telehealth melaporkan bahwa **sekitar 60–70% bidan** merasa ragu terhadap keakuratan penilaian klinis jarak jauh dan aspek tanggung jawab profesional dalam pelayanan daring (Inayati, Kebidanan, and Bogor 2025). **Ketiga**, maraknya penggunaan media sosial dan lingkungan informasi digital memengaruhi hubungan bidan–klien, di mana penelitian (Wilhelm et al. 2024) menemukan bahwa **lebih dari 50% tenaga kesehatan maternal**, termasuk bidan, pernah menghadapi konflik profesional akibat informasi kesehatan digital yang tidak tervalidasi, sementara (Carina and Elinor 2025b) menegaskan bahwa komunikasi

digital yang tidak terkontrol dapat mengaburkan batas profesionalisme dalam praktik kebidanan.

Permasalahan etika profesi bidan di era digital diduga terjadi karena ketidakseimbangan antara pesatnya perkembangan teknologi kesehatan dengan kesiapan kompetensi digital dan etika profesional bidan. Transformasi digital sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan pembaruan kurikulum pendidikan kebidanan, pedoman etika, serta regulasi praktik berbasis teknologi. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan terkait etika digital, keamanan data, dan komunikasi profesional daring menyebabkan bidan rentan menghadapi dilema etis dalam praktik sehari-hari (Janes et al. 2025).

Tantangan etika tersebut semakin diperkuat oleh tuntutan profesionalisme bidan sebagai pemberi layanan kesehatan primer yang harus adaptif terhadap inovasi digital tanpa mengabaikan nilai-nilai etik kebidanan. Penelitian menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan literasi digital dan pemahaman etika teknologi di kalangan bidan dan mahasiswa kebidanan, yang berpotensi menurunkan kualitas asuhan dan kepercayaan masyarakat (Wilhelm et al. 2024).

Oleh karena itu, kajian mengenai etika profesi bidan dan tantangan praktik kebidanan di era digital menjadi sangat penting untuk memperkuat landasan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melindungi keselamatan dan hak klien. Pemahaman yang komprehensif terhadap isu etika digital diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan, pendidikan, dan praktik kebidanan yang adaptif, beretika, dan berkelanjutan seiring dengan transformasi sistem kesehatan modern (Janes et al. 2025).

B. Etika Kerahasiaan dan Perlindungan Data Klien Dalam Praktik Kebidanan Era Digital

Etika kerahasiaan dalam praktik kebidanan merupakan kewajiban profesional bidan untuk melindungi seluruh informasi pribadi dan data kesehatan klien yang diperoleh selama proses asuhan kebidanan. Informasi tersebut meliputi identitas klien, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, diagnosis, serta data lain yang bersifat sensitif. Seiring dengan perkembangan teknologi kesehatan, konsep kerahasiaan tidak lagi terbatas pada pencatatan manual dan komunikasi tatap muka, tetapi juga mencakup pengelolaan rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, telekonsultasi, serta berbagai bentuk komunikasi digital yang digunakan dalam pelayanan kebidanan (Ayu Hendrati Rahayu , Lusi Marlina 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerahasiaan menjadi salah satu prinsip fundamental dalam etika profesi bidan yang bertujuan menjaga hak privasi dan martabat klien. Prinsip ini menekankan bahwa setiap informasi yang diperoleh

bidan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan klien, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Dalam konteks praktik kebidanan digital, prinsip kerahasiaan juga menuntut bidan untuk bersikap profesional dalam penggunaan teknologi, memahami batasan komunikasi daring, serta memastikan bahwa pemanfaatan sistem digital tidak mengurangi kepercayaan klien terhadap pelayanan kebidanan (Carina and Elinor 2025).

Namun demikian, penerapan prinsip kerahasiaan dalam praktik kebidanan digital tidak terlepas dari berbagai risiko, terutama kebocoran dan penyalahgunaan data klien. Penggunaan rekam medis elektronik, telehealth, dan media digital meningkatkan potensi akses tidak sah terhadap informasi kesehatan, khususnya apabila bidan memiliki keterbatasan literasi keamanan digital atau menggunakan perangkat tanpa sistem perlindungan yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman bidan terhadap keamanan data digital menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran kerahasiaan pasien. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan berupa penerapan sistem keamanan data, pembatasan akses informasi sesuai kewenangan, penggunaan enkripsi, serta penyusunan standar operasional prosedur yang jelas dalam pengelolaan data kebidanan berbasis digital (Ayu Hendrati Rahayu , Lusi Marlina 2025; Janes et al. 2025)

Sebagai tindak lanjut dari berbagai risiko tersebut, bidan memiliki peran strategis dalam menjaga kerahasiaan klien di era digital melalui peningkatan kompetensi etika dan literasi digital secara berkelanjutan, oleh karena itu bidan diuntut untuk:

1. Memahami regulasi dan kode etik profesi

Pemahaman terhadap regulasi dan kode etik profesi merupakan landasan utama bagi bidan dalam menjaga kerahasiaan pasien. Bidan wajib mengetahui ketentuan hukum, standar profesi, serta kode etik kebidanan yang mengatur perlindungan data dan hak privasi klien. Dengan memahami regulasi tersebut, bidan dapat menentukan batasan yang jelas mengenai informasi apa saja yang boleh diakses, digunakan, dan dibagikan dalam praktik kebidanan, khususnya pada layanan berbasis digital. Pengetahuan ini juga membantu bidan menghindari pelanggaran etik dan konsekuensi hukum yang dapat merugikan klien maupun profesi.

2. Memahami implikasi etis penggunaan teknologi dalam pelayanan kebidanan

Pemanfaatan teknologi digital dalam kebidanan, seperti rekam medis elektronik dan telekonsultasi, memiliki implikasi etis yang kompleks. Bidan perlu

menyadari bahwa setiap penggunaan teknologi berpotensi menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan data pasien, termasuk akses tidak sah dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, bidan harus mampu mempertimbangkan aspek etika dalam setiap keputusan penggunaan teknologi, memastikan bahwa teknologi digunakan semata-mata untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak mengabaikan hak privasi klien.

3. Bersikap bijak dalam penggunaan media sosial

Media sosial menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga profesionalisme dan kerahasiaan pasien. Bidan dituntut untuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial dengan memisahkan kehidupan pribadi dan profesional. Setiap bentuk unggahan, komentar, atau diskusi yang berkaitan dengan pengalaman praktik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyinggung identitas atau kondisi klien. Sikap bijak ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan serta mencegah terjadinya pelanggaran etika akibat penggunaan media digital yang tidak terkontrol.

4. Menghindari pembagian informasi klien dalam bentuk apa pun

Bidan memiliki kewajiban mutlak untuk tidak membagikan informasi klien, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam bentuk teks, gambar, rekaman suara, atau cerita kasus, meskipun tanpa mencantumkan identitas klien. Informasi kesehatan tetap bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan tanpa dasar hukum atau persetujuan klien. Dengan menghindari pembagian informasi klien, bidan berperan aktif dalam melindungi privasi, martabat, dan keamanan pasien dalam pelayanan kebidanan.

5. Memastikan adanya informed consent pada setiap layanan kebidanan berbasis digital

Informed consent merupakan bentuk penghormatan terhadap hak otonomi klien dan menjadi bagian penting dalam menjaga kerahasiaan pasien. Dalam layanan kebidanan berbasis digital, bidan harus memastikan bahwa klien memahami tujuan layanan, prosedur yang dilakukan, risiko yang mungkin timbul, serta bagaimana data pribadi mereka akan dikelola dan dilindungi. Persetujuan yang diberikan secara sadar dan jelas menunjukkan bahwa bidan telah menjalankan tanggung jawab etisnya dalam memberikan pelayanan yang transparan, aman, dan berorientasi pada perlindungan hak klien.

Dengan mengintegrasikan nilai etika profesi ke dalam praktik digital sehari-hari, bidan dapat memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan perlindungan hak dan kerahasiaan klien (Wilhelm et al. 2024).

C. Dilema Etis dan Tanggung Jawab Profesional Bidan Dalam *Telehealth* dan Telekonsultasi

1. Konteks Media Sosial Dalam Praktik Kebidanan

Perkembangan media sosial dan lingkungan informasi digital telah mengubah cara bidan berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi dengan klien (Golden et al. 2024). Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi pribadi, tetapi juga sebagai media edukasi kesehatan, promosi layanan, dan berbagi informasi kebidanan. Namun, dalam konteks profesional, penggunaan media sosial oleh bidan menuntut kehati-hatian karena setiap aktivitas digital berpotensi memengaruhi citra profesi, hubungan bidan–klien, serta perlindungan kerahasiaan data pasien (Carina and Elinor 2025; Wilhelm et al. 2024). Berdasarkan konteks tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu:

a. Media sosial sebagai sarana edukasi kesehatan kebidanan

Media sosial memiliki potensi besar sebagai media edukasi kesehatan karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. Bidan dapat memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, kehamilan, persalinan, serta perawatan nifas. Namun, penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi harus dilakukan secara profesional, berbasis bukti ilmiah, dan tidak melanggar etika profesi, khususnya terkait penyampaian informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.

b. Dampak penggunaan media sosial terhadap hubungan bidan–klien

Interaksi bidan dan klien melalui media sosial dapat memperlambat komunikasi, tetapi juga berpotensi mengaburkan batas hubungan profesional. Komunikasi yang terlalu personal, respons di luar jam pelayanan, atau keterlibatan emosional yang berlebihan dapat menimbulkan dilema etis. Oleh karena itu, perlu adanya batasan yang jelas dalam interaksi digital agar hubungan bidan–klien tetap profesional dan berorientasi pada pelayanan kesehatan.

c. Risiko etika dan kerahasiaan data dalam aktivitas digital bidan

Setiap aktivitas bidan di media sosial membawa risiko terhadap kerahasiaan data pasien dan citra profesi. Unggahan kasus, pengalaman praktik, atau diskusi daring yang tidak disaring dengan baik dapat berpotensi mengungkapkan informasi sensitif klien, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menuntut bidan untuk selalu mempertimbangkan aspek etika dan kerahasiaan sebelum melakukan aktivitas apa pun di ruang digital.

2. Tantangan Etis dalam Penyebaran Informasi Digital

Salah satu tantangan utama dalam penggunaan media sosial adalah maraknya penyebaran informasi kesehatan yang tidak tervalidasi atau tidak berbasis bukti ilmiah. Lingkungan informasi digital memungkinkan setiap individu untuk memproduksi dan menyebarkan konten kesehatan secara cepat tanpa melalui proses validasi ilmiah, sehingga klien sering kali memperoleh informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini dapat menimbulkan tekanan profesional bagi bidan ketika klien datang dengan pemahaman yang keliru mengenai kondisi kesehatan, pilihan tindakan, atau metode perawatan tertentu, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik profesional dan kesalahpahaman dalam proses asuhan kebidanan (Wilhelm et al. 2024).

Selain menimbulkan tekanan dalam pengambilan keputusan klinis, paparan informasi digital yang tidak kredibel juga dapat melemahkan kepercayaan klien terhadap tenaga kesehatan apabila informasi dari media sosial dianggap lebih benar dibandingkan rekomendasi profesional bidan. Dalam situasi ini, bidan dihadapkan pada dilema etis antara menghormati otonomi klien dan tetap memberikan asuhan yang aman serta berbasis bukti. Ketidakseimbangan informasi ini dapat memengaruhi kualitas hubungan terapeutik bidan–klien dan berpotensi mengganggu keberhasilan asuhan kebidanan.

Di sisi lain, keterlibatan bidan dalam diskusi daring tanpa batasan profesional turut memperbesar risiko pelanggaran etika. Respons spontan, opini pribadi, atau pembahasan kasus di ruang digital dapat menimbulkan salah tafsir dan berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan serta profesionalisme. Oleh karena itu, bidan dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital dan etika komunikasi daring yang memadai, sehingga mampu menyaring informasi, menjaga batas profesional, serta memastikan bahwa setiap aktivitas digital tetap selaras dengan nilai-nilai etika profesi kebidanan (Wilhelm et al. 2024).

3. Peran Bidan Dalam Menjaga Profesionalisme di Era Informasi Digital

Dalam menghadapi tantangan tersebut, bidan dituntut untuk menjaga profesionalisme dengan menerapkan prinsip etika dalam setiap aktivitas digital. Bidan perlu menyaring informasi sebelum dibagikan, memastikan bahwa konten edukasi yang disampaikan bersumber dari referensi ilmiah yang valid, serta menghindari keterlibatan dalam diskusi daring yang berpotensi melanggar etika. Selain itu, penguatan literasi digital dan etika penggunaan media sosial menjadi bagian penting dari kompetensi profesional bidan agar teknologi

informasi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan kepercayaan publik (Janes et al. 2025).

D. Media Sosial, Informasi Digital, dan Profesionalisme Bidan

Perkembangan teknologi digital telah membawa peluang sekaligus tantangan etis yang memerlukan perhatian khusus dari bidan sebagai tenaga kesehatan profesional. Adapun beberapa aspek penting yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran Informasi Kesehatan yang Tidak Tervalidasi

Media sosial memungkinkan penyebaran informasi kesehatan secara cepat dan luas tanpa melalui proses verifikasi ilmiah. Kondisi ini menyebabkan klien sering menerima informasi yang tidak berbasis bukti, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terkait kondisi kesehatan ibu dan anak. Penelitian menunjukkan bahwa paparan informasi digital yang tidak kredibel dapat memengaruhi persepsi klien terhadap asuhan kebidanan dan menimbulkan tekanan profesional bagi bidan dalam meluruskan informasi tersebut (Wilhelm et al. 2024).

2. Dampak terhadap Hubungan Bidan–Klien

Interaksi bidan dan klien melalui media sosial dapat mempererat komunikasi, namun juga berisiko mengaburkan batas hubungan profesional. Komunikasi yang terlalu personal, respons di luar konteks pelayanan, atau keterlibatan emosional yang berlebihan dapat menimbulkan dilema etis dan memengaruhi objektivitas bidan dalam memberikan asuhan. Oleh karena itu, batasan komunikasi yang jelas menjadi penting untuk menjaga hubungan terapeutik yang profesional (Carina and Elinor 2025).

3. Konflik Profesionalisme dalam Ruang Digital

Lingkungan informasi digital dapat memicu konflik profesionalisme ketika bidan terlibat dalam diskusi daring yang bersifat opini pribadi atau kontroversial. Unggahan atau komentar yang tidak mencerminkan sikap profesional berpotensi merusak citra profesi bidan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Jurnal-jurnal kebidanan menekankan bahwa profesionalisme bidan tidak hanya dinilai dari praktik klinis, tetapi juga dari perilaku dan etika komunikasi di ruang digital (Getu et al. 2025).

4. Batasan Komunikasi Personal dan Profesional

Media sosial sering kali mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan peran profesional bidan. Penerimaan pertemanan dari klien, percakapan informal, atau berbagi pengalaman praktik di media sosial tanpa pertimbangan etis dapat berisiko melanggar prinsip profesionalisme. Oleh karena itu, bidan

perlu menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi digital untuk melindungi diri, klien, dan profesi (Carina and Elinor 2025)

5. Risiko Pelanggaran Etika akibat Konten Digital

Setiap konten digital yang dibagikan oleh bidan, baik berupa teks, gambar, maupun video, berpotensi menimbulkan pelanggaran etika jika tidak dikelola dengan baik. Pengunggahan pengalaman praktik, studi kasus, atau testimoni klien tanpa persetujuan dapat melanggar prinsip kerahasiaan dan hak privasi pasien. Penelitian menegaskan bahwa penguatan literasi digital dan etika penggunaan media sosial menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran etika di era digital (Janes et al. 2025).

Kesiapan kompetensi etika digital dalam kebidanan menjadi faktor penting dalam menjamin bahwa pemanfaatan teknologi kesehatan tidak mengabaikan nilai-nilai profesional dan keselamatan klien. Perkembangan pesat teknologi kesehatan, seperti rekam medis elektronik, telehealth, kecerdasan buatan (AI), dan media digital, menuntut bidan untuk memiliki kemampuan tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara etis. Namun, berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi tersebut dengan kesiapan kompetensi etika digital bidan, baik pada level pendidikan maupun praktik profesional (Janes et al. 2025).

a. Literasi Digital sebagai Dasar Kompetensi Etika Digital

Literasi digital merupakan kemampuan dasar bidan dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam konteks kebidanan, literasi digital mencakup pemahaman terhadap sistem informasi kesehatan, keamanan data, serta penggunaan media digital untuk edukasi dan komunikasi dengan klien. Jurnal pendidikan kebidanan menegaskan bahwa rendahnya literasi digital dapat meningkatkan risiko pelanggaran etika, terutama terkait kerahasiaan data dan penyebaran informasi kesehatan yang tidak tervalidasi (Rabbani and Alam 2025).

b. Pemahaman Etika Penggunaan Teknologi Kesehatan (AI dan Sistem Digital)

Penggunaan teknologi kesehatan berbasis digital dan AI dalam pelayanan kebidanan membawa implikasi etis yang kompleks. Bidan perlu memahami bahwa teknologi bersifat sebagai alat bantu, bukan pengganti pengambilan keputusan profesional. Kurangnya pemahaman etika penggunaan teknologi dapat menyebabkan ketergantungan berlebihan pada sistem digital, bias algoritma, serta pengabaian aspek kemanusiaan dalam asuhan kebidanan. Oleh karena itu, pemahaman etika digital menjadi

kompetensi penting agar bidan tetap mampu memberikan asuhan yang aman, manusiawi, dan berpusat pada klien (Astuti et al. 2023).

c. Kesiapan Pendidikan Kebidanan dalam Mengintegrasikan Etika Digital

Pendidikan kebidanan memiliki peran strategis dalam membentuk kompetensi etika digital sejak dini. Namun, sejumlah jurnal menunjukkan bahwa kurikulum kebidanan di berbagai institusi belum sepenuhnya mengintegrasikan materi etika digital dan literasi teknologi secara sistematis. Etika profesi masih sering diajarkan secara konvensional tanpa dikaitkan dengan tantangan praktik kebidanan berbasis digital. Kondisi ini menyebabkan lulusan bidan kurang siap menghadapi dilema etis yang muncul dalam praktik kebidanan modern (Janes et al. 2025) (Janes et al., 2025).

d. Tantangan Implementasi Etika Digital dalam Praktik Profesional

Dalam praktik profesional, bidan sering kali dihadapkan pada situasi yang menuntut penerapan etika digital secara langsung, seperti penggunaan telekonsultasi, pengelolaan data elektronik, dan komunikasi melalui media sosial. Tantangan utama yang muncul adalah keterbatasan pelatihan berkelanjutan, kurangnya pedoman operasional etika digital, serta perbedaan tingkat kesiapan teknologi antar fasilitas kesehatan. Jurnal-jurnal kebidanan menekankan bahwa tanpa dukungan sistem dan kebijakan yang memadai, bidan berisiko menghadapi dilema etis yang berulang dalam praktik sehari-hari (Carina and Elinor 2025).

e. Perlunya Pelatihan Berkelanjutan dan Penguatan Kebijakan Institusi

Untuk meningkatkan kesiapan kompetensi etika digital, diperlukan pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada literasi digital, keamanan data, etika penggunaan teknologi, dan komunikasi profesional daring. Selain itu, institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu menyusun kebijakan serta standar operasional prosedur yang jelas terkait praktik kebidanan digital. Integrasi etika digital dalam pendidikan dan praktik profesional diharapkan mampu memperkuat profesionalisme bidan serta menjaga kualitas dan keamanan asuhan kebidanan di era digital (Fitria and Rusdi 2025; Livesay et al. 2024).

E. Simpulan

Perkembangan teknologi kesehatan dan lingkungan informasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kebidanan, baik dari segi pelayanan klinis, komunikasi bidan kepada klien, maupun pengelolaan data kesehatan. Kondisi ini menuntut bidan untuk tidak hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi

juga pemahaman yang kuat terhadap etika profesi, khususnya dalam menjaga kerahasiaan data klien, profesionalisme, dan pengambilan keputusan etis dalam praktik kebidanan berbasis digital. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pesatnya transformasi digital dengan kesiapan kompetensi etika digital bidan, baik pada level pendidikan maupun praktik profesional. Keterbatasan literasi digital, pemahaman etika penggunaan teknologi, serta belum optimalnya integrasi etika digital dalam kurikulum dan kebijakan praktik berpotensi menimbulkan dilema etis dan menurunkan kualitas asuhan kebidanan. Oleh karena itu, penguatan etika profesi bidan di era digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keselamatan klien, martabat profesi, dan kepercayaan masyarakat. Untuk itu kami memberikan rekomendasi: 1) Institusi pendidikan kebidanan perlu mengintegrasikan etika digital dan literasi teknologi secara sistematis dalam kurikulum pembelajaran, 2) Bidan diharapkan meningkatkan kompetensi etika digital melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan prinsip etika dalam setiap praktik berbasis teknologi.

F. Referensi

-
- Astuti, Ari, Prapaporn Langputeh, Dwi Sulisworo, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, and Universitas Ahmad Dahlan. 2023. "Telemedicine and Digital Health in the Future of Midwifery Care." 2(03):141–53. doi: 10.56741/bikk.v2i03.438.
- Ayu Hendrati Rahayu , Lusi Marlina, Rochmawati. 2025. "Midwives Readiness Factors in Maintaining Patient Confidentiality in the Digital Medical Record Era." 10(3). doi: <https://doi.org/10.22146/jkesvo.108116>.
- Carina, Lindgren, and Ludvigsson Elinor. 2025a. "Digital Midwifery Care – Blurring Boundaries and Finding New Paths for Midwifery Care during Pregnancy and Postpartum: A Qualitative Study on Swedish Midwives' Experiences." 46(July). doi: 10.1016/j.srhc.2025.101147.
- Carina, Lindgren, and Ludvigsson Elinor. 2025b. "Sexual & Reproductive Healthcare Digital Midwifery Care – Blurring Boundaries and Finding New Paths for Midwifery Care during Pregnancy and Postpartum : A Qualitative Study on Swedish Midwives ' Experiences " Ckstr o." 46(September). doi: 10.1016/j.srhc.2025.101147.
- Fitria, Henni, and Annisa Rusdi. 2025. "Framing the Midwifery Profession in The Digital Era: The Impact of Social Media on Midwifery Students." *Jurnal Kesehatan* 2:123–30. doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.35730/jk.v16i2.1327> Fitria,.
- Getu, Tadesse, Ayenew Tega, Getie Mihret Aragaw, Misgana Desalegn Menesho, and Robel Demelash. 2025. "Ethical Dilemmas Experienced by Midwives in Their Professional Practice in Northwestern Ethiopia : A Phenomenological Interview Study." doi: <https://doi.org/10.1186/s12910-025-01266-6>.

- Golden, Bethany N., Shaimaa Elrefaay, Monica R. Mclemore, Amy Alspaugh, Kimberly Baltzell, and Linda S. Franck. 2024. "Midwives ' Experience of Telehealth and Remote Care : A Systematic Mixed Methods Review." doi: 10.1136/bmjopen-2023-082060.
- Inayati, Inna Noor, Prodi Kebidanan, and Universitas Ummi Bogor. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Bidan Dalam Telekonsultasi Kebidanan Dalam Perspektif Peraturan Per-Undang-Undangan Dan Etika Profesi Latar Belakang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisine Antar Fasilitas Untuk Telemedisin , Meskipun Fokus." (24):1–12. doi: DOI: <https://doi.org/10.61132/prosemmasikk.v2i1.58> Available.
- Janes, Gillian, Lorna Chesterton, Vanessa Heaslip, Joanne Reid, Bente Lüdemann, João Gentil, André Oxholm, Clayton Hamilton, Natasha Phillips, and Michael Shannon. 2025. "Current Nursing and Midwifery Contribution to Leading Digital Health Policy and Practice : An Integrative Review ." (May 2024):116–39. doi: 10.1111/jan.16265.
- Livesay, Karen, Ruby Walter, Sacha Petersen, Robab Abdolkhani, and Lin Zhao. 2024. "Challenges and Needs in Digital Health Practice and Nursing Education Curricula : Gap Analysis Study." 10:1–10. doi: 10.2196/54105.
- Rabbani, Golam, and Ashrafe Alam. 2025. "Digital Health Transformation Through Telemedicine (2020 – 2025): Barriers , Facilitators , and Clinical Outcomes — A Systematic Review and Meta-Analysis." 1–23. doi: <https://doi.org/10.3390/encyclopedia5040206>.
- Wilhelm, Elisabeth, Victoria Vivilaki, Jean Calleja-agius, Elena Petelos, Paraskevi Giaksi, Elena Triantafyllou, Eleni Asimaki, Faye Alevizou, and D. Tina. 2024. "Effects of the Modern Digital Information Environment on Maternal Healthcare Professionals , the Role of Midwives and the People in Their Care : A Scoping Review Table of Contents."
- Astuti, Ari, Prapaporn Langputeh, Dwi Sulisworo, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, and Universitas Ahmad Dahlan. 2023. "Telemedicine and Digital Health in the Future of Midwifery Care." 2(03):141–53. doi: 10.56741/bikk.v2i03.438.
- Ayu Hendrati Rahayu , Lusi Marlina, Rochmawati. 2025. "Midwives Readiness Factors in Maintaining Patient Confidentiality in the Digital Medical Record Era." 10(3). doi: <https://doi.org/10.22146/jkesvo.108116>.
- Carina, Lindgren, and Ludvigsson Elinor. 2025a. "Digital Midwifery Care – Blurring Boundaries and Finding New Paths for Midwifery Care during Pregnancy and Postpartum: A Qualitative Study on Swedish Midwives' Experiences." 46(July). doi: 10.1016/j.srhc.2025.101147.
- Carina, Lindgren, and Ludvigsson Elinor. 2025b. "Sexual & Reproductive Healthcare Digital Midwifery Care – Blurring Boundaries and Finding New Paths for Midwifery Care during Pregnancy and Postpartum : A Qualitative Study on

- Swedish Midwives ' Experiences " Ckstr o." 46(September). doi: 10.1016/j.srhc.2025.101147.
- Fitria, Henni, and Annisa Rusdi. 2025. "Framing the Midwifery Profession in The Digital Era: The Impact of Social Media on Midwifery Students." *Jurnal Kesehatan* 2:123–30. doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.35730/jk.v16i2.1327> Fitria,.
- Getu, Tadesse, Ayenew Tega, Getie Mihret Aragaw, Misgana Desalegn Meneshe, and Robel Demelash. 2025. "Ethical Dilemmas Experienced by Midwives in Their Professional Practice in Northwestern Ethiopia : A Phenomenological Interview Study." doi: <https://doi.org/10.1186/s12910-025-01266-6>.
- Golden, Bethany N., Shaimaa Elrefaay, Monica R. Mclemore, Amy Alspaugh, Kimberly Baltzell, and Linda S. Franck. 2024. "Midwives ' Experience of Telehealth and Remote Care : A Systematic Mixed Methods Review." doi: 10.1136/bmjopen-2023-082060.
- Inayati, Inna Noor, Prodi Kebidanan, and Universitas Ummi Bogor. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Bidan Dalam Telekonsultasi Kebidanan Dalam Perspektif Peraturan Per-Undang-Undangan Dan Etika Profesi Latar Belakang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisine Antar Fasilitas Untuk Telemedisin , Meskipun Fokus." (24):1–12. doi: DOI: <https://doi.org/10.61132/prosemnasikk.v2i1.58> Available.
- Janes, Gillian, Lorna Chesterton, Vanessa Heaslip, Joanne Reid, Bente Lüdemann, João Gentil, André Oxholm, Clayton Hamilton, Natasha Phillips, and Michael Shannon. 2025. "Current Nursing and Midwifery Contribution to Leading Digital Health Policy and Practice : An Integrative Review ." (May 2024):116–39. doi: 10.1111/jan.16265.
- Livesay, Karen, Ruby Walter, Sacha Petersen, Robab Abdolkhani, and Lin Zhao. 2024. "Challenges and Needs in Digital Health Practice and Nursing Education Curricula : Gap Analysis Study." 10:1–10. doi: 10.2196/54105.
- Rabbani, Golam, and Ashrafe Alam. 2025. "Digital Health Transformation Through Telemedicine (2020 – 2025): Barriers , Facilitators , and Clinical Outcomes — A Systematic Review and Meta-Analysis." 1–23. doi: <https://doi.org/10.3390/encyclopedia5040206>.
- Wilhelm, Elisabeth, Victoria Vivilaki, Jean Calleja-agius, Elena Petelos, Paraskevi Giaksi, Elena Triantafyllou, Eleni Asimaki, Faye Alevizou, and D. Tina. 2024. "Effects of the Modern Digital Information Environment on Maternal Healthcare Professionals , the Role of Midwives and the People in Their Care : A Scoping Review Table of Contents."

G. Glosarium

Informed Consent = Persetujuan yang diberikan klien setelah memperoleh penjelasan lengkap mengenai pelayanan kebidanan, termasuk penggunaan teknologi dan pengelolaan data pribadi.

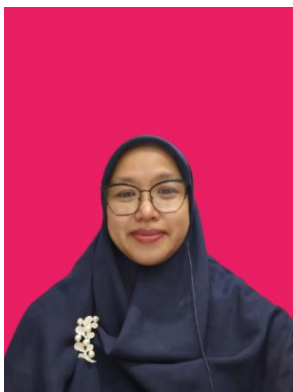
Literasi Digital = Kemampuan bidan dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi digital secara kritis dan bertanggung jawab dalam praktik kebidanan.

Telehealth = Pelayanan kesehatan kebidanan yang diberikan dari jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

PROFIL PENULIS



Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb Lahir di Kotamobagu, 16 Februari 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Sekolah Pascasarjana pada Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 di Akademi Kebidanan Bunda Kotamobagu yang saat ini telah berkembang menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Jainuddin Kotamobagu. Pada tahun 2024 penulis terangkat sebagai ASN di Poltekkes Kemenkes Manado dan telah mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi, Obstetri dan Ginekologi, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, Praktik Klinik Kebidanan, Keterampilan Dasar Kebidanan dan mata kuliah kebidanan lainnya. Penulis aktif sebagai dewan direksi Jurnal Ilmiah Bidan (JIDAN) Poltekkes Kemenkes Manado dan aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengajaran, serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: deivitayan@gmail.com
Motto: "Tumbuh dalam diam, mekar pada waktunya"



Giari Rahmilasari, S.ST., M.Keb., Bdn Lahir di Jakarta, 15 Agustus 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan, Poltekkes Jakarta III lulus pada tahun 2022, D4 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Padjadjaran lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 – 2003 di TPMB Jakarta, tahun 2004 - 2008 di Rumah Bersalin Cuma-Cuma, tahun 2007 mengajar kebidanan di beberapa perguruan tinggi, dan menjadi dosen tetap di Universitas Aisyiyah Bandung sejak 2011. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyiyah Bandung mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas, Dokumentasi Kebidanan, dan Psikologi Perkembangan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan menjadi pembicara di beberapa pelatihan diantaranya pelatihan konselor ASI, dll. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: giarirahmilasari@unisa-bandung.ac.id
Motto: "Live it, Be Grateful"

PROFIL PENULIS



Bdn. Nurul Komariah, SST., S.Stat., M.Keb. Lahir di Palembang, 30 September 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan pada Poltekkes Kemenkes Bandung Tahun 2026, S1 Statistika Universitas Terbuka tahun 2023. Pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjajaran Bandung dan lulus tahun pada tahun 2013. Saat Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nknurulkomariah@gmail.com



Dr.Yeni Fitrianingsih,SST,MKes Lahir di Kuningan, 12 Desember 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV pada Program Studi DIV Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan S3 Doktor Ilmu Kedokteran Kesehatan pada Universitas Dipenogoro lulus tahun 2022 . Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1988 menjadi Perawat di RS Pelabuhan, kemudian Tahun 1990 menjadi Bidan Puskesmas Nyalindung Sukabumi, selanjutnya menjadi bidan di beberapa Puskesmas Kota Cirebon hingga tahun 2010. Saat ini penulis bekerja menjadi dosen di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon . Beberapa pengalaman diantaranya menjadi Reviewer nasional versi Simlitabkes, menjadi Ketua IBI Kota Cirebon Periode 2018-2023 dan menjadi Ketua Program Studi STR Kebidanan Cirebon, mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatal, Bayi, Balita dan Pra Sekolah, Soft Skill, Kewirausahaan, Biokimia, nulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Menjadi Narasumber Seminar Nasional dan Internasional. . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yfitrianingsih44@gmail.com
Motto: "Knowledge from Practice, Excellence for Humanity."

PROFIL PENULIS



Hasnawati S.ST.,M.Kes Lahir di Palu, 19 Mei 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang SPK Donggala Tahun 1988, pendidikan Bidan A SPK Labuang Baji di Makassar Tahun 1991, pendidikan D-III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Palu dan lulus pada Tahun 2005, pendidikan Sarjana Terapan di Poltekkes Kemenkes Palu dan lulus pada Tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia Timur di Makassar dan selesai pada Tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun

1989 sampai dengan tahun 2020 mengabdikan di RSUD Anutapura, setelah itu pada tahun 2021 pindah tugas di kementerian kesehatan untuk penempatan di Poltekkes Kemenkes Palu. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Palu. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dll. Penulis dapat dihubungi melalui

e-mail: watihhasna69@gmail.com

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Pendidikan Kebidanan Berbasis Kontinuitas Asuhan: Kurikulum, Praktik Klinik, dan Kompetensi Bidan Masa Kini menyajikan gagasan dan praktik pembelajaran kebidanan yang berorientasi pada mutu, keselamatan, dan kebutuhan perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Dengan menempatkan continuity of care sebagai benang merah, buku ini menegaskan pentingnya pendidikan kebidanan yang tidak hanya menekankan keterampilan klinis, tetapi juga membentuk bidan yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi efektif, berpegang pada bukti ilmiah, serta menjunjung etika profesi di tengah perubahan layanan dan kemajuan teknologi.

Pembahasan diawali pada Chapter 1 mengenai transformasi kurikulum D3–D4–Profesi Bidan berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan Standar Kompetensi Nasional Bidan, termasuk pemetaan standar kompetensi terhadap capaian pembelajaran lulusan serta implementasi pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya, Chapter 2 menguraikan model Continuity of Care (CoC) dalam pendidikan kebidanan dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi sebagai kerangka pembelajaran klinik yang terstruktur. Chapter 3 memperkuat kesiapan keterampilan klinis melalui pendekatan simulasi—OSCE, high-fidelity simulation, dan standardized patient—beserta integrasi ke kurikulum, evaluasi pembelajaran, serta aspek etika dan keselamatan.

Pada bagian lanjutan, buku ini menitikberatkan penguatan kompetensi profesional bidan. Chapter 4 membahas komunikasi terapeutik dan shared decision making sebagai inti asuhan berpusat pada klien dan penghormatan terhadap otonomi perempuan. Chapter 5 mengulas implementasi evidence-based midwifery dalam pembelajaran teori dan praktik, termasuk refleksi berbasis teknologi digital serta sinergi interprofessional collaboration untuk meningkatkan kualitas layanan. Sebagai penutup, Chapter 6 menyoroti etika profesi bidan dan tantangan praktik di era digital, seperti kerahasiaan dan perlindungan data, telehealth, serta profesionalisme di media sosial. Buku ini ditujukan bagi dosen, mahasiswa, preceptor klinik, dan praktisi sebagai rujukan aplikatif dalam memperkuat kurikulum, pembelajaran klinik, dan kompetensi bidan masa kini.

Buku Bunga Rampai Pendidikan Kebidanan Berbasis Kontinuitas Asuhan: Kurikulum, Praktik Klinik, dan Kompetensi Bidan Masa Kini menyajikan gagasan dan praktik pembelajaran kebidanan yang berorientasi pada mutu, keselamatan, dan kebutuhan perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Dengan menempatkan continuity of care sebagai benang merah, buku ini menegaskan pentingnya pendidikan kebidanan yang tidak hanya menekankan keterampilan klinis, tetapi juga membentuk bidan yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi efektif, berpegang pada bukti ilmiah, serta menjunjung etika profesi di tengah perubahan layanan dan kemajuan teknologi. Pembahasan diawali pada Chapter 1 mengenai transformasi kurikulum D3–D4–Profesi Bidan berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan Standar Kompetensi Nasional Bidan, termasuk pemetaan standar kompetensi terhadap capaian pembelajaran lulusan serta implementasi pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya, Chapter 2 menguraikan model Continuity of Care (CoC) dalam pendidikan kebidanan dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi sebagai kerangka pembelajaran klinik yang terstruktur. Chapter 3 memperkuat kesiapan keterampilan klinis melalui pendekatan simulasi—OSCE, high-fidelity simulation, dan standardized patient—beserta integrasi ke kurikulum, evaluasi pembelajaran, serta aspek etika dan keselamatan. Pada bagian lanjutan, buku ini menitikberatkan penguatan kompetensi profesional bidan. Chapter 4 membahas komunikasi terapeutik dan shared decision making sebagai inti asuhan berpusat pada klien dan penghormatan terhadap otonomi perempuan. Chapter 5 mengulas implementasi evidence-based midwifery dalam pembelajaran teori dan praktik, termasuk refleksi berbasis teknologi digital serta sinergi interprofessional collaboration untuk meningkatkan kualitas layanan. Sebagai penutup, Chapter 6 menyoroti etika profesi bidan dan tantangan praktik di era digital, seperti kerahasiaan dan perlindungan data, telehealth, serta profesionalisme di media sosial. Buku ini ditujukan bagi dosen, mahasiswa, preceptor klinik, dan praktisi sebagai rujukan aplikatif dalam memperkuat kurikulum, pembelajaran klinik, dan kompetensi bidan masa kini.

ISBN 978-634-7556-63-9



9

786347

556639

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

